

Quiz

Случайные по 50

Экзамен

[Консультация \(примеры и разборы вопросов\) – 138 стр. ↓](#)

1. Пациент Д., 20 лет доставлен в клинику после автодорожной катастрофы. Жалобы на боли, припухлость в области подглазничных и щечных областей с обеих сторон, головные боли, слабость. При осмотре: асимметрия лица за счет отека окологлазничных клетчаток, подглазничной и щечной областей с обеих сторон. Имеется кровоизлияние в конъюнктиву обеих глаз, глазная щель сужена. Средний отдел верхней челюсти удлиннен. Пальпация болезненна по нижнему краю глазницы. Открывание рта ограничено до 1,5 см. При пальпации передней части альвеолярного отростка отмечается подвижность средней зоны лица. Поставьте предварительный диагноз:

***перелом верхней челюсти по Ле-Фор-II**

- перелом верхней челюсти по Ле-Фор-I
- перелом скуловой кости справа
- перелом передней стенки верхнечелюстного синуса
- перелом верхней челюсти по Ле-Фор-III

2. В клинику обратился пациент И., 18 лет с жалобами на боли и выделение гноя из свища в подчелюстной области слева. 1,5 месяца назад находился на стационарном лечении с диагнозом: перелом тела нижней челюсти по 3.6 зубу. При осмотре: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти слева. В подчелюстной области имеется свищевой ход с выходящими грануляциями и гнойным экссудатом. Открывание рта ограничено до 3,0 см. Лунка 3.6 зуба заполнена грануляциями. На рентгенограмме: в области тела нижней челюсти в проекции лунки 3.6 зуба имеются мелкие секвестры. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

***хронический постравматический остеомиелит, секвестрэктомия**

- острый постравматический остеомиелит, периостотомия
- фиброзная дисплазия, мукогингивопластика
- нагноившаяся радикулярная киста, цистэктомия
- острый гнойный периостит, остеоперфорация

3. В клинику обратился пациент Р., 38 лет с жалобами на боли и припухлость в области нижней челюсти справа, слабость, повышение температуры тела до 38,0°. Из анамнеза: болеет в течение 3 суток, 2 суток назад в поликлинике удален 4.6 зуб. Объективно: общее состояние средней тяжести. Асимметрия лица за счет отека подчелюстной и щечной области справа. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены. Открывание рта болезненное. Лунка 4.6 зуба заполнена гнойным экссудатом. Слизистая десны на уровне 4.5, 4.6, 4.7 гиперемирована, отечна. Имеется подвижность 4.5, 4.6, 4.7 зубов. Снижена чувствительность нижней губы и подбородка. На рентгенограмме: имеется очаг просветления в области лунки 4.6 зуба диаметром 0,5х0,4 см. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

***острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти, остеоперфорация**

- хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти, периостотомия
- подострый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти, периостотомия

- хронический гематогенный остеомиелит нижней челюсти, остеоперфорация
- подострый гематогенный остеомиелит нижней челюсти, периостотомия

4. В клинику обратился пациент В., 47 лет с жалобами на боли, припухлость в подчелюстной области справа, повышение температуры тела до 38,7 С, слабость. Из анамнеза: болеет в течение 7 суток, когда заболел 4.6 зуб. Объективно: асимметрия лица за счет отека подчелюстной области справа. При пальпации в данной области определяется инфильтрат размером 3,0х3,5 см с четкими границами. Кожа над ним гиперемированная, отечная. В центре инфильтрата определяется симптом флюктуации. Открывание рта болезненное. Коронка 4.6 зуба разрушена на 2/3, перкуссия 4.6 зуба болезненна. Слизистая оболочка десны 4.6 зуба гиперемирована, отечна. На рентгенограмме: в области верхушки корней и бифуркации имеются очаги деструкции костной ткани. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

- острый серозный лимфаденит подчелюстной области, консервативное лечение
- *острый гнойный лимфаденит подчелюстной области, хирургическое лечение**
- аденофлегмона подчелюстной области, пункция гнойника
- острый гнойный подчелюстной сиалоденит, пункция гнойника
- одонтогенная флегмона подчелюстной области, хирургическое лечение

5. В клинику обратилась пациентка Т., 18 лет с жалобами на боли в подчелюстной области справа. Из анамнеза заболевания: пациентка неделю назад переболела ангиной. Объективно: в подчелюстной области справа отмечаются увеличение лимфатических узлов размером 1,5 х 1,0 см, подвижные, неспаивающиеся с окружающей тканью, пальпация болезненна. Кожа в цвете не изменена. Зев гиперемирован, отечен. Поставьте предварительный диагноз:

- нагноившаяся боковая киста
- хронический гиперпластический неодонтогенный лимфаденит
- острый гнойный неодонтогенный лимфаденит
- *острый серозный неодонтогенный лимфаденит**
- хронический сиалоденит

6. В клинику обратился пациент П., 45 лет с жалобами на боли припухлость в подчелюстной области слева, слабость, повышение температуры тела до 38,50С. 7 дней назад переболел ангиной. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей подчелюстной области слева. В данной области имеется инфильтрат 6,0*4,0см, кожа над ним гиперемирована, отечна, напряжена. Открывание рта болезненное, подъязычный валик гиперемирован, отечен слева. Зев гиперемирован, отечен. Поставьте предварительный диагноз и определите тактику хирургического лечения:

- хронический подчелюстной сиалоденит, периостотомия
- острый гнойный подчелюстной сиалоденит слева, пункция гнойника
- *аденофлегмона подчелюстной области слева, дренирование флегмоны**
- одонтогенная флегмона подчелюстной области слева, периостотомия
- острый гнойный лимфаденит подчелюстной области слева, дренирование гнойника

7. В клинику обратился пациент У., 28 лет с жалобами на боли и припухлость в области верхней челюсти справа, ограничение открывания рта, слабость, повышение температуры тела до 38,5°С. Из анамнеза: 3 суток назад в поликлинике удален 1.6 зуб. Объективно: общее состояние средней тяжести. Асимметрия лица за счет припухлости в щечной, околоушно-жевательной, височной области справа. Имеется симптом «песочных часов». Кожа гиперемирована, отечна. При

пальпации отмечается болезненность в точке соединения двух прямых, проведенных через наружный край орбиты и козелка уха под углом 60°. Открывание рта ограничено до 2,0 см. Лунка 1.6 зуба покрыта серым налетом. Слизистая свода преддверия полости рта гиперемирована, отечна. Поставьте предварительный диагноз и определите тактику хирургического лечения:

- одонтогенная флегмона височной, подвисочной областей, периостотомия
- *одонтогенная флегмона крылонебной, подвисочной областей, дренирование
- абсцесс подвисочной областей, пункция
- аденофлегмона височной, скуловой областей, остеоперфорация
- остеофлегмона околоушно-жевательной, височной областей, пункция

8. В клинику обратился пациент С., 55 лет, с жалобами на припухлость в области нижней челюсти справа. Болеет в течение 3 лет. Объективно: асимметрия лица за счет выбухания в области тела и угла нижней челюсти справа. В данной области наружная кортикальная пластина выбухает, кожные покровы не изменены в цвете, пальпация безболезненна. Открывание рта свободное. Переходная складка в области 4.6 и 4.7 сглажена, при пальпации определяется симптом «пергаментного хруста». Слизистая оболочка в цвете не изменена. На рентгенограмме – очаг просветления с зачатком 4.8 зуба. При гистологическом исследовании материала определена структура эмалевого органа. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

- *амелобластома, хирургическое лечение
- остеобластокластома, пункция
- цементома, экскохлеация
- одонтома, хирургическое лечение
- миксома, пункция

9. В клинику обратился пациент А., 65 лет с жалобами на припухлость в области нижней челюсти справа. Болеет в течение 2 лет. Объективно: асимметрия лица за счет деформации нижней челюсти справа. При пальпации определяется безболезненное, плотное вздутие тела нижней челюсти с обеих сторон. Кожа в цвете не изменена. Открывание рта свободное. Переходная складка сглажена с обеих сторон на уровне 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 зубов, имеется подвижность 4.5, 4.6, 4.7 зубов II-III степени. Слизистая оболочка с синюшным оттенком. На рентгенограмме – разрезание округлой формы с четкими контурами не связанное с зубами. Гистологически: васкулизированная ткань, состоящая из веретенообразных и гигантских клеток типа остеокластов. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

- амелобластома, пункция
- *гигантоклеточная опухоль, хирургическое лечение
- хондробластома, консервативное лечение
- фолликулярная киста, лучевая терапия
- одонтома, консервативное лечение

10. В клинику обратился пациент Ч., 36 лет. Поставлен диагноз: постравматический дефект нижней челюсти справа. Из анамнеза: травму получил во время военных действий. Объективно: асимметрия лица, за счет дефекта тела и угла нижней челюсти справа. Дефект длиной 8,0 см. Открывание рта ограничено до 2,0 см, слизистая оболочка полости рта на стороне дефекта не повреждена. Определите наиболее эффективный вид трансплантации:

- *аутоотрансплантат по размеру дефекта
- аутоотрансплантат на микрососудистом анастомозе
- гетеротрансплантат по размеру дефекта

- аллотрансплантат на микрососудистом анастомозе
- свободная пересадка комбинированных тканей

11. В клинику обратился пациент Т., 55 лет с жалобами на дефект зубного ряда нижней челюсти справа. Пациенту планируется операция имплантация зубов. Объективно: открывание рта свободное, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 зубов отсутствуют, альвеолярный отросток в области отсутствующих зубов атрофирован. Для проведения аугментации атрофированного альвеолярного отростка челюсти данному пациенту, лучше использовать:

- аллотрансплантат кости
- *аутоотрансплантат кости**
- гетеротрансплантат кости
- гидроксиапатит
- лиофилизированный аллотрансплантат хряща

12. В клинику обратился пациент Л., 20 лет с целью профилактического осмотра. При осмотре у пациента в полости рта на пришеечной области 3.3 зуба, обнаружено белое меловидное пятно, лишенное блеска. При зондировании зонд скользит, боли нет. После нанесения кариесмаркера пятно окрасилось в голубой цвет. Поставьте диагноз и определите рациональный метод лечения данного зуба

- Кариес дентина, сошлифовывание пятна
- *Кариес эмали, реминерализующая терапия**
- Гипоплазия, изготовление металлокерамической коронки на зуб
- Клиновидный дефект, пломбирование зуба
- Флюороз, гелий-неоновая лазеротерапия

13. В клинику обратился пациент Т., 32 лет, с жалобами на кратковременные боли от сладкого и кислого. При осмотре полости рта: на жевательной поверхности 1.7 зуба в области фиссур имеется кариозная полость в пределах эмали. Зондирование по дну безболезненное. ЭОД= 6 мкА.

Поставьте клинический диагноз и определите метод лечения:

- Кариес дентина, сошлифовывание эмали
- Кариес цемента, покрытие фторлаком
- Флюороз, пятнистая форма, реминерализующая терапия
- *Кариес эмали, пломбирование зуба**
- Очаговая гипоплазия, электрофорез с 10% раствором хлорида кальция

14. При обследовании полости рта пациента Д., 29 лет, в пришеечной области 1.4 зуба выявлена кариозная полость, дно которой располагается в пределах дентина. Зуб в цвете не изменен. Зондирование по дну – безболезненное, по стенкам болезненно. Перкуссия безболезненная. ЭОД=10 мкА. Поставьте клинический диагноз и определите метод лечения:

- Кариес эмали, реминерализующая терапия
- *Кариес дентина, пломбирование зуба**
- Кариес цемента, покрытие фторлаком
- Клиновидный дефект, пломбирование зуба
- Гипоплазия очаговая, реминерализующая терапия

15. В клинику обратился пациент Р., 46 лет, с жалобами на самопроизвольные приступообразные боли в области нижней челюсти, иррадирующие в ухо, усиливающиеся ночью. Точно не может

указать причинный зуб. При осмотре полости рта: на жевательной поверхности 3.6 зуба имеется глубокая кариозная полость, при зондировании дна отмечаются длительные боли. Дно и края полости рыхлые, дентин желтоватого цвета, легко отслаивается. Температурные раздражители вызывают приступ длительной медленно проходящей боли. Перкуссия безболезненная.

Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- Хронический периодонтит, перкуссия
- Хронический пульпит, пальпация
- Острый периодонтит, рентгенография
- Кариес дентина, витальное окрашивание

***Острый пульпит, электроодонтометрия**

16. В клинику обратился пациент Л., 25 лет, с жалобами на кровоточивость в 1.7 зубе во время еды. При осмотре полости рта: на жевательной поверхности 1.7 зуба имеется кариозная полость, заполненная разросшейся тканью, малоболезненной и кровоточащей при зондировании. Перкуссия безболезненная. Выберите метод обследования для уточнения диагноза:

- Биопсия
- Пальпация

***Рентгенография**

- Витальное окрашивание
- Трансиллюминация

17. В клинику обратился пациент К., 36 лет, с жалобами на постоянные ноющие боли в области 3.6 зуба. Зуб ранее лечен. При осмотре полости рта: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти слева, подчелюстные лимфоузлы увеличены слева. Открывание рта болезненное. Коронка 3.6 зуба под пломбой, на слизистой оболочке десны имеется свищевой ход с сукровично-гнойным экссудатом. На рентгенограмме: медиальные каналы obturated не до верхушки корня. У верхушки медиального корня имеется гомогенный очаг просветления костной ткани в виде «языка пламени». Поставьте диагноз и определите начальный этап лечения:

- Хронический гранулематозный периодонтит, резекция верхушки корня
- Острый периодонтит в фазе экссудации, УВЧ-терапия
- Обострение хронического гангренозного пульпита, лазеротерапия
- Хронический фиброзный периодонтит, электрофорез

***Обострение хронического гранулирующего периодонтита, распломбирование каналов**

18. В клинику обратился пациент Д., 35 лет, с жалобами на боли в зубе на верхней челюсти, усиливающиеся при накусывании. Ранее периодически беспокоили боли, за стоматологической помощью не обращался. Постепенно нарастающие боли беспокоят в течение 4 суток. При осмотре полости рта: коронка 2.6 зуба изменена в цвете, на жевательной поверхности имеется кариозная полость. Зондирование безболезненное, перкуссия резко болезненная. ЭОД=105 мкА. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- острый периодонтит в фазе экссудации, ультразвуковое исследование

***обострение хронического периодонтита, рентгенография**

- обострение хронического пульпита, микробиологическое исследование
- острый пульпит, иммунологическое исследование
- хронический периодонтит, магнитно-резонансная томография

19. В клинику обратился пациент И., 25 лет с жалобами на постоянные ноющие боли в 1.4 зубе, усиливающиеся при накусывании, ощущение «выросшего» зуба. В анамнезе: травма, полученная 2 дня назад. При осмотре зуб интактный, изменен в цвете. Вертикальная и горизонтальная перкуссия зуба резко болезненны, переходная складка сглажена, слизистая гиперемирована, отечна, пальпация болезненна. ЭОД-110 мкА. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- острый травматический периодонтит фаза интоксикации, ультразвуковое исследование
- *острый травматический периодонтит фаза экссудации, рентгенография**
- острый маргинальный периодонтит, микробиологическое исследование
- обострение хронического фиброзного периодонтита, иммунологическое исследование
- обострение хронического гранулирующего периодонтита, гистологическое исследование

20. Пациент Н., 59 лет, обратился с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов и при приеме пищи, увеличение десневых сосочков. При осмотре полости рта: в области 4.4,4.3,4.2,4.1,3.1,3.2,3.3,3.4 зубов определяются увеличенные разросшиеся десневые сосочки, синюшного цвета, которые закрывают до 1/3 высоты коронки зубов, легко кровоточат при дотрагивании. На рентгенограмме изменений нет. Поставьте предварительный диагноз:

- хронический катаральный гингивит
- обострение хронического катарального гингивита
- *гипертрофический гингивит отечная форма**
- гипертрофический гингивит фиброзная форма
- острый катаральный гингивит

21. Пациентка Р., 42 лет обратилась с жалобами на неприятный запах изо рта, кровоточивость десен при чистке зубов. Состоит на Д-учете с диагнозом хронический гастрит. При осмотре полости рта: слизистая оболочка десны цианотична, легко кровоточит при зондировании. У отдельных зубов определяются пародонтальные карманы глубиной до 3,5 мм. Имеются над- и поддесневые зубные отложения. Поставьте предварительный диагноз и определите начальный этап лечения:

- Острый гингивит, противовоспалительная терапия
- Хронический пародонтоз, консультация гастроэнтеролога
- Язвенный гингивит, антисептическая обработка
- *Хронический пародонтит, снятие зубных отложений**
- Обострение хронического гингивита, антибактериальная терапия

22. Пациентка Л., 25 лет, обратилась с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, неприятный запах изо рта. Беременность 32 недели. Со слов пациентки кровоточивость беспокоит в течении 6 месяцев. При осмотре полости рта: в области верхних и нижних резцов и клыков определяются рыхлые, гиперемированные с цианотичным оттенком десневые сосочки, которые кровоточат при зондировании, пародонтальные карманы отсутствуют. Имеются обильные наддесневые отложения. Поставьте предварительный диагноз:

- Острый пародонтит локализованный
- Хронический пародонтит легкой степени тяжести
- *Хронический катаральный гингивит**
- Язвенный гингивит
- Гипертрофический гингивит, фиброзная форма

23. В клинику обратился пациент О., 50 лет с жалобами на зуд в деснах, чувствительность зубов к тактильным, термическим и химическим раздражителям. При осмотре полости рта: десна плотная, бледно-розового цвета. Наличие клиновидных дефектов на жевательных зубах. Корни зубов оголены на 2/3 длины, зубы устойчивые. На рентгенограмме определяется равномерное снижение межзубных перегородок на 2/3 их высоты, чередование очагов остеопороза и остеосклероза. Поставьте предварительный диагноз:

- пародонтит 3 степени
- пародонтоз 2 степени
- пародонтит 2 степени
- *пародонтоз 3 степени**
- атрофический гингивит

24. В клинику обратился пациент К., 37 лет, с жалобами на зуд в десне по утрам. Со слов пациента зуд в деснах беспокоит его в течении 2 месяцев. При осмотре полости рта: слизистая оболочка десны бледно-розового цвета, плотная при пальпации. Клиновидные дефекты пришеечной области премоляров и моляров в пределах эмали. На рентгенограмме определяется равномерное снижение высоты межальвеолярных перегородок до 1/3 при сохранившейся компактной пластинке. Поставьте предварительный диагноз:

- *пародонтоз 1 степени**
- пародонтоз 2 степени
- пародонтит 2 степени
- атрофический гингивит
- пародонтит 1 степени

25. В клинику обратился пациент В., 25 лет с жалобами на периодическую кровоточивость десен при чистке зубов. При осмотре полости рта: слизистая оболочка десны и межзубных сосочков гиперемизированные с синюшным оттенком, рыхлые, неплотно прилегают к зубам. Имеются наддесневые зубные отложения. Зубодесневое прикрепление не нарушено. На рентгенограмме: изменений в костной ткани альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей не обнаружено. Поставьте предварительный диагноз:

- *хронический катаральный гингивит**
- острый катаральный гингивит
- хронический пародонтит легкой степени тяжести
- хронический пародонтит средней степени тяжести
- гипертрофический гингивит, фиброзная форма

26. В клинику обратился пациент Р., 25 лет с жалобами на сухость и шелушение нижней губы. При осмотре: на слизистой оболочке нижней губы, в области линии Клейна видны расширенные выводные протоки слизистых желез, из которых выделяется слюна в виде капель. Поставьте предварительный диагноз:

- контактный аллергический хейлит
- экзематозный хейлит
- эксфолиативный хейлит
- *простой glandулярный хейлит**
- метеорологический хейлит

27. В клинику обратился пациент К., 39 лет с жалобами на чувство жжения слизистой оболочки полости рта, усиливающееся при приеме пищи, разговоре, слабость, повышение температуры тела до 38С. Со слов пациента, состоит на Д-учете с хроническим тонзиллитом. Кожные покровы бледные, на коже предплечий, голеней эритематозные пятна с кровянистой коркой в центре. Красная кайма губ отечная, покрыта кровянистыми корками. Подчелюстные лимфоузлы увеличенные, болезненные при пальпации. На слизистой оболочке обоих щек, губ, дна полости рта имеются эрозии, покрытые фибринозным налетом. Поставьте предварительный диагноз:

***многоформная экссудативная эритема**

- отек Квинке
- лекарственная аллергия
- медикаментозный стоматит
- афтозный стоматит

28. В клинику обратился пациент Н., 36 лет, с жалобами на боли в области твердого неба, которые усиливаются при приеме пищи и чистке зубов. Со слов пациента, боли беспокоят в течении 2 суток, после неосторожного приема горячей пищи. При осмотре полости рта: слизистая оболочка твердого неба гиперемизированная, отечная, с участками эрозии неправильной формы, покрытые фибринозным налетом, болезненные при пальпации. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены. Поставьте предварительный диагноз:

- рванная рана твердого неба
- колотая рана твердого неба
- герпетический стоматит

***ожог слизистой оболочки твердого неба**

- лейкоплакия

29. В клинику обратился пациент Ю., 47 лет, с жалобами на чувство жжения на языке, неприятный запах изо рта, боли на языке при приеме горячей и острой пищи. При осмотре полости рта: на всей поверхности языка определяются мелкие борозды различной глубины, в виде извилин. Язык утолщен и увеличен в размере. Слизистая оболочка языка не изменена, все сосочки сохранены. Скопление пищи между складками языка. Поставьте предварительный диагноз:

- десквамативный глоссит

***складчатый язык**

- глоссалгия
- ромбовидный глоссит
- волосатый язык

30. В клинику обратился пациент Л., 54 лет, с жалобами на боли, припухлость в области мягких тканей нижней челюсти слева, слабость, повышение температуры тела до 37,8С. Болен в течение 3 суток, когда заболел 4.6 зуб, 2 суток назад появился отек. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти справа, кожа гиперемизированная, отечная. Пальпация болезненная. Открывание рта болезненное. Коронка 4.6 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненная. Переходная складка на уровне 4.5, 4.6, 4.7 зубов сглажена, гиперемизированная, отечная, напряжена. Пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

***острый гнойный периостит нижней челюсти, рентгенография**

- острый гнойный остеомиелит нижней челюсти, электроодонтометрия
- флегмона щечной области, иммунологическое исследование

- острый гнойный лимфаденит, коагуллограмма
- острый гнойный периодонтит, телерентгенография

31. В клинику обратился пациент Е., 37 лет, с жалобами на припухлость в области нижней челюсти слева. Болен в течение 12 суток, когда заболел 3.6 зуб. Объективно: асимметрия лица за счет уплотнения нижней челюсти слева, кожа в цвете не изменена. Пальпация безболезненна. Открывание рта свободное. Коронка 3.6 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненная. Переходная складка бледно-розового цвета, сглажена. Пальпация слегка болезненная. На рентгенограмме имеется расширение периодонтальной щели 3.6 зуба, очаг деструкции в области бифуркации корней. Поставьте предварительный диагноз:

- хронический периодонтит
- *хронический одонтогенный периостит**
- хронический одонтогенный остеомиелит
- хронический пародонтит
- радикулярная киста

32. Пациент М., 25 лет обратился с жалобами на боли и припухлость в подъязычной области слева. При осмотре: асимметрия лица за счет отека мягких тканей поднижнечелюстной области слева. Пальпируются увеличенные лимфатические узлы. Открывание рта ограничено до 1,5 см. В подъязычной области на уровне проекции корня 4.6 зуба имеется инфильтрат 2,5*2,0см, слизистая оболочка над ним гиперемированная, отечная, напряжена. Коронка 4.6 зуб коронка разрушена на 2/3, перкуссия болезненная, десна вокруг 4.6 зуба гиперемированная, отечная, пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз:

- абсцесс поднижнечелюстной области
- абсцесс крыловидно-челюстного пространства
- *абсцесс челюстно-язычного желобка**
- абсцесс окологлоточного пространства
- абсцесс языка

33. Во время проведения операции удаление 2.6 зуба произошла перфорация верхнечелюстного синуса с проникновением небного корня в верхнечелюстной синус, у пациента Р., 38 лет. Врач провел промывание верхнечелюстного синуса, промывные воды чистые, гноя нет. На компьютерной томографии небный корень располагался справа от соустья. Определите объем хирургического лечения:

- удаление корня 2.6 зуба и периостотомия
- гайморотомия
- *удаление корня 2.6 зуба, пластика соустья**
- удаление корня 2.6 зуба
- пластика соустья

34. Пациенту Д., 35 лет врач поставил диагноз: хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти от 4.7 зуба. Основным местным симптомом данной болезни, является:

- затрудненное дыхание, тахикардия
- повышение температуры, боли при жевании
- тахикардия, ограниченное открывание рта
- *наличие свищевого хода**
- боли при глотании, тахикардия

35. В клинику обратился пациент Я., 30 лет, с жалобами на боли и припухлость околоушной, височной областей слева. При осмотре: асимметрия лица за счет отека околоушной, височной областей слева. Имеется симптом «песочных часов». Определяется болезненность при пальпации в точке пересечения двух прямых, проведенных через наружный край глазницы и козелка уха под углом 60 градусов. Открывание рта ограничено до 1,5 см. Коронка 2.7 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненная. Слизистая свода преддверия полости рта сглажена, гиперемированная, отечная, напряжена. Пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз:

***флегмона подвисочной области слева**

- флегмона подглазничной области слева
- флегмона скуловой области слева
- флегмона околоушно-жевательной области слева
- флегмона щечной области слева

36. Пациент Р., 39 лет, обратился с жалобами на боли и припухлость в щечной, подглазничной областях слева, заложенность носа, головную боль, повышение температуры до 38,0С. Боли иррадиируют в лобную, височную области. При осмотре: асимметрия лица за счет отека щечной, подглазничной областей слева. Пальпация болезненная по передней стенке тела верхней челюсти. Открывание рта болезненное. Коронка 2.7 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненная. Десна вокруг 2.7 зуба гиперемированная, отечная. Из-под десневого края 2.7 зуба выделяется гнойный экссудат. Поставьте предварительный диагноз:

- флегмона крылонебной, подвисочной областей
- флегмона подглазничной, щечной областей
- острый гнойный остеомиелит верхней челюсти

***острый гнойный верхнечелюстной синусит**

- острый гнойный периостит верхней челюсти

37. Пациент Н., 28 лет, обратился с жалобами на головные боли и выделение гноя изо рта. 2 недели назад был удален 1.6 зуб, удаление было сложное. При осмотре: лицо симметричное. Открывание рта свободное. Лунка 1.6 зуба покрыта грануляциями, из-под которых выделяется гнойный экссудат. При зондировании, зонд свободно проходит в полость верхнечелюстного синуса слева. Определите метод диагностики для подтверждения диагноза:

- визиография
- ортопантомография
- магнитно-резонансная томография
- электроодонтометрия

***компьютерная томография**

38. Пациент А., 19 лет обратился с жалобами на ограничение открывания рта, деформацию лица справа, нарушение жевания. Из анамнеза: 5 лет назад у пациента была травма - перелом головки суставного отростка нижней челюсти справа. Проводилось консервативное лечение. Через 1 год после травмы появилось ограничение открывания рта, и появилась полная неподвижность нижней челюсти. Постепенно появилась деформация лица. Объективно: асимметрия лица за счет уплощения лица слева. При пальпации в области угла нижней челюсти определяется "шпора". Размеры тела и ветви нижней челюсти справа меньше, чем слева. Открывание рта ограничено до 1,5 см. Поставьте предварительный диагноз:

***постравматический анкилоз**

- деформирующий остеоартроз
- склерозирующий остеоартроз
- неоартроз
- посттравматический артрит

39. Пациент Ч., 32 лет, обратился в клинику с жалобами на боли и припухлость околоушно-жевательных областей, сухость во рту, повышение температуры тела до 38,0С. Болеет в течение 3 суток, когда появились кашель, насморк. Объективно: асимметрия лица за счет припухлости в околоушно-жевательных областях с обеих сторон. Кожные покровы в цвете не изменены. При пальпации определяются следующие болевые точки: впереди мочки уха, при надавливании в области верхушки сосцевидного отростка, в области вырезки нижней челюсти. Из устьев протоков слюнных желез слюна не выделяется. Поставьте предварительный диагноз:

***вирусный сиаладенит**

- обострение хронического сиаладенита
- острый гнойный сиаладенит
- калькулезный сиаладенит
- кисты слюнных желез

40. В клинику обратился пациент К., 19 лет, с жалобами на дефект в области неба, нарушение питания, дыхания, речи. Из анамнеза: патология врожденная. При местном осмотре: асимметрия лица, за счет укорочения среднего отдела лица. Открывание рта свободное. В области твердого и мягкого неба имеется дефект с захватом резцового отверстия, укорочение мягкого неба, расширен средний отдел ротоглотки. Поставьте предварительный диагноз:

- врожденная неполная расщелина твердого неба
- врожденная полная расщелина мягкого неба
- врожденная полная расщелина твердого неба

***врожденная полная расщелина твердого и мягкого неба**

- врожденная неполная расщелина мягкого неба

41. В клинику обратился пациент З., 43 лет, с жалобами на опухолевидное образование околоушно-жевательной области слева. Болеет в течение 9 месяцев, когда появилось новообразование, постепенно увеличилось. Объективно: асимметрия лица за счет опухолевидного образования в области околоушной слюнной железы диаметром 5,0*4,0см. При пальпации плотно-эластичной консистенции. Кожные покровы над опухолью не изменены в цвете, пальпация безболезненная. При гистологическом исследовании определены эпителиальные клетки с мезенхимоподобными участками, состоящими из хрящеподобных структур. Поставьте клинический диагноз:

***плеоморфная аденома**

- сиалоденоз
- онкоцитоз
- аденолимфома
- аденокарцинома

42. В клинику обратился пациент Ш., 29 лет, с жалобами на боли в полости рта. 6 часов назад выпил горячий чай. При осмотре: слизистая полости рта гиперемированная, отечная. На слизистой оболочке верхней и нижней губы имеются пузыри желтоватого цвета, при пальпации болезненные. Определите степень ожога слизистой оболочки верхней и нижней губы:

- I степень
- *II степень**
- III-а степень
- III-б степень
- IV степень

43. Пациенту С., 27 лет, поставлен диагноз: Обострение хронического периодонтита 4.7 зуба. Показана операция удаление 4.7 зуба. Врач после проведенной местной анестезии приступил к удалению зуба. Врач наложил щипцы на 4.7 зуб, продвинул их, зафиксировал, вывихнул зуб и извлек из лунки. Во время извлечения из лунки произошел разрыв десны, и началось кровотечение. Определите этап операции удаления 4.7 зуба, который врач не провел:

***отслоение круговой связки зуба**

- фиксация щипца
- продвижение щечек щипцов
- люксация зуба
- экстракция зуба

44. Пациенту Ф., 32 лет проведена операция удаление 4.7 зуба. Врач, во время проведения операции удаление 4.7 зуба элеватором, не фиксировал альвеолярный отросток пальцами левой руки. Вывихнутый корень сместился под слизистую оболочку альвеолярной части нижней челюсти в язычную сторону. Определите причину проталкивания корня зуба в мягкие ткани:

- обильное кровоснабжение

***тонкая внутренняя стенка альвеолы**

- плотная наружная стенка альвеолы
- кривой корень зуба
- особенности иннервации

45. Пациент У., 35 лет, во время драки получил ножевое ранение подбородочной области. Края раны ровные, умеренно кровоточат, размеры раны 3,0*1,0см. При проведении первичной хирургической обработки раны промежутки между швами должны быть не более:

- 0,3см

***0,4см**

- 0,6см
- 0,8см
- 1,0см

46. В клинику обратился пациент Ц., 49 лет, с жалобами на невозможность закрыть рот, боли в верхнем отделе околоушных областей. Из анамнеза: во время зевания что-то щелкнуло и пациент не смог закрыть рот. Объективно: асимметрия лица за счет удлинения его нижней трети и смещения подбородка кпереди. Из рта обильно выделяется слюна, но язык сухой. Ткани впереди козелка уха слева и справа западают, а под скуловой дугой пальпируются головки суставных отростков. Прикус открытый. Поставьте предварительный диагноз:

- задний вывих ВНЧС
- перелом суставных отростков

***передний вывих ВНЧС**

- анкилоз
- деформирующий остеоартроз

47. Пациенту Д., 42 лет, проведена операция имплантация 3.4,3.5,3.6 зубов, после операции через 3 суток появилась парестезия нижней губы и щечной области слева. Определите причину возникновения парестезии:

- несоблюдение правил асептики
- *сдавление нервного ствола имплантатом**
- перфорация стенки альвеолярного отростка
- выход инструмента за пределы костной ткани
- неправильно выбранная доза анестетика

48. В клинику обратился пациент Т., 39 лет с жалобами на нарушение приема пищи, речи, отсутствие центральных зубов на нижней челюсти. При осмотре полости рта определен включенный дефект переднего отдела зубного ряда на нижней челюсти, при отсутствии 41,31,32 зубов. Определите вид протеза для закрытия данного дефекта:

- *несъемный мостовидный протез**
- консольный протез
- полный съемный протез
- адгезивный мостовидный протез
- частичный съемный протез

49. В клинику обратился пациент У., 49 лет с жалобами на нарушение приема пищи, отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти. При осмотре полости рта определен включенный дефект бокового отдела зубного ряда на нижней челюсти слева, при отсутствии 35,36 зубов. Определите вид протеза для закрытия данного дефекта:

- консольный протез
- *несъемный мостовидный протез**
- полный съемный протез
- адгезивный мостовидный протез
- частичный съемный протез

50. В клинику обратился пациент Г., 29 лет с жалобами на дефект в зубном ряду. При осмотре полости рта определен дефект зубного ряда на верхней челюсти слева, при отсутствии 22 зуба. Определите вид протеза для закрытия данного дефекта:

- полный съемный протез
- несъемный мостовидный протез
- *консольный протез**
- адгезивный мостовидный протез
- частичный съемный протез

51. В клинику обратился пациент Е., 32 лет после операции имплантация зубов. Пациенту показано временное протезирование. При осмотре полости рта определены дефекты зубного ряда на нижней челюсти справа и слева, при наличии имплантатов в области 34,35,36,45,46,47 зубов. Определите вид временного протеза для закрытия данного дефекта:

- полный съемный протез
- несъемный мостовидный протез
- консольный протез
- *адгезивный мостовидный протез**

- частичный съемный протез

52. В клинику обратился пациент Н., 62 лет с жалобами на нарушение приема пищи, полное отсутствие зубов. Асимметрия лица за счет западения губ и щек. Выражены носогубные складки, опущены углы рта. Нижняя челюсть смещена кверху и кпереди, высота нижнего отдела лица снижена. Открывание рта свободное, наблюдается полное отсутствие зубов, атрофия вестибулярной поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти и язычной поверхности альвеолярного отростка нижней челюсти. Определите вид прикуса, развившееся при полном отсутствии зубов:

- ювенильная дизокклюзия
- ювенильная мезиоокклюзия
- старческая микрогения
- старческая прогнатия

***старческая прогения**

53. В клинику обратился пациент Ф., 65 лет с жалобами на нарушение приема пищи, полное отсутствие зубов. Асимметрия лица за счет западения губ и щек. Выражены носогубные складки, опущены углы рта. Нижняя челюсть смещена кверху и кпереди, высота нижнего отдела лица снижена. Открывание рта свободное. Наблюдается полное отсутствие зубов на нижней челюсти, выраженная альвеолярная часть, переходная складка расположена далеко от гребня альвеолярного отростка. Определите вид атрофии беззубой нижней челюсти по Келлеру:

***1-й тип**

- 2-й тип
- 3-й тип
- 4-й тип
- 5-й тип

54. В клинику обратился пациент О., 67 лет с жалобами на нарушение приема пищи, полное отсутствие зубов. Асимметрия лица за счет западения губ и щек. Выражены носогубные складки, опущены углы рта. Нижняя челюсть смещена кверху и кзади, высота нижнего отдела лица снижена. Открывание рта свободное. Наблюдается полное отсутствие зубов на нижней челюсти, средняя равномерная атрофия всей альвеолярной части, подвижная слизистая оболочка расположена на уровне гребня. Определите вид атрофии беззубой нижней челюсти по Келлеру:

- 1-й тип

***2-й тип**

- 3-й тип
- 4-й тип
- 5-й тип

55. В клинику обратился пациент З., 57 лет с жалобами на нарушение приема пищи, полное отсутствие зубов. Асимметрия лица за счет западения губ и щек. Выражены носогубные складки, опущены углы рта. Нижняя челюсть смещена кверху и кпереди, высота нижнего отдела лица снижена. Открывание рта свободное. Наблюдается полное отсутствие зубов на нижней челюсти, хорошо выражена альвеолярная часть во фронтальном отделе и резко атрофирована в области жевательных зубов. Определите вид атрофии беззубой нижней челюсти по Келлеру:

- 1-й тип
- 2-й тип

***3-й тип**

- 4-й тип
- 5-й тип

56. В клинику обратился пациент Я., 66 лет с жалобами на нарушение приема пищи, полное отсутствие зубов. Асимметрия лица за счет западения губ и щек. Выражены носогубные складки, опущены углы рта. Нижняя челюсть смещена кверху и кпереди, высота нижнего отдела лица снижена. Открывание рта свободное. Наблюдается полное отсутствие зубов на нижней челюсти, альвеолярная часть атрофирована во фронтальном отделе и хорошо выражена в области жевательных зубов. Определите вид атрофии беззубой нижней челюсти по Келлеру:

- 1-й тип
- 2-й тип
- 3-й тип

***4-й тип**

- 5-й тип

57. Перестройка мышечного компонента под новую высоту нижнего отдела лица и окклюзионные взаимоотношения зубов-антагонистов и зубных рядов происходит в течение:

- 1 месяца
- 2 месяцев
- 3 месяцев
- 5 месяцев

***6 месяцев**

58. Процессом, сопровождающимся убылью твердых тканей зубов, изменениями периодонта, нарушением функции жевательных мышц, является:

***повышенное стирание**

- сошлифовывание
- эрозия
- дефект
- деформация

59. Процессом, сопровождающимся убылью твердых тканей зубов, вследствие реставрации или механического воздействия инородными телами, проявляющаяся на пришеечных и окклюзионных поверхностях, является:

- повышенное стирание

***сошлифовывание**

- эрозия
- дефект
- деформация

60. Процессом, сопровождающимся убылью твердых тканей зубов, обусловленной поверхностной деминерализацией, вследствие действия кислот, проявляющаяся на вестибулярных пришеечных или оральных и окклюзионных поверхностях, является:

- повышенное стирание
- сошлифовывание

***эрозия**

- дефект
- деформация

61. В клинику обратился пациент Р., 47 лет с жалобами на боли, хруст в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) справа, шум в ушах, снижение слуха. Пациент очень раздражительный. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта болезненное. При открывании рта наблюдается девиация нижней челюсти. При пальпации жевательная мышца справа напряжена. На КТ-графии определяется вывих головки нижней челюсти справа.

Определите степень тяжести дисфункции ВНЧС:

- средняя
- тяжелая
- средне-тяжелая
- * легкая
- крайне-тяжелая

62. В клинику обратился пациент Л., 45 лет с жалобами на боли, хруст в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) слева, снижение слуха, головные боли, боли в области лица. Пациент очень раздражительный. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта ограничено до 3.0 см. При открывании рта наблюдается девиация нижней челюсти. При пальпации жевательная мышца и мышцы лица слева напряжены. На КТ-графии определяется вывих головки нижней челюсти слева. Определите степень тяжести дисфункции ВНЧС:

- * средняя
- тяжелая
- средне-тяжелая
- легкая
- крайне-тяжелая

63. В клинику обратился пациент Д., 37 лет с жалобами на боли, хруст в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) справа, шум в ушах, снижение слуха, головокружение, головные и лицевые боли. Пациент очень раздражительный. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта ограничено до 2,5 см. При открывании рта наблюдается девиация нижней челюсти. Прикус нарушен. На КТ-графии определяется вывих головки нижней челюсти справа. Определите степень тяжести дисфункции ВНЧС:

- средняя
- * тяжелая
- среднетяжелая
- легкая
- крайне-тяжелая

64. В клинику обратился пациент Р., 46 лет с целью протезирования после операции имплантации. Врач-ортопед принял решение использовать имплантаты и зубы в качестве опоры несъемного протеза. Определите причину неблагоприятного влияния на устойчивость остеоинтегрированных внутрикостных имплантатов:

- нагрузка на имплантаты
- нагрузка на опорные зубы
- * физиологическая подвижность зубов
- состояние слизистой оболочки десны

- состояние высоты альвеолярного отростка

65. В клинику обратился пациент В., 26 лет с жалобами на изменение положения 16,17 зубов, нарушение жевания. 5 лет назад удалены 46, 47 зубы. 16, 17 зубы вертикально переместились, наблюдается зубо-альвеолярное удлинение. Определите группу деформации зубного ряда по Гаврилову:

- V
- IV
- III
- II
- *I**

66. Ребенок А., 10 лет, обратился к врачу-ортодонт. Из анамнеза: привычка спать на левом боку подложив кулак под щеку. Объективно: правая и левая половины лица не симметричные, верхняя, средняя и нижняя трети лица пропорциональны, носогубные, подбородочная складки умеренно выражены, профиль прямой. Смыкание жевательных зубов по трансверзали: слева - щечные бугорки нижних жевательных зубов перекрывают щечные бугорки верхних, справа – щечные бугорки нижних жевательных зубов располагаются в продольной фиссуре верхних. Срединная линия между нижними и верхними центральными резцами смещена на 2 мм вправо. Величина открывания рта 39 мм, при открывании рта отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

***перекрестная окклюзия**

- мезиальная окклюзия
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

67. Пациент Г., 8 лет обратился с жалобами на деформацию лица. Объективно: асимметрия лица за счет смещения подбородка вправо. Носогубные, подбородочная складки умеренно выражены, профиль прямой. При смыкании жевательных зубов по трансверзали: слева щечные бугорки нижних зубов контактируют с небными бугорками верхних зубов, справа щечные бугорки нижних зубов перекрывают щечные бугорки верхних зубов. Срединная линия между нижними и верхними центральными резцами смещена вправо на 4 мм. При закрывании рта нижняя челюсть смещается вправо, при открывании возвращается в правильное положение. Величина открывания рта 39 мм. Поставьте предварительный диагноз:

- мезиальная окклюзия

***перекрестная окклюзия**

- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

68. Пациент Е., 15 лет обратилась к ортодонт с жалобами на неправильное смыкание зубов и некрасивый профиль. Из анамнеза жизни: у отца и деда массивная нижняя челюсть. Объективно: верхняя, средняя и нижняя трети пропорциональны, подбородочная складка сглажена, подбородок выступает вперед. Между зубами нижней челюсти диастема и тремы. При смыкании жевательных зубов по трансверзали: справа и слева щечные бугорки нижних зубов перекрывают щечные бугорки верхних зубов. Срединная линия между центральными зубами верхнего и

нижнего зубного ряда совпадает. Нижние фронтальные зубы перекрывают верхние на 1/3, обратная сагиттальная щель 3 мм. Величина открывания рта 39 мм. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- *мезиальная окклюзия**
- нижняя микрогнатия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

69. Пациент Ж., 8 лет обратился с жалобами на ротовое дыхание ребенка. Из анамнеза: привычка держать рот приоткрытым. Объективно: высота нижней трети лица увеличена, носогубные и подбородочные складки сглажены, подбородок выступающий. Верхние фронтальные зубы наклонены вестибулярно. При смыкании жевательных зубов по трансверзали: справа и слева вестибулярные и оральные бугорки верхних и нижних зубов контактируют друг с другом. Срединная линия между центральными зубами совпадает. Вертикальная щель между резцами 2 мм. Величина открывания рта 39 мм. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- дистальная окклюзия
- мезиальная окклюзия
- *вертикальная резцовая дизокклюзия**
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

70. Пациент О., 13 лет обратился к ортодонту с жалобами на «кривые» передние зубы. Из анамнеза: сосание пустышки до 3 лет. Объективно: высота нижней трети лица снижена, носогубные складки сглажены, подбородочная складка выражена, подбородок скошенный. Верхние фронтальные зубы наклонены вестибулярно, скученность нижних фронтальных зубов, оральный наклон. При смыкании жевательных зубов по трансверзали: справа и слева вестибулярные бугорки нижних зубов располагаются в продольной фиссуре верхних зубов. Срединная линия между центральными зубами совпадает. Глубина резцового перекрытия 2/3. Открывание рта 39 мм, при открывании рта отмечается девиация. при глотании язык прокладывает между зубами. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- мезиальная окклюзия
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- *глубокая резцовая дизокклюзия**

71. Пациент К., 9 лет обратился к ортодонту. Из анамнеза: хронический синусит. Объективно: лицо узкое, вытянутое, складки сглажены, подбородок скошен, губы смыкаются с напряжением. Между временными зубами плотные контакты. При смыкании жевательных зубов по трансверзали: справа и слева вестибулярные бугорки нижних зубов располагаются в продольной фиссуре верхних зубов. Мезиальные бугры нижних первых моляров при смыкании контактируют с одноименными буграми верхних первых моляров. Срединная линия между центральными зубами совпадает. Глубина резцового перекрытия 1/3, открывание рта 39 мм, при открывании рта отмечается девиация. Отмечается нарушение артикуляционных движений. Привычное ротовое дыхание. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия

- мезиальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- *дистальная окклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

72. Пациент Л., 12 лет обратился к ортодонту. Объективно: носогубные, подбородочная складки умеренно выражены, профиль прямой. Отмечается скученность нижних фронтальных зубов. По сагиттали: справа и слева медиальный щечный бугорок первого верхнего постоянного моляра располагается в межбугорковой фиссуре первого нижнего постоянного моляра. Срединная линия между центральными резцами смещена влево на 2 мм. Глубина резцового перекрытия 1/3, сагиттальная щель 3 мм. Слизистая оболочка с оральной стороны в области нижних фронтальных зубов гиперемирована, отечна. Величина открывания рта 39 мм, при открывании рта отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- мезиальная окклюзия
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- *сагиттальная резцовая дизокклюзия

73. Пациент Г, 12 лет, обратился к ортодонту. Из анамнеза: состояние после хейло-уранопластики. Объективно: Вторичная деформация носа выражена не значительно. Складки умеренно выражены. Скученность верхних фронтальных зубов, 22 зуб отсутствует. Фронтальный отдел верхнечелюстного зубного ряда укорочен, форма трапецевидная. Форма нижнего зубного ряда парабола. По сагиттали: справа и слева медиальный щечный бугорок первого верхнего постоянного моляра располагается в межбугорковой фиссуре первого нижнего постоянного моляра. Срединная линия между центральными резцами смещена влево на 2 мм. Обратное резцовое перекрытие, глубина перекрытия 1/3, открывание рта 39 мм, при открывании рта отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

- *обратное резцовое перекрытие
- мезиальная окклюзия
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

74. Мама пациента В., 7 лет, обратилась к ортодонту с жалобами на прорезавшиеся «огромные» передние зубы у ребенка. Объективно: Лицо симметричное, пропорциональное, складки умеренно выражены. Тип профиля прямой. Тремы между временными зубами, за исключением II и III верхних справа и слева, постоянные верхние центральные резцы очень крупные. При смыкании жевательных зубов по трансверзали: справа и слева вестибулярные бугорки нижних зубов располагаются в продольной фиссуре верхних зубов. Глубина резцового перекрытия 1/3, центральная линия между резцами совпадает, открывание рта 39 мм. Поставьте предварительный диагноз:

- микроденция 11,21 зубов
- *макроденция 11,21 зубов
- деформация зубного ряда
- деформация прикуса
- дефект зубного ряда

75. Пациент Б., 13 лет, обратился к ортодонту с жалобами на не смыкание передних зубов. Объективно: высота нижней трети лица увеличена, подбородочная и носогубные складки сглажены. Небное положение 14, 15, 24, 25 зубов. Форма верхнего зубного ряда седловидная, форма нижнего зубного ряда парабола. При смыкании жевательных зубов по трансверзали: в области моляров вестибулярные бугорки нижних зубов располагаются в продольной фиссуре верхних, в области премоляров вестибулярные бугорки нижних зубов расположены вестибулярно одноименных бугорков верхних зубов. Во фронтальном отделе: вертикальная щель 4 мм. Открывание рта 39 мм, при открывании рта отмечается девиация. Во время глотания язык прокладывает между зубами. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- мезиальная окклюзия
- дистальная окклюзия
- *вертикальная резцовая дизокклюзия**
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

76. Пациент А., 15 лет, обратился к ортодонту с жалобами на наличие щели между верхними центральными зубами. Объективно: Отмечается асимметрия лица за счет снижения высоты нижней трети лица. Носогубные складки сглажены, подбородочная складка выражена. Отмечается скученность нижних фронтальных зубов. При смыкании зубов во фронтальном отделе срединная линия смещена влево на 4 мм. Верхние центральные резцы перекрывают нижние более чем на ½ высоты коронок. В области 13,12,11 зубов сагиттальная щель до 3 мм уменьшающаяся по направлению к центральным резцам. Открывание рта 41 мм, при открывании рта отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- мезиальная окклюзия
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- *глубокая резцовая дизокклюзия**

77. Пациент И., 7 лет, обратился к ортодонту. Объективно: Лицо симметричное, носогубные и подбородочная складки умеренно выражены. Верхние фронтальные зубы имеют оральный наклон, отмечается скученность. Зубо-альвеолярное удлинение в области 55, 54 зубов. По трансверзали имеющиеся жевательные зубы имеют правильное фиссурно-бугорковое смыкание, по сагиттали отмечается бугорковое смыкание 26 и 36 зубов, медиальный щечный бугор 16 зуба смыкается с дистальным бугорком 46 зуба. Глубина резцового перекрытия 1/3, срединная линия между центральными резцами совпадает. Открывание рта 42 мм, движения в суставе не симметричные, при открывании рта отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

- *дистальная окклюзия**
- дефект зубных рядов
- деформация прикуса
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

78. Мама пациента А., 7 лет, обратилась к ортодонту с жалобами на криво стоящие зубы. Объективно: носогубные и подбородочная складки умеренно выражены. 12 зуб не прорезался, место для него отсутствует, выраженная скученность нижних фронтальных зубов: вестибулярный

наклон 43 зуба, язычное прорезывание 42 зуба, тортоположение 32 зуба. Форма зубных рядов полукруг. При смыкании зубов в боковых отделах по трансверзали справа и слева, вестибулярные бугорки нижних зубов располагаются в продольной фиссуре верхних. Глубина резцового перекрытия 1\3 коронки, срединная линия смещена вправо за счет перемещения 11,21 в сторону отсутствующего 12 зуба. Открывание рта 39 мм, при глотании язык прокладывает между зубами. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- *аномалия положения зубов**
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

79. Пациент Е, 14 лет, обратилась к ортодонту с жалобами на неправильное смыкание зубов, нарушение речи. Объективно: носогубные и подбородочная складки умеренно выражены. Язык крупный, на боковых поверхностях языка сохраняются отпечатки зубов. 37 и 47 зубы с мезиальным наклоном. Между 44 и 45, 34 и 35 зубами тремы. Верхние и нижние фронтальные зубы в состоянии ретрузии, нижние боковые зубы с оральным наклоном. При смыкании во фронтальном отделе обратное резцовое перекрытие, срединная линия совпадает. При смыкании зубов по сагиттали, медиальные щечные бугорки верхних первых постоянных моляров располагаются между шестыми и седьмыми нижними зубами. Открывание рта 38 мм, движения в суставе не симметричные, отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- *мезиальная окклюзия**
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

80. Пациент К., 15 лет, обратился к ортодонту с жалобами на криво стоящие зубы. Из анамнеза: 15 и 25 зубы удалены в возрасте 11 лет по ортодонтическим показаниям. Объективно: высота нижней трети лица уменьшена, подбородочная складка выражена. Отмечается скученность нижних фронтальных зубов. Верхний зубной ряд сужен в области премоляров и моляров, нижний зубной ряд асимметричен, сужение наиболее выражено в области премоляров справа. По трансверзали отмечается правильное фиссурно-бугорковое смыкание, за исключением области 13/44 зубов – обратное перекрытие, 14/45– 45 зуб смещен орально. Глубина резцового перекрытия 2/3 коронки, центральная линия не совпадает. Открывание рта 38 мм, движения в суставе не симметричные, отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- мезиальная окклюзия
- *глубокая окклюзия 2 степени**
- вертикальная резцовая дизокклюзия
- сагиттальная резцовая дизокклюзия

81. Пациенту 8 лет. Жалобы: на наличие промежутка между передними зубами верхней челюсти. Объективно: лицо симметричное, дыхание носовое, низкое прикрепление уздечки верхней губы. Расстояние между 11 и 21- 4мм. 11 зуб смещен латерально, завернут по оси. Недостаток места 12 зубу. На рентгенограмме имеются зачатки всех постоянных зубов. Наиболее вероятный диагноз:

- Адентия 12 зуба

- Дистопия 11 зуба

- *Диастема**

- Сужение верхней челюсти
- Ретенция

82. Пациенту 14 лет. Жалобы: на косметический недостаток. Объективно: В полости рта сужение зубного ряда верхней и нижней челюсти. 13 зуб смещен в сторону преддверия рта, 14 зуб смещен медиально. В зубном ряду сохранен 53 зуб. Наиболее вероятный диагноз:

- Прямой прикус
- Адентия 12, 22 зубов

- *Дистопия 13 зуба**

- Сверхкомплектный между 12 и 14 зубами
- Мезиальный прикус

83. Ребенку 6 лет. Появилась привычка проталкивать язык между зубными рядами во время глотания. К какому виду аномалий прикуса может привести данная вредная привычка?

- глубокому
- *перекрестному**
- прогнатическому
- ортогнатическому
- прямому

84. У пациентки резцовая дизокклюзия без нарушения сагиттального соотношения зубных рядов, но с тенденцией к развитию мезиоокклюзии. То в таком случае применяем аппарат с окклюзионными накладками в области боковых зубов с целью:

- *зубоальвеолярного укорочения**

- зубоальвеолярного удлинения
- для расширения зубных рядов
- для корпусного перемещения
- для удлинения зубных рядов

85. Пациент 16 лет, обратился к врачу-ортодонт по поводу верхнего клыка, резко выступающего вестибулярно из зубной дуги. Объективно: верхний клык выступает за дугу окклюзии на $\frac{1}{2}$ толщины зуба, на противоположной стороне зубного ряда отсутствует постоянный клык место для него в зубном ряду недостаточна. На ортопантомограмме челюстей отмечается наличие клыка расположенный горизонтально под углом к соседнему боковому резцу. Укажите какой вид аномалии развития зубов:

- Адентия зубов
- *Ретенция зубов**
- Сверхкомплектные зубы
- Макродентия зубов
- Аномалии формы зубов

86. Пациент О., 15 лет в течение 2 лет находилась на ортодонтическом лечении брекет-системой, период активного лечения прерван по требованию пациента, брекеты сняты. Объективно: Лицо симметричное. Носогубные и подбородочные складки умеренно выражены. Форма верхнего зубного ряда полуэллипс, форма нижнего зубного ряда парабола. При смыкании зубных рядов

глубина резцового перекрытия 1/3 высоты коронки, срединная линия совпадает, по трансверзали правильный фиссурно-бугорковый контакт, по сагиттали отмечается бугорковое смыкание в области моляров и премоляров. Открывание рта 38 мм, движения в суставе не симметричные, отмечается девиация. На оральной поверхности верхних и нижних фронтальных зубов зафиксирован стекловолоконный ретейнер. Поставьте предварительный диагноз:

- перекрестная окклюзия
- мезиальная окклюзия
- глубокая резцовая окклюзия

***смыкание жевательных зубов по 2 классу Энгля**

- смыкание жевательных зубов по 3 классу Энгля

87. Пациент М., 14 лет обратилась к врачу-ортодонту с жалобами на криво стоящие зубы.

Объективно: Долихоцефалическая форма головы, носогубные и подбородочные складки выражены умеренно. Отмечается скученность верхних и нижних фронтальных зубов, 12 и 22 зубы имеют шиповидную форму. Верхний зубной ряд равномерно сужен в области премоляров и моляров, форма нижнего зубного ряда парабола. Глубина резцового перекрытия 1/3 коронки, срединная линия не совпадает, при смыкании зубов по сагиттали выявляется правильный фиссурно-бугорковый контакт, по трансверзали вестибулярные бугры нижних жевательных зубов располагаются кнаружи от соответствующих бугров верхних зубов. Открывание рта 38 мм, движения в суставе не симметричные, отмечается девиация. Поставьте предварительный диагноз:

- глубокую резцовую окклюзию
- мезиальная окклюзия
- дистальная окклюзия
- вертикальная резцовая дизокклюзия

***двусторонняя палатиноокклюзия**

88. Мама с ребенком 3., 5 лет, обратилась к ортодонту. Объективно: носогубные и подбородочные складки выражены умеренно. Между нижними фронтальными зубами отмечаются промежутки 1-2 мм, верхние центральные резцы имеют небольшой поворот по оси. Коронки временных зубов стерты на 1/3 высоты коронок. Форма зубных рядов полукруг. При смыкании зубных рядов по трансверзали вестибулярные бугры нижних жевательных зубов располагаются в продольной фиссуре верхних, по сагиттали дистальные поверхности последних моляров образуют мезиальную ступеньку. Открывание рта 38 мм, при открывании рта движения в суставе симметричны.

Поставьте предварительный диагноз:

***тортаномалия 51,61 зубов**

- макроденция 51,61 зубов
- деформация прикуса
- дефект зубного ряда
- деформация зубного ряда

89. Пациент У., 2 лет, обратился с жалобами на припухлость и боли в подчелюстной области

справа. Ребенок 1 неделю назад болел ангиной. При осмотре: в подчелюстной области пальпируется болезненный инфильтрат, подвижный, с кожей и подлежащими тканями не спаян, размером 2.5х2.0см. Кожа над ним в цвете не изменена, собирается в складку. Открывание рта свободное, зев гиперемированный, отечный справа. Поставьте предварительный диагноз:

- боковая киста шеи

- хронический гиперпластический лимфаденит

- *острый серозный лимфаденит**

- острый гнойный лимфаденит

- острый серозный сиалоденит

90. Ребенок Н., 6 лет, обратился в клинику с жалобами на боли и припухлость в области мягких тканей нижней челюсти справа, слабость, недомогание. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти справа. Кожные покровы над отеком гиперемизированные, отечные. Открывание рта болезненное. Коронка 8.5 зуба разрушена на ½, перкуссия болезненная. Переходная складка на уровне 8.4, 8.5 зубов сглажена, гиперемизированная, отечная, напряжена.

Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- обострение хронического периодонтита 8.5 зуба, общий анализ крови

- острый гнойный периодонтит 8.5 зуба, телерентгенография

- острый гнойный остеомиелит от 8.5 зуба, компьютерная томография

- острый гнойный пульпит 8.5 зуба, электроодонтометрия

- *острый гнойный периостит от 8.5 зуба, рентгенография**

91. Ребенок Р., 9 лет, обратился в клинику с жалобами на боли и припухлость мягких тканей верхней челюсти слева, повышение температуры тела до 38,0°C. Болеет третий день. Объективно: асимметрия лица, за счет отека мягких тканей верхней челюсти слева. Кожные покровы над отеком гиперемизированные, отечные, пальпация болезненная. Открывание рта болезненное. Коронка 6.4 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненная, подвижность 7.4 зуба II-III степени. Переходная складка на уровне 6.3, 6.4, 6.5 зубов гиперемизированная, отечная, напряжена.

Пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- обострение хронического периодонтита 6.4 зуба, телерентгенография

- острый гнойный остеомиелит от 6.4 зуба, компьютерная томография

- одонтогенная флегмона щечной области от 6.4 зуба, коагулограмма

- острый гнойный пульпит 6.4 зуба, электроодонтометрия

- *острый гнойный периостит от 6.4 зуба, рентгенография**

92. В поликлинику обратился ребенок Ж., 8 лет, с жалобами на боли и припухлость в области верхней челюсти слева. Из анамнеза: Болеет в течении 2 суток, когда заболел 6.5 зуб, который лечили 6 месяцев назад по поводу острого пульпита. Периодически 6.5 зуб беспокоил, но повторно за медицинской помощью не обращались. Появилась припухлость. Врач-стоматолог, на основании осмотра и рентгенографии, поставил диагноз: Обострение хронического периодонтита и принял решение провести операцию удаление 6.5 зуба. Выберите вид анестезии и инструмент для удаления 6.5 зуба:

- ментальная анестезия, прямые щипцы

- подглазничная анестезия, прямой элеватор

- туберальная анестезия, клювовидные сходящиеся щипцы несходящиеся щипцы с шипами

- *инфильтрационная анестезия, S-образные несходящиеся щипцы с шипами**

- мандибулярная анестезия, клювовидные щипцы с шипами

93. В клинику обратился ребенок Я., 16 лет, с жалобами на боли и припухлость в области нижней челюсти справа. Из анамнеза: болеет в течении 2 суток, когда заболел 4.6 зуб. Появилась припухлость. На основании осмотра и рентгенографии, врач-стоматолог поставил диагноз: обострение хронического периодонтита 4.6 зуба и принял решение провести операцию удаление

4.6 зуба. Определите вид анестезии и положение врача во время проведения операции удаление

4.6 зуба:

- уберальная и небная; впереди-справа
- ментальная и инфильтрационная; впереди-слева
- *мандибулярная и инфильтрационная; позади-справа
- подглазничная и небная; позади-слева
- резцовая и небная; по центру

94. В поликлинику обратился ребенок Ж., 12 лет с жалобами на постоянные ноющие боли в области второго верхнего резца слева, усиливающиеся при надкусывании, иррадиирующие в область левого глаза. Отмечает чувство "выросшего" зуба. Болеет 2 суток. Объективно: лицо симметричное. Открывание рта свободное. На небной поверхности коронки 2.1 зуба глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином, зондирование безболезненное, перкуссия вертикальная и горизонтальная болезненная, десна вокруг 2.1 зуба гиперемизированная, отечная, пальпация болезненная. На рентгенограмме определяется гомогенный очаг просветления области проекции верхушки корня 2.1 зуба, округлой формы, диаметром до 0,5*0,5 см, с четкими границами. Поставьте клинический диагноз и определите метод лечения:

- острый гнойный периодонтит, удаление 2.1 зуба
- *обострение хронического гранулематозного периодонтита, эндодонтическое лечение 2.1 зуба
- хронический гранулирующий периодонтит, резекция верхушки корня 2.1 зуба
- хронический гангренозный пульпит, эндодонтическое лечение 2.1 зуба
- хронический фиброзный периодонтит, эндодонтическое лечение 2.1 зуба

95. На прием к врачу-стоматологу обратилась мама с ребенком Д., 7 лет с диагнозом: детский церебральный паралич. При осмотре полости рта: кп + КПУ= 7. Ребенок с выраженным негативным непреодолимым отношением к лечению зубов. Определите вид обезболивания, которое показано ребенку для проведения лечения и удаления зубов:

- аппликационная анестезия
- инфильтрационная анестезия
- проводниковая анестезия
- внутрикостная

*общее обезболивание

96. В клинику обратился ребенок Г., 13 лет с жалобами боли и припухлость в околоушно-жевательной области слева, солоноватый привкус во рту. Из анамнеза: болеет в течение 2 лет, когда периодически появлялась припухлость в левой околоушно-жевательной области. В районной поликлинике проводилось лечение: противовоспалительная, гипосенсибилизирующая терапия, спиртовые компрессы. На фоне проведенного лечения припухлость в околоушно-жевательной области исчезала, но затем появлялась вновь. На контрастной сиалографии: – в паренхиме околоушной слюнной железы определяется расширение протоков II-III порядков в виде «гроздьев винограда» и сужение протоков IV-V порядков. Поставьте клинический диагноз:

- острый вирусный сиалоденит
- хронический паренхиматозный сиалоденит
- *обострение хронического паренхиматозного сиалоденита
- обострение хронического интерстициального сиалоденита
- острый гнойный сиалоденит

97. В клинику обратилась мама с ребенком О., 2 месячного возраста с жалобами на дефект в области верхней губы слева, нарушение питания, дыхания. Патология врожденная. При осмотре: асимметрия лица за счет дефекта верхней губы слева с захватом дна носового хода, укорочение среднего отдела верхней губы, деформация кожно-хрящевого отдела носа слева:

- врожденная полная расщелина верхней губы справа
- врожденная неполная расщелина верхней губы слева
- врожденная скрытая расщелина верхней губы слева
- *врожденная полная расщелина верхней губы слева**
- врожденная неполная расщелина верхней губы справа

98. В поликлинику обратилась мама с ребенком И., 10 месячного возраста с жалобами на отказ от пищи. Со слов мамы, в первой половине беременности у нее был токсикоз. Ребенок находится на искусственном вскармливании. На ночь мама оставляет бутылочку со смесью малышу в кровати. При осмотре полости рта: на вестибулярной и небной поверхностях 5.2, 5.1, 6.1, 6.2 зубов в пришеечной области кариозные полости средней глубины. Эмаль по периферии полостей гладкая, ровная. Дентин пигментированный, плотный. При удалении дентина экскаватором отмечается болезненность в области эмалево-дентинной границы. Поставьте предварительный диагноз и определите степень активности кариозного процесса:

- *средний кариес, компенсированная форма 5.2,5.1,6.1,6.2 зубов**
- поверхностный кариес, субкомпенсированная форма 5.2,5.1,6.1,6.2 зубов
- глубокий кариес компенсированная форма 5.2,5.1,6.1,6.2 зубов
- средне-углубленный кариес субкомпенсированная форма 5.2,5.1,6.1,6.2 зубов
- пришеечный кариес декомпенсированная форма 5.2,5.1,6.1,6.2 зубов

99. В клинику обратился пациент Г., 14 лет, с жалобами боли в 1.6 зубе, возникающие во время приема жесткой и холодной пищи. Из анамнеза: 1.6 был лечен по поводу кариеса, 2 месяца назад пломба частично выпала, появились боли на температурные и механические раздражители. При осмотре полости рта: лицо симметричное. Открывание рта свободное. На жевательной поверхности 1.6 зуба имеется глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином и остатками пломбы из амальгамы, резкая боль при зондировании по дну кариозной полости, реакция на холодное кратковременная, перкуссия безболезненная, ЭОД =10 мкА. Поставьте предварительный диагноз и определите методы диагностики:

- средний кариес 1.6 зуба, рентгенография и пальпация
- поверхностный кариес 1.6 зуба, перкуссия и ЭОД
- *глубокий кариес 1.6 зуба, термодиагностика и ЭОД**
- средне-углубленный кариес 1.6 зуба, окрашивание и рентгенография
- пришеечный кариес 1.6 зуба, зондирование и рентгенография

100. В клинику обратился пациент К., 15 лет, с жалобами на наличие белого пятна в пришеечной области 3.3 зуба. Из анамнеза: пятно появилось полгода назад, с течением времени увеличилось в размере. При осмотре полости рта: в пришеечной области 3.3 зуба определяется меловидное пятно с матовым оттенком. Эмаль тусклая. Пятно окрашивается 2% раствором метиленового синего. Реакция на температурные раздражители отрицательная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод лечения:

- средний кариес 3.3 зуба, пломбирование
- *начальный кариес 3.3 зуба, реминерализующая терапия**
- глубокий кариес 3.3 зуба, пломбирование

- средне-углубленный кариес 3.3 зуба, реставрация
- пришеечный кариес 3.3 зуба, аппликации

101. В детскую стоматологическую поликлинику обратилась мама с ребенком О., 5 лет для профилактического осмотра. При осмотре полости рта: слизистая оболочка бледно-розовая, умеренно увлажнена, без видимых патологических изменений. ИГ =1,9. На контактных поверхностях 8.4 и 8.5 зубов кариозные полости в пределах эмали и дентина, зондирование слабо болезненное по эмалево-дентинному соединению, перкуссия безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите степень активности кариозного процесса:

***средний кариес 8.4,8.5 зубов, компенсированная форма**

- поверхностный кариес 8.4,8.5 зубов, субкомпенсированная форма
- глубокий кариес 8.4,8.5 зубов, декомпенсированная форма
- средне-углубленный кариес 8.4,8.5 зубов, субкомпенсированная форма
- пришеечный кариес 8.4,8.5 зубов, субкомпенсированная форма

102. В клинику обратилась мама с ребёнком Д., 9 лет, с жалобами на косметический дефект зубов. При осмотре полости рта: жевательные бугры 1.6, 1.5, 2.5, 2.6, 3.6, 4.6 зубов имеют шиповидную форму, травмируют слизистую оболочку языка и щёк. Эмаль на указанных зубах истончена, имеются сколы. По режущему краю всех зубов имеются борозды, идущие горизонтально, параллельно режущему краю. Дно и стенки борозд гладкие, плотные, на дне глубоких борозд виден мягкий зубной налёт. Поставьте предварительный диагноз:

- кариес в стадии пятна
- флюороз, меловидно-крапчатая форма
- флюороз, штриховая форма

***системная гипоплазия, бороздчатая форма**

- системная гипоплазия, пятнистая форма

103. На сайте стоматологической клиники был задан вопрос анонимным пациентом: «Уважаемый доктор! У моего восьмилетнего сына верхние центральные зубы имеют бочкообразную форму. По режущему краю имеется выемка полулунной формы. У десны зубы кажутся большими, чем у края. Почему у ребёнка такие зубы и что нам делать?» Поставьте предварительный диагноз и определите болезнь матери, перенесенную во время беременности:

- гиперплазия эмали, анемия у матери
- флюороз, меловидно-крапчатая форма, гиповитаминоз у матери
- флюороз, штриховая форма, гистоз у матери
- зубы Турнера, травма у матери

***зубы Гетчинсона, сифилис у матери**

104. В стоматологическую поликлинику обратилась мама с ребенком Ж., 4 лет, с жалобами на самопроизвольные боли в зубе нижней челюсти слева, ночные боли с короткими светлыми промежутками в течение 1,5 дней, боли усиливаются от холодного. При осмотре полости рта: слизистая оболочка в области 7.5 зуба гиперемированная. На жевательной поверхности 7.5 зуба имеется глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином. После удаления дентина экскаватором зондирование дна полости болезненное, реакция на холод длительная, перкуссия безболезненная. Имеется 3 степень активности кариеса (кп = 9). Поставьте предварительный диагноз:

***острый общий пульпит 7.5 зуба**

- острый частичный пульпит 7.5 зуба
- острый периодонтит 7.5 зуба
- обострение хронического пульпита 7.5 зуба
- обострение хронического периодонтита 7.5 зуба

105. В клинику обратился ребенок Т., 12 лет, с жалобами на ноющие боли в 2.6 зубе. При осмотре полости рта: слизистая оболочка в области 2.6 бледно-розового цвета. На мезиально-жевательной поверхности 2.6 зуба имеется глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином, полость зуба вскрыта, зондирование болезненное, реакция на холод длительная, перкуссия безболезненная, ЭОД = 20 мА. Поставьте предварительный диагноз

- острый общий пульпит 2.6 зуба
- острый частичный пульпит 2.6 зуба
- острый периодонтит 2.6 зуба
- *обострение хронического пульпита 2.6 зуба**
- обострение хронического периодонтита 2.6 зуба

106. В клинику обратился ребенок К., 15 лет, с жалобами на выпадение пломбы в 2.4 зубе, изменение его в цвете. Из анамнеза: 2.4 зуб ранее лечен по поводу кариеса, пломба выпала 1 неделю назад. При осмотре полости рта: слизистая оболочка в области 2.4 зуба бледно-розового цвета. На жевательной поверхности 2.4 зуба имеется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Пульпа зуба некротизирована, зондирование вскрытой полости зуба, перкуссия и реакция на температурные раздражители безболезненные. ЭОД=100мкА. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- хронический фиброзный пульпит 2.4 зуба, одонтометрия
- хронический гранулематозный периодонтит 2.4 зуба, сиалогграфия
- *хронический фиброзный периодонтит 2.4 зуба, рентгенография**
- хронический гранулирующий периодонтит 2.4 зуба, реопародонтография
- обострение хронического периодонтита 2.4 зуба, миография

107. В клинику обратился пациент С., 26 лет с жалобами на неправильное положение зубов, боли при жевании в правом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). При осмотре: средняя линия зубной дуги нижней челюсти смещено вправо на 2,5 мм. Отсутствует 4.6 зуб, вестибулярно расположены 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубы. На компьютерной томографии - мезиальное смещение головки нижней челюсти в левом височно-нижнечелюстном суставе. Поставьте клинический диагноз и определите технику лечения:

- язычное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, рубцовый анкилоз ВНЧС
- глубокий прикус, костный анкилоз ВНЧС
- перекрестный прикус, артроз ВНЧС
- *вестибулярное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, дисфункция ВНЧС**
- прямой прикус, ретрогения

108. В клинику обратилась пациентка А., 13 лет с жалобами на нарушение эстетики лица, некрасивые зубы. Объективно: лицо симметричное. Открывание рта свободное. Резцы верхней челюсти перекрывают резцы нижней челюсти на 8 мм, сагитальная щель между резцами 11мм, дистоокклюзия в боковых участках зубных рядов. Тремы между передними зубами верхней челюсти. Имеется некариозное поражение эмали на вестибулярной поверхности передних зубов верхней челюсти. Поставьте предварительный диагноз:

- язычное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, кариес цемента
- мезиоокклюзия, острый гнойный пульпит
- перекрестный прикус, острый гнойный периодонтит
- открытый прикус, кариес дентина
- *глубокое резцовое перекрытие, гипоплазия эмали

109. В клинику обратился пациент К., 25 лет с жалобами на неправильное положение зубов, боли при жевании в правом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). При осмотре: асимметрия лица за счет увеличения околоушно-жевательной мышцы справа. Средняя линия зубной дуги нижней челюсти смещено вправо на 1,5 мм. Отсутствует 4.6 зуб, вестибулярно расположены 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубы. Анализ записи показал, что причинами изменений были аномалии смыкания зубных рядов, нарушения ВНЧС и функции жевательных мышц. На компьютерной томографии - мезиальное смещение головки нижней челюсти в левом височно-нижнечелюстном суставе.

Определите технику ортодонтического лечения:

- несъемная вестибулярная техника
- съемные ретейнеры
- *несъемная ортодонтическая техника «прямая дуга»
- аппараты трансфорсы W. Clark
- аппараты Spring jet

110. В клинику обратился ребенок И., 8 лет с жалобами на нарушение жевания. Из анамнеза: состояние после хейло-урано-стафиллопластики. При осмотре: осанка нарушена – имеется искривление позвоночника. Асимметрия лица за счет недоразвития верхней челюсти. Открывание рта свободное, отсутствует верхний боковой резец слева. Имеется межзубное положение кончика языка. На рентгенограмме кисти руки установлена запоздавшая оссификация скелета на 2 года.

Поставьте диагноз и определите технику ортодонтического лечения:

- *мезиоокклюзия, регулятор функций Френкеля III типа
- дистоокклюзия, съемные ретейнеры
- открытый прикус, несъемная ортодонтическая техника «прямая дуга»
- перекрестный прикус, аппараты трансфорсы W. Clark
- глубокий прикус, аппараты Spring jet

111. Для ускорения ортодонтического лечения выраженных зубочелюстных аномалий и деформаций, а также получения более эффективных и устойчивых результатов, показано предварительное хирургическое вмешательство:

- остеосинтез
- *компактостеотомия
- остеоперфорация
- периостотомия
- артропластика

112. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при нормальной окклюзии и резко выраженном тесном положении передних зубов на $6,7 \pm 0,84$ мм, при дистоокклюзии на $6,4 \pm 0,93$ мм, при мезиоокклюзии на $6,3 \text{ мм} \pm 0,91$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- лечения отдельных зубов
- лечения боковых резцов

- удаления клыков
- *удаления отдельных зубов
- удаления моляров

113. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при нормальной окклюзии и резко выраженном тесном положении передних зубов на $6,7 \pm 0,84$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- лечения отдельных зубов
- лечения боковых резцов
- удаления клыков
- удаления отдельных зубов
- *удаления моляров

114. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при дистоокклюзии на $6,4 \pm 0,93$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- лечения отдельных зубов
- лечения боковых резцов
- удаления моляров
- удаления клыков
- *удаления отдельных зубов

115. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при мезиоокклюзии на $6,3\text{мм} \pm 0,91$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- *удаления отдельных зубов
- лечения боковых резцов
- удаления клыков
- лечения отдельных зубов
- удаления моляров

116. Укорочение трех сегментов (переднего, среднего, заднего) до $6,7 \pm 0,84$ мм. верхней челюсти, расположение зачатков клыков впереди резцового канала и уменьшение ретромолярного пространства на нижней челюсти являются показаниями к нормализации прикуса путем удаления на соответствующей челюсти:

- вторых временных моляров и зачатков первых моляров
- *первых временных моляров и зачатков первых премоляров
- временных клыков и зачатков вторых моляров
- временных центральных резцов и зачатков первых моляров
- временных боковых резцов и зачатков третьих моляров

117. В мезиальном прикусе гнатической разновидности у девочек в возрасте 11 лет и у мальчиков 13 лет, с целью задержки развития нижнего зубного ряда при адентии аналогичных верхних зубов, целесообразно удаление:

- зачатков первых моляров в младшем школьном возрасте
- зачатков первых премоляров в старшем школьном возрасте
- *зачатков нижних третьих моляров в препубертатном периоде

- зачатков вторых премоляров в среднем школьном возрасте
- зачатков вторых моляров в дошкольном возрасте

118. В клинику обратился ребенок А., 14 лет. Диагноз: состояние после хейло-урано-стафиллопластики, мезиальный прикус. В мезиальном прикусе, обусловленном сквозным несращением верхней губы, альвеолярного отростка и неба слева, целесообразно удаление:

***зачатков третьих моляров в препубертатном периоде**

- зачатков первых премоляров в старшем школьном возрасте
- зачатков первых моляров в младшем школьном возрасте
- зачатков вторых премоляров в среднем школьном возрасте
- зачатков вторых моляров в дошкольном возрасте

119. Хронические воспалительные процессы вокруг дистального корня второго временного моляра, могут быть причиной изменения угла наклона продольной оси:

- второго моляра до его прорезывания
- третьего моляра до его прорезывания

***первого моляра до его прорезывания**

- второго премоляра до его прорезывания
- первого премоляра до его прорезывания

120. Корпусное и наклонное смещение зубов, укорочение зубного ряда, смещение постоянного первого моляра мезиально в более узкую часть зубной дуги развиваются, в результате удаления больше чем за 1 год до периода их физиологической смены:

- временного клыка
- временного бокового резца
- временного центрального резца
- временных премоляров

***временных моляров**

121. Несоответствие длины альвеолярной дуги нижней челюсти, более чем на 4 мм, при прорезывании боковых резцов и смещении средней линии на эту сторону является показанием для удаления:

- временных резцов
- временных моляров

***временных клыков**

- постоянных резцов
- постоянных моляров

122. Пациент 17 лет, жалобы на эстетический недостаток, травму слизистой оболочки в области зубов 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, боли в ВНЧС. Оценка лицевых параметров: асимметрия лица не отмечена, высота нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя -66 мм, в положении ЦО- 60 мм, величина угла нижней челюсти слева и справа – 125°. При объективном обследовании полости рта: верхний зубной ряд интактный, на нижней челюсти отсутствуют зубы 36, 3.5, 4.6. Глубина резцового перекрытия на 2/3 длины нижних резцов, слизистая оболочка в области зубов 2.1, 1.2 гиперемирована, отечна, при дотрагивании кровоточит, зубо-десневое прикрепление не нарушено. Соотношение первых моляров: медиальный бугор первого верхнего моляра находится

на уровне между вторым премоляром и первым моляром, бугровое смыкание клыков. Ваш диагноз

· Мезиальная окклюзия, глубокая резцовая дизокклюзия

***Дистальная окклюзия, глубокий прикус**

· Ортогнатический прикус

· Трансверсальная окклюзия

· Открытый прикус

123. Ребенку 7 лет. При осмотре уздечка губы имеющая вид широкого тяжа, вплетающего в межзубной сосочек. Имеется щель между центральными резцами 2 мм. Какой метод лечения?

· хирургический

· аппаратный

· миогимнастика

***хирургический + аппаратный**

· миогимнастика + аппаратный

124. Ребенок 8 лет. В полости рта: при смыкании зубных рядов определяется сагиттальная щель 6 мм, коронки 6/6 разрушены. Поставьте диагноз.

***глубокое резцовое перекрытие**

· перекрестному

· прогнатическому

· ортогнатическому

· прямому

125. Пациент 15 лет, предъявляет жалобы на наличие щели между передними зубами. При внешнем осмотре губы смыкаются с напряжением, на подбородке – симптом наперстка. В полости рта: во фронтальном отделе вертикальная щель 3мм. Какой из нижеперечисленных методов лечения целесообразно провести в первую очередь?

· Нормализация резцового перекрытия

· Нормализация формы зубных рядов

***Нормализация функции глотания и дыхания**

· Расширение верхней челюсти

· Дистализацию моляров

126. Пациент 10 лет, предъявляет жалобы на наличие щели между передними зубами. В полости рта: отсутствуют 12, 22 зубы, расстояние между 11 и 21 зубами 4 мм, на рентгенограмме отсутствуют зачатки 12, 22 зубов. Какой предварительный диагноз наиболее вероятен?

· Диастема, тортоаномалия

· Диастема, транспозиция

· Диастема, ретенция

***Диастема, адентия**

· Диастема, тремы

127. Девочка 13 лет, предъявляет жалобы на не красивый внешний вид. При внешнем осмотре определяется удлинение нижней трети лица, круговые мышцы рта напряжены, подбородок скошен кзади. В полости рта: сагиттальная щель 6 мм, вертикальная щель 4 мм, в боковых участках контакт одноименных зубов. Поставьте предварительный диагноз:

***Прогнатический открытый прикус**

- Прогнатический глубокий прикус
- Прогенический открытый прикус
- Прогенический глубокий прикус
- Перекрестный прикус

128. Ребенок 7 лет. Направлен к ортодонту школьным стоматологом после санации полости рта. При внешнем осмотре определяется незначительная асимметрия лица. В полости рта: сменный прикус, в боковых участках незначительное обратное перекрытие. Какая тактика ведения пациента является целесообразным?

***Сошлифовка бугорков временных моляров**

- Подбородочная праща с косой тягой
- Расширение верхнего зубного ряда
- Устранение вредных привычек
- Консультация ЛОР-врача

129. Ребенку 8 лет. Лицо симметричное, мезоцефалического типа. Профиль - прямой. При осмотре полости рта: сменный прикус, нейтральная окклюзия, двустороннее сужение верхнего зубного ряда. Какая тактика лечения из перечисленных ниже является наиболее целесообразной?

- Санация полости рта

***Пластика с расширяющим винтом**

- Удаление временных зубов
- Брекет-система
- Рациональное протезирование

130. Ребенку 5 лет. Жалобы родителей на вредную привычку: сосание большого пальца левой руки. Лицо без особенностей, дыхание - смешанное. Между резцами вертикальная щель - 2 мм. Какой план лечебных мероприятий из перечисленных ниже является наиболее целесообразным?

- Миогимнастика, протезирование

***Устранение вредных привычек, нормализация функции дыхания**

- Удаление передних зубов, нормализация функции дыхания
- Несъемные ортодонтические аппараты, массаж
- Компактостеотомия, несъемные ортодонтические аппараты

131. Мальчик, 12 лет. Жалобы родителей на неправильный прикус. Объективно: лицо симметричное, профили - прямой. При осмотре полости рта: смыкание моляров по II классу, кривая Шпее резко выражена, верхние резцы перекрывают нижние на 2/3 высоты коронок. Какой план лечебных мероприятий из перечисленных ниже является наиболее целесообразным?

- Зубоальвеолярное удлинение передних зубов
- Стимулирование роста верхней челюсти
- Торможение роста нижней челюсти

***Зубоальвеолярное удлинение боковых зубов**

- Сокращение размера верхней челюсти

132. Укажите среди перечисленных признаков, наиболее характерный для формирующегося мезиального соотношения зубных рядов в периоде временного прикуса:

- Краевое смыкание резцов

- Язычный наклон резцов на нижней челюсти
- Сужение верхнего зубного ряда
- *Нестершиеся бугры временных клыков**
- Привычка выдвигать нижнюю челюсть влево

133. Пациент 12 лет. Объективно: 1.3 и 2.3 зуба вне зубной дуги, в вестибулярном положении.

Была изготовлена расширяющая пластинка с М-образными кламмерами по всей площади коронок 1.3 и 2.3 зуба на вестибулярной дуге. Укажите характер перемещения зубов:

- Наклонное перемещение
- *Корпусное перемещение**
- Перемещение вокруг продольной оси
- Вертикальное перемещение
- Перемещение корней зубов

134. Девушка 18 лет, предъявляет жалобы на нарушение откусывания пищи. Объективно: профиль выпуклый, подбородок скошен. В полости рта: диастемы, тремы между фронтальными зубами, сагиттальная щель 7 мм; нарушение смыкания моляров – 3 мм. Какой план лечебных мероприятий из ниже перечисленных является наиболее первоочередным?

- *Ретрагирование верхних фронтальных зубов**
- Протрагирование верхних фронтальных зубов
- Дистализация 16, 26 зубов, выдвижение нижней челюсти
- Выдвижение нижней челюсти вперед
- Сокращение размера зубного ряда

135. Ребенок, 3 года. Мама жалуется на западение верхней губы, подсасывание ее. У ребенка имеется вредная привычка постоянно выдвигать нижнюю челюсть вперед. При осмотре лица отмечается вогнутый профиль лица, углубление носогубных складок. Какая патология прикуса возникнет у ребенка без должного ортодонтического лечения?

- Открытый
- Перекрестный
- Прогнатический
- *Прогенический**
- Глубокий

136. Девочка, 10 лет. В течение двух месяцев находится на лечении по поводу небного положения 12 зуба. Лечение проводится при помощи пластинки с секторальным распилом, винтом и разобщением на боковых зубах. В настоящее время аномалийное положение 1.2 зуба устранено. Какой ортодонтический аппарат целесообразно применить для закрепления результатов лечения?

- изготовление пластинки с винтом
- изготовление пластинки с рукообразными пружинами
- *ретенционный аппарат**
- подбородочная праща с головной шапочкой
- аппарат Персина

137. Пациентке 10 лет. Находится на лечении у ортодонта по поводу тортаномалии 4.2 зуба. В настоящее время активный этап лечения закончен и Пациенту изготовлен ретенционный аппарат

следующей конструкции: съемная пластинка с вестибулярной дугой. Укажите необходимый срок ретенционного периода:

- 3 месяца
- *полгода**
- 1 год
- 2 года
- 3 года

138. В клинику обратился пациент К., 25 лет с жалобами на разрушение коронки 2.6 зуба. При осмотре: на окклюзионной поверхности зуба имеется дефект 0,3*0,3см. Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ) составляет 30%. Поставьте предварительный диагноз и определите метод ортопедического лечения:

- малый дефект коронки 2.6 зуба, искусственная коронка
- *средний дефект коронки 2.6 зуба, вкладки**
- большой дефект коронки 2.6 зуба, штифты
- полный дефект коронки 2.6 зуба, виниры
- кариес 2.6 зуба, пломбирование 2.6 зуба

139. В клинику обратился пациент А., 27 лет с жалобами на разрушение коронки 1.6 зуба. При осмотре: на окклюзионной поверхности зуба имеется дефект 0,1*0,2см. Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ) составляет 15%. Поставьте предварительный диагноз и определите метод ортопедического лечения:

- *малый дефект коронки 1.6 зуба, пломбирование коронки**
- средний дефект коронки 1.6 зуба, искусственная коронка
- большой дефект коронки 1.6 зуба, штифты
- полный дефект коронки 1.6 зуба, виниры
- кариес 1.6 зуба, вкладки

140. В клинику обратился пациент С., 30 лет с жалобами на разрушение коронки 3.6 зуба. При осмотре: на окклюзионной поверхности зуба имеется дефект 0,7*0,7см. Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ) составляет 70%. При зондировании имеется сообщение с полостью зуба. Поставьте предварительный диагноз и определите метод ортопедического лечения:

- малый дефект коронки 3.6 зуба, пломбирование коронки
- большой дефект коронки 3.6 зуба, искусственная коронка
- *большой дефект коронки 3.6 зуба, вкладка с искусственной коронкой**
- полный дефект коронки 3.6 зуба, виниры
- кариес 3.6 зуба, вкладки

141. В клинику обратился пациент Е., 27 лет с жалобами на разрушение коронки 4.7 зуба. При осмотре: на окклюзионной поверхности зуба имеется дефект 0,9*0,9см. Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ) составляет 90%. При зондировании имеется сообщение с полостью зуба. Поставьте предварительный диагноз и определите метод ортопедического лечения:

- малый дефект коронки 4.7 зуба, пломбирование коронки
- средний дефект коронки 4.7 зуба, виниры
- большой дефект коронки 4.7 зуба, искусственная коронка

***полный дефект коронки 4.7 зуба, штифтовые зубы**

- кариес 4.7 зуба, вкладки

142. В клинику обратился пациент Ю., 28 лет с жалобами на отсутствие зубов. При осмотре: на нижней челюсти отсутствуют все жевательные зубы слева и два центральных резца. Поставьте предварительный диагноз, согласно классификации Кеннеди:

- дефект зубного ряда по II классу
- дефект зубного ряда по III классу
- дефект зубного ряда II класс III подкласс
- *дефект зубного ряда II класс IV подкласс**
- дефект зубного ряда I класс II подкласс

143. В клинику обратился пациент С., 35 лет с жалобами на отсутствие зубов. При осмотре: на нижней челюсти отсутствуют 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 зубы и 3.1, 4.1 зубы. Поставьте предварительный диагноз, согласно классификации Кеннеди:

- *дефект зубного ряда II класс IV подкласс**
- дефект зубного ряда III класс
- дефект зубного ряда II класс III подкласс
- дефект зубного ряда III класс I подкласс
- дефект зубного ряда I класс II подкласс

144. В клинику обратился пациент А., 37 лет с жалобами на отсутствие зубов. При осмотре: на верхней челюсти отсутствуют 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 зубы. Поставьте предварительный диагноз, согласно классификации Кеннеди:

- дефект зубного ряда II класс I подкласс
- *дефект зубного ряда IV класс**
- дефект зубного ряда III класс
- дефект зубного ряда III класс I подкласс
- дефект зубного ряда I класс II подкласс

145. В клинику обратился пациент М., 36 лет с жалобами на отсутствие зубов. При осмотре: на нижней челюсти отсутствуют 3.4, 3.5, 3.6 зубы. Поставьте предварительный диагноз, согласно классификации Кеннеди:

- дефект зубного ряда II класс I подкласс
- дефект зубного ряда IV класс
- *дефект зубного ряда III класс**
- дефект зубного ряда III класс I подкласс
- дефект зубного ряда I класс II подкласс

146. В клинику обратился пациент К., 37 лет с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. При осмотре: асимметрия лица за счет западения верхней губы, опущение углов рта. Открывание рта свободное, альвеолярный отросток верхней челюсти высокий, равномерно покрытый плотной слизистой оболочкой. Хорошо выражены верхнечелюстные бугры, глубокое небо, торус выражен слабо. Определите тип беззубой верхней челюсти по Шредеру:

***I тип**

- II тип
- III тип

- IV тип
- V тип

147. В клинику обратился пациент Д., 45 лет с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. При осмотре: асимметрия лица за счет западения верхней губы, опущение углов рта. Открывание рта свободное, отмечается средняя степень атрофии альвеолярного отростка, умеренно выражены верхнечелюстные бугры, средней глубины небо, торус выражен. Определите тип беззубой верхней челюсти по Шредеру:

- I тип
- *II тип**
- III тип
- IV тип
- V тип

148. Пациент обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на боли под протезом. Объективно: наклон опорного зуба в дистальном направлении, внедрение промежуточного тела в слизистую с образованием декубитальной язвы. На рентгенограмме расширение периодонтальной щели опорного зуба в пришеечной трети и половины длины стенки лунки. Исходя из перечисленных данных, какой протез был изготовлен данному пациенту:

- Балочный
- бюгельный
- *консольный**
- мостовидный
- частичный съемный

149. Каким критериям должны соответствовать по отношению к шейке опорного зуба при припасовки цельнолитой коронки

- на уровне анатомической шейки зуба
- на уровне клинической шейки зуба
- погружается под десну на 0,4мм
- *погружается под десну на 0,2 мм.**
- погружается под десну на 0,1мм

150. Какое осложнение может возникнуть, если при протезировании культевым штифтовым зубом по Ахмедову, глубину погружения штифт сделать на 1/3 длины канала:

- подвижность антагониста
- *расцементировка штифта**
- отлом коронковой части
- воспалительные изменения в периодонте
- воспалительные изменения в краевой десне

151. Какое осложнение может возникнуть после протезирования штифтовым зубом по Ильиной-Маркосян, если кубической формы вкладка неплотно прилежит к сформированной полости в устье корневого канала:

- подвижность антагониста
- отлом коронковой части
- *расцементировка штифта**

- воспалительные изменения в периодонте
- воспалительные изменения в краевой десне

152. Беспрепятственное наложение пластиночного протеза на этапе его припасовки может быть затруднено, вследствие:

- занижения высоты нижнего отдела лица
- завышения высоты нижнего отдела лица
- ошибки при постановке искусственных зубов
- дефектов базиса при недопаковке пластмассы

***прилегания базисной пластмассы к шейкам зубов**

153. Определить положительные стороны изготовления цельнолитых металлических вкладок прямым и косвенным способом по сравнению с пломбами?

- Эстетичнее;
- Плотноекраевое прилегание
- Минимальное одонтопрепарирование зубов

***Восстанавливают жевательную поверхность, контактный пункт, за счет прочности конструкционных материалов не скалывается в области жевательных зубов;**

- Отсутствие аллергических реакций;

154. При оздоровительной подготовке полости рта, в случаях одномоментного удаления нескольких зубов, фиксирующих прикус и с целью предупреждения функциональной перегрузки оставшихся зубов, необходимо исключить:

- шинирование
- депульпирование

***изготовить иммедиат-протез**

- резекция верхушек корней
- лечение «Вектор» терапией

155. Для фиксации отломков, какой шиной необходима предварительная сепарация контактных поверхностей клыков и первых моляров:

- Порта
- *Шура**
- Вебера
- Збаржа
- Ванкевич

156. При шинировании зубов армирующим композитным волокном, после установления коффердама, в межзубные промежутки вводят деревянные клинышки. Для чего проводится данная процедура

- предотвратить отрыв реставрации
- предотвратить краевое окрашивание композита

***сохранить десневые сосочки от попадания жидкого композита**

- создать пространство для физиологической подвижности
- исключить подвижность зубов после шинирования

157. Пациент 50 лет, обратился в стоматологическую клинику с жалобами на невозможность пережевывания пищи. Высота коронок оставшихся зубов: 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 стерта на 2/3. Утолщение альвеолярного отростка в области стертых зубов нет. Определите тип прикуса в данной клинической ситуации:

***нефиксированный**

- бипрогнатический
- опистогнатический
- ортогнатический
- прямой

158. У пациента 68 лет при осмотре полости рта врач стоматолог ортопед поставил диагноз: "Дефект зубного ряда на нижней челюсти 3-класс по Кеннеди". Выбрана конструкция: съемный мостовидный протез с опорами на 37 и 33 зубы. В следствии каких причин рекомендована данная конструкция мостовидного протеза?

- из-за подвижности опорных зубов, ограничивающих дефект
- из-за включенного бокового дефекта зубного ряда

***из-за большой протяженности дефекта зубного ряда**

- из-за глубокого прикуса, при смыкании зубов
- из-за больших конвергенций зубов, ограничивающих дефект

159. На момент наложения и сдачи полного протеза объективно выявлено западение верхней губы. Какая была допущена ошибка:

- постановка зубов переднего отдела на приточке
- определена передняя окклюзия на втором клиническом этапе

***не сформирован вестибулярный овал прикусного валика в профиле лица**

- вестибулярный овал прикусного валика определен по красной кайме губ
- изготовление прикусных валиков без учета атрофии альвеолярного отростка

160. Пациентка год назад обратилась с жалобами на отсутствие жевательных зубов, повышенную чувствительность на термические и химические раздражители во фронтальных зубах нижней челюсти, на которых были выявлены кратерообразные фасетки стирания. Врачом стоматологом ортопедом было изготовлено два металлокерамических мостовидных протеза с опорой на 1.6, 1.3, 1.1 и 2.6, 2.3, 2.2, 2.1 зубы. Через год после фиксации металлокерамических мостовидных протезов пациентка повторно обратилась с жалобами на стирание зубов на 1/2. Назовите причину повторного обращения. Коронки, каких зубов стерлись на 1/2:

- нефиксированная высота прикуса; премоляры и моляры

***повышенное стирание; антагонисты металлокерамики**

- функциональная перегрузка; фронтальные зубы нижней челюсти
- деформация окклюзионной поверхности зубов; все зубы нижней челюсти
- физиологическое стирание эмали и дентина; антагонисты металлокерамики

161. Врач стоматолог-ортопед после осмотра полости рта пациента 52 лет, рекомендует бюгельный протез на нижнюю челюсть. При анализе гипсовой модели в параллелометре, предлагает изготовить 5-тип опорно-удерживающего кламмера системы Нея. Укажите дефект зубного ряда больного?

- двухсторонний концевой дефект-ограничен премолярами
- односторонний концевой дефект-ограничен премолярами

***включенные дефекты в боковом отделе с одиночно стоящими молярами**

- включенные дефекты в переднем отделе с одиночно стоящими премолярами
- одиночно стоящие премоляры на верхней и нижней челюсти

162. Какие конструкции несъемного протезирования применяются при патологической стираемости и некариозных поражениях?

- искусственные коронки;
- мостовидные протезы

***вкладки, виниры, полукоронки**

- дентальные импланты;
- адгезивные мостовидные протезы

163. Какая патология зубочелюстной системы является относительным противопоказанием для имплантации?

- Наличие ограниченных включенных дефектов зубного ряда
- Полное отсутствие зубов
- Заболевания ЖКТ., обусловленные утратой зубов и нарушением пережевывания пищи

***Патологический прикус**

- Отсутствие одного зуба во фронтальном отделе

164. У пациента 25 лет дефект коронковой части 1.1 зуба, 4 класс по Блэку перед протезированием на приеме у врача стоматолога – ортопеда первый клинический этап изготовления металлокерамической коронки состоит из:

- обследование, постановка диагноза, выбор конструкции протеза, препарирование зуба, обезболивание, снятие двухслойного слепка

***обследование, рентген снимок, постановка диагноза, выбор конструкции, обезболивание, препарирование, формирование уступа, ретракция зубодесневого края, снятие двухслойного слепка**

- постановка диагноза, выбор конструкции, обезболивание,препарирование уступа, снятие двухслойного слепка
- обследование, постановка диагноза, выбор конструкции, формирование уступа, препарирование зуба, ретракция зубодесневого края, снятие слепка
- обследование, снятие слепка, препарирование зуба

165. После одонтопрепарирования 2.3 зуба под металлокерамическую коронку перед снятием двухслойного оттиска необходимо:

- тщательное высушивание

***ретракция тканей десны**

- уточнение границы коронки
- точный отпечаток пришеечной части зуба
- защита зуба от химических и температурных раздражителей

166. При лечении вертикальной деформации нижнего зубного ряда справа в 2 мм частичными съемными пластиночными протезами на верхнюю и нижнюю челюсти, на этапе проверки восковой конструкции обнаружено, что при центральном смыкании между искусственными зубами спереди имеется щель около 2 мм, в то время как естественные зубы в боковом отделе справа и искусственные слева плотно смыкаются. Когда и какая была допущена ошибка:

- первый клинический этап, определена центральная окклюзия

- второй клинический этап, определена дистальная окклюзия
- *второй клинический этап, определена передняя окклюзия**
- второй клинический этап, определена боковая окклюзия
- первый лабораторный этап, определена боковая окклюзия

167. При каком переломе проводят лечение зубодесневой шиной Вебера:

- *верхней челюсти со смещением отломков книзу при неповрежденной нижней челюсти**
- верхней челюсти со смещением отломков книзу при поврежденной нижней челюсти
- при переломе альвеолярного отростка нижней челюсти без смещения
- при полном отрыве верхней челюсти со смещением ее кзади
- альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых отделах

168. У пациента 3., 65 лет, после огнестрельного ранения, при протезировании срединных дефектов твердого неба при наличии зубов используют:

- *на небной стороне протеза создают валик высотой 1 мм для создания замыкающего клапана по периферии дефекта**
- на небной стороне протеза создают валик высотой 8 мм для создания замыкающего клапана
- на базисе obturating части
- obturator, высоко входящий в полость носа
- полый obturator

169. Какой цвет маркировки имеют алмазные боры с низкой степенью абразивности, используемые на этапе окончательного препарирования и шлифования уступа, скосов, фланцев:

- *красным**
- зеленый
- черный
- синий
- белым

170. В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент 55 лет с отсутствием зуба 1.1. Остальные зубы интактные. В анамнезе — две недели назад выписался из стационара по поводу инфаркта миокарда. Ваша тактика по ведению больного:

- отказать пациенту в ортопедической помощи
- препарировать под мостовидный протез с опорой на 1.2, 2.1
- препарировать под консольный мостовидный протез с опорой на 2.1
- препарировать под консольный мостовидный протез с опорой на 1.2
- *изготовить временный съемный пластиночный протез, сроком на полгода**

171. В клинику обратился ребенок П., 5 лет с жалобами на боли и припухлость в области верхней челюсти слева, слабость, недомогание. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей верхней челюсти слева. В данной области имеется инфильтрат 2.0x1.5см. Кожные покровы над ним гиперемизированные. Открывание рта болезненное. Коронка 6.4 зуба разрушена на ½, перкуссия болезненна. Переходная складка на уровне 6.3, 6.4, 6.5 зубов сглажена, гиперемизирована, отечна, напряжена, пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод хирургического лечения:

- обострение хронического периодонтита 6.4 зуба, удаление 6.4 зуба
- острый гнойный периодонтит, резекция верхушки корня 6.4 зуба

- острый гнойный остеомиелит от 6.4 зуба, остеоперфорация
- *гнойный периостит верхней челюсти, периостотомия, удаление 6.4 зуба**
- флегмона подчелюстной области от 6.4 зуба, дренирование гнойника

172. В клинику обратился ребенок В., 5 лет с жалобами на боли и припухлость в поднижнечелюстной области справа, повышение температуры тела до 37,5 С, слабость, недомогание. Со слов мамы, ребенок болен в течение 5 суток, когда заболел 8.5 зуб, 2 суток назад появилась припухлость, состояние ухудшилось. Общее состояние средней степени тяжести. Температура-37,4 С, ЧДД-24 в мин, ЧСС-106 в мин. Асимметрия лица за счет отека поднижнечелюстной области справа. В данной области пальпируется инфильтрат 4,0х4,0 см, кожа над ним гиперемирована, отечна, напряжена. Открывание рта болезненно. Коронка 8.5 зуба разрушена на 1/2, перкуссия болезненна. Подъязычный валик справа гиперемированный, отечный, болезненный при пальпации. Поставьте предварительный диагноз:

- флегмона подподбородочной области от 8.5 зуба
- *флегмона поднижнечелюстной области от 8.5 зуба**
- флегмона окологлоточной области от 8.5 зуба
- флегмона подмассетеральной области от 8.5 зуба
- флегмона щечной области от 8.5 зуба

173. В клинику обратился ребенок Р., 5 лет. Врач поставил диагноз: обострение хронического периодонтита от 6.5 зуба. Планируется операция удаление 6.5 зуба под локальной анестезией. Определите вид инструмента для удаления 6.5 зуба и положение врача:

- прямые щипцы, впереди и справа от пациента
- прямой элеватор, впереди и слева от пациента
- универсальные щипцы, впереди и справа от пациента
- *S-образные несходящиеся щипцы с шипом справа, впереди и справа**
- S-образные сходящиеся щипцы, впереди и слева от пациента

174. В клинику обратился ребенок Д., 14 лет с жалобами на боль и припухлость в области верхней челюсти слева. Из анамнеза: болен в течении 2 суток, когда заболел 1.1 зуб. Появилась припухлость. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей в области верхней челюсти слева. Пальпация болезненна. Открывание рта болезненное. Коронка 1.1 зуба разрушена на 1/3. Перкуссия болезненна. Переходная складка сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена, пальпация болезненная. На рентгенограмме: в области верхушки корня имеется расширение периодонтальной щели и гомогенный очаг 0,2х0,2 см, округлой формы. Поставьте предварительный диагноз и определите объем хирургического вмешательства:

- *острый гнойный периостит, периостотомия, лечение 1.1 зуба**
- острый гнойный периодонтит, удаление 1.1 зуба
- острый гнойный остеомиелит, остеоперфорация, удаление 1.1 зуба
- острый гнойный пульпит, лечение 1.1 зуба
- обострение хронического периодонтита, периостотомия, удаление 1.1 зуба

175. В клинику обратился ребенок Ц., 6 лет. Врач поставил диагноз: обострение хронического периодонтита от 8.5 зуба. Планируется операция удаление 8.5 зуба под локальной анестезией. Определите вид инструмента для удаления 8.5 зуба и положение врача:

- прямые щипцы, впереди и справа от пациента
- прямой элеватор, впереди и слева от пациента

- универсальные щипцы, впереди и справа от пациента
- ***клювовидные несходящиеся щипцы, позади и справа от пациента**
- клювовидные сходящиеся щипцы, позади и слева от пациента

176. В клинику обратился ребенок Н., 12 лет с жалобами на боли при жевании, от холодного и горячего в области бокового резца справа. Из анамнеза: ударился во время игры в бокс. При местном осмотре: асимметрия лица за счет отека верхней губы справа. Коронка 1.2 зуба повреждена полностью с захватом корневой части. Отмечается боли от температурных раздражителей. Вскрыта пульповая камера, определяется кровоточивость пульпы. На рентгенограмме: имеется линия перелома на границе корня и коронки зуба. Поставьте предварительный диагноз:

- верхушечный перелом корня 1.2 зуба
- срединный перелом корня 1.2 зуба
- ***коронковый перелом корня 1.2 зуба**
- полный отлом коронки 1.2 зуба
- продольный коронково-корневой перелом 1.2 зуба

177. В клинику обратился ребенок М., 11 лет с жалобами на боли и отек десны нижних зубов. При местном осмотре: лицо симметричное. Открывание рта свободное. Глубина преддверия полости рта составляет 3 мм, нижняя губа малоподвижна во время акта речи. Уздечка нижней губы мало выражена. В области десневого края 3.1, 4.1 зубов имеется гиперемия и болезненность при пальпации. Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического вмешательства:

- короткая уздечка языка, френуллопластика
- короткая уздечка верхней губы, хейлопластика
- деформация альвеолярного отростка, альвеолопластика
- ***мелкое преддверие полости рта, вестибулопластика**
- слизистые тяжи преддверия полости рта, альвеолопластика

178. В клинику обратился ребенок Ж., 12 лет, жалобы на хруст в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) справа во время открывания рта. При осмотре: лицо симметричное. При пальпации височно-нижнечелюстного сустава справа отмечается болезненность, хруст при выдвигании нижней челюсти вправо. Положителен симптом нагрузки в области височно-нижнечелюстного сустава справа. Открывание рта болезненное справа. Прикус нарушен. Уздечка языка в виде толстого, короткого тяжа прикреплена к кончику языка. Имеется скученность 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 зубов. Поставьте предварительный диагноз:

- вторичный деформирующий остеоартроз ВНЧС
- ***болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава справа**
- костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава справа
- рубцовый анкилоз височно-нижнечелюстного сустава справа
- неартроз височно-нижнечелюстного сустава справа

179. Новорожденный М., 2 сутки. Жалобы на дефект в области верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба, нарушение питания, дыхания. Из анамнеза: патология врожденная. Ребенок родился в гипоксии. При осмотре: асимметрия лица за счет дефекта в области верхней губы, продолжающийся на альвеолярный отросток, твердое и мягкое небо. Имеется укорочение среднего отдела верхней губы, деформация кожно-хрящевого отдела носа

справа. Открывание рта свободное. В области неба имеется дефект, сообщающийся с полостью носа. Укорочено мягкое небо, расширен средний отдел глотки. Поставьте предварительный диагноз и определите вид лечения на данный момент:

***полная расщелина верхней губы и неба, ортодонтическое лечение**

- неполная расщелина верхней губы, хейлопластика
- полная расщелина твердого и мягкого неба, ортодонтическое лечение
- полная расщелина мягкого неба, ураностафиллопластика
- неполная расщелина верхней губы и неба, хейлоуранопластика

180. Ребенку М., 14 лет, планируется операция удаление 1.6 зуба под локальной анестезией.

Определите направление и глубину продвижения иглы при проведении туберальной анестезии у ребенка:

- вниз, назад, внутрь на глубину 1,5 см
- назад, внутрь на глубину 2,0 см
- *вверх, вперед, внутрь на глубину 1,5 см**
- вверх, назад, кнаружи на глубину 2,5 см
- вниз, вперед, внутрь на глубину 1,5 см

181. В детскую стоматологическую поликлинику обратилась мама ребенком Д. 6 лет с жалобами на ночные боли в зубе. Из анамнеза: девочка состоит на диспансерном учете у невропатолога по поводу эпилепсии. Девочка плачет, не садится в кресло, отталкивает врача. При осмотре: множественные кариозные полости в зубах 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6. 3, 7.4, 7.5, 8.4, 8.5. Определите метод анестезии, под которой будет проводиться санация полости рта:

- мандибулярная анестезия
- *общее обезболивание**
- туберальная анестезия
- ментальная анестезия
- инфильтрационная анестезия

182. В стоматологическую клинику обратился ребенок Г., 11 лет с жалобами на выпадение пломбы в 2.4 зубе, изменение его в цвете. Из анамнеза: 2.4 зуб ранее лечен по поводу кариеса дентина, пломба выпала неделю назад. Объективно: лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 2.4 зуба имеется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование вскрытой полости зуба, перкуссия безболезненны. Реакция на температурные раздражители отсутствует. ЭОД=100мкА. На рентгенограмме: расширение периодонтальной щели в области верхушки корня зуба. Поставьте клинический диагноз и определите вид лечения:

***хронический фиброзный периодонтит 2.4 зуба, эндодонтическое лечение**

- острый гнойный периостит от 2.4 зуба, периостотомия
- хронический гранулематозный периодонтит 2.4 зуба, удаление
- хронический гранулирующий периодонтит 2.4 зуба, эндодонтическое лечение
- обострение хронического фиброзного периодонтита 2.4 зуба, удаление

183. В клинику обратилась мама ребенком Л., 7 лет с жалобами на дефект коронки 3.6 зуба. При осмотре: Лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 3.6 зуба имеется дефект эмали с захватом дентина 0,1 см Зондирование безболезненное, дно и края полости плотные. Показатели ЭОД = 10 мкА. Поставьте диагноз и определите метод лечения:

- кариес эмали, реставрация стеклоиномером
- кариес цемента, штампованные коронки
- *кариес дентина, реставрация профилактика композитом**
- клиновидный дефект, реставрация амальгаммой
- системная гипоплазия, реставрация фиссурным герметиком

184. В клинику обратилась мама ребенком П., 3 лет с жалобами на периодические боли в 7.5 зубе во время приема пищи, с сохранением болевых ощущений 10 мин. При осмотре: на жевательной поверхности 7.5 зуба имеется кариозная полость, заполненная размягченным дентином. При удалении размягченного дентина, обнажилась пульпа 7.5 зуба. Пульпа кровоточит, при зондировании болезненно, перкуссия безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- хронический периодонтит, ультразвуковое исследование 7.5 зуба
- острый пульпит, магнитно-резонансная томография 7.5 зуба
- острый периодонтит, компьютерная томография 7.5 зуба
- *хронический фиброзный пульпит 7.5 зуба, визиография зуба**
- хронический гангренозный пульпит, ортопантомография

185. В клинику обратилась мама ребенком Ж., 5 лет с жалобами на периодические боли в 8.4 зубе во время приема пищи, с сохранением болевых ощущений 15 мин. При осмотре: на жевательной поверхности 8.4 зуба имеется кариозная полость, заполненная размягченным дентином, коронка зуба изменена в цвете. При удалении размягченного дентина, обнажилась пульпа 8.4 зуба. Пульпа серого цвета, при зондировании болезненно, перкуссия безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- хронический периодонтит, ультразвуковое исследование 8.4 зуба
- острый пульпит, магнитно-резонансная томография 8.4 зуба
- острый периодонтит, компьютерная томография 8.4 зуба
- хронический фиброзный пульпит 8.4 зуба, ортопантомография
- *хронический гангренозный пульпит, визиография зуба**

186. В клинику обратилась мама ребенком Ю., 12 лет с жалобами на быстропроходящие в боли во время приема пищи и на дефект коронки 4.6 зуба. При осмотре: Лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 4.6 зуба имеется кариозная полость заполненная остатками пищи. При зондировании дно болезненное, дно и края полости покрыта размягченным дентином. Реакция на температурный раздражитель выражена слабо. Показатели ЭОД = 12 мкА. Поставьте диагноз и определите метод лечения:

- кариес эмали, ультразвуковое исследование 4.6 зуба
- кариес цемента, окрашивание 4.6 зуба
- *кариес дентина, визиография 4.6 зуба**
- клиновидный дефект, сиалогграфия
- системная гипоплазия, биохимический анализ крови

187. В клинику обратился ребенок 10 лет с жалобами на припухлость в подъязычной области справа. Со слов мамы ребенок болен в течение 6 месяцев, когда появилась припухлость и периодически увеличивалась и вновь уменьшалась. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела -36,4С, ЧДД -20 в мин, ЧСС-88 в мин. Лицо симметричное, открывание рта свободное. В подъязычной области справа пальпируется инфильтрат 3,0х2,0 см, слизистая

оболочка над ним бледно-розового цвета с синюшным оттенком, пальпация безболезненная.

Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического лечения:

- дермоидная киста дна полости рта, цистоэктомия
- ретенционная киста правой слюнной желез, цистотомия
- ретенционная киста околоушно-слюнной железы, цистоэктомия
- *ретенционная киста подъязычной слюнной железы справа, цистотомия**
- ретенционная киста подчелюстно слюнной железы справа, цистоэктомия

188. В клинику обратился ребенок Н. 13 лет с жалобами на боли и припухлость в щечной области слева, повышение температуры тела до 38,5 С, слабость, недомогание. Со слов мамы ребенок болен в течение 5 суток, состояние ухудшилось. Общее состояние средней степени тяжести. Температура тела -38,4С, ЧДД -24 в мин, ЧСС-106 в мин. Лицо симметричное, открывание рта свободное. Асимметрия лица за счет отека в щечной области слева. В данной области имеется инфильтрат 4,0х4,0, кожа над инфильтратом гиперемирована, отечна и напряжена. В центре инфильтрата имеется 4 гнойных стержня, пальпация болезненна. Открывание рта болезненное, слизистая полости рта бледно- розового цвета. Поставьте предварительный диагноз и определите вид разреза:

- флегмона щечной области слева, разрез по нижнему краю инфильтрата
- абсцедирующий фурункул щечной области слева, разрез по центру инфильтрата
- лимфаденит щечной области слева, разрез по нижнему краю инфильтрата
- целлюлит щечной области слева, разрез по верхнему краю инфильтрата
- *карбункул щечной области слева, крестообразный разрез**

189. Ребенку 11 лет. Жалоб нет. В полости рта: 1.6 зуб изменен в цвете, на жевательной поверхности полость, заполненная пищевыми остатками. Зондирование устьев корневых каналов слабо болезненно, определяется распад в виде маркового налета, неприятный запах. Перкуссия безболезненна. На рентгенограмме корни сформированы, в околокорневых тканях патологических изменений нет. Поставьте предварительный диагноз.

- Хронический фиброзный периодонтит
- Хронический фиброзный пульпит
- Хронический гранулирующий периодонтит
- *Хронический гангренозный пульпит**
- Хронический гипертрофический пульпит

190. Ребенку 12 лет. Жалобы: на косметический дефект зубов. При осмотре полости рта: 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 зубы имеют меловидный оттенок, блеск отсутствует, очаги пигментации светло-коричневого цвета. На эмали небольшие, округлой формы дефекты диаметром 1,5 мм, дно их темного цвета. Поставьте диагноз

- Поверхностный кариес, декомпенсированная форма
- *Флюороз, меловидно-крапчатая форма**
- Системная гипоплазия, пятнистая форма
- Флюороз, пятнистая форма
- Системная гипоплазия, эрозивная форма

191. У мальчика 13-ти лет жалобы на пульсирующие боли в 4.7 зубе, усиливающиеся ночью и от горячей пищи. Объективно: ГИ-2,0; КПУ-2; на жевательной поверхности 4.7зуба имеется глубокая

кариозная полость, зондирование болезненно по всему дну, при перкуссии возникают болевые ощущения. Проведите дополнительный метод исследования

- общий анализ крови, электроодонтометрия
- электроодонтометрия, термометрия
- *рентгенография, термометрия**
- флюоресценция, трансиллюминация
- общий анализ крови, витальное окрашивание

192. Мышьяковистая интоксикация периодонта у детей купируется:

- экстирпацией пульпы и пломбированием канала в то же посещение
- ампутацией пульпы с наложением тампона с обезболивающим препаратом под временную повязку
- *удалением пульпы, медикаментозной обработкой канала, введением в корневой канал турунды с препаратами йода или унитиолом**
- удалением пульпы, наложением тампона с резорцин-формалиновой жидкостью
- удалением пульпы, зуб оставляем открытым на 24 часа

193. Девочке 12 лет проведена операция удаление 1.6 зуба. Через 40 минут после операции удаления 1.6 зуба наблюдается кровотечение из лунки 1.6 зуба. На рентгенограмме обнаружена 1/3 верхушки дистально-щечного корня. Ваша дальнейшая тактика:

- *удаление верхушки корня зуба**
- назначение гемостатиков
- назначение антибиотика
- ушивание краев лунки
- тампонада лунки

194. Пациент 14 лет. Жалобы на необычный вид и форму десны. Объективно: в полости рта разрастания десны в области 1.3-2.3 зубов на 2/3 высоты коронки, десна бледного цвета, не кровоточит, безболезненная при пальпации. Изменения костной структуры на рентгенограмме не выявлены. Какие препараты показаны при местном лечении данного заболевания:

- антибактериальные
- кортикостероидные
- кератопластические
- противовирусные
- *склерозирующие**

195. Девочка 8 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на кровоточивость десен во время чистки зубов. Беспокоит в течение 1 года. При осмотре: лицо симметричное, дыхание через рот. Среди вредных привычек: сосание предметов. Десна на всем протяжении гиперемирована, рыхлая. Гигиенические навыки плохие. Зубы чистит с 6 лет, нерегулярно. Практически здорова. Поставьте диагноз:

- ювенильный гингивит
- *хронический катаральный гингивит**
- хронический локализованный пародонтит
- хронический генерализованный пародонтит
- хронический генерализованный парадонтоз

196. Пациентка 15 лет предъявляет жалобы на кровоточивость десен, болезненность при чистке зубов, приеме пищи, неприятный запах изо рта. Объективно в полости рта: в области 3.3-4.3 зубов десна застойно-цианотичная, гиперемирована, отечна, подвижность зубов II степени, обильные над и поддесневые зубные отложения, наблюдаются пародонтальные карманы глубиной до 5 мм. Какие рентгенологические изменения вы увидите при данной патологии:

- диффузный гиперостоз альвеолярного отростка
- диффузный остеосклероз альвеолярного отростка
- *деструкция кортикальных межзубных перегородок**
- диффузный остеопороз межзубных перегородок и альвеолярного отростка
- деструкция костной ткани альвеолярного отростка с полостными включениями

197. У ребенка 6 лет со слов мамы определяется запах изо рта и связано это с разрушенными зубами. При осмотре: в 8.5 зубе большая кариозная полость с массой ткани грязно-серого цвета и неприятным запахом, зондирование устьев канала болезненно. Перкуссия болезненна незначительна. Поставьте диагноз:

- острый серозный пульпит
- хронический фиброзный пульпит
- *хронический гангренозный пульпит**
- хронический гипертрофический пульпит
- хронический пульпит в стадии обострения

198. Определите показания к удалению молочных и постоянных зубов у детей:

- острое воспаление пульпы зуба
- хроническое воспаление пульпы зуба
- кариозные поражения твердых тканей зубов
- некариозные поражения твердых тканей зубов
- *при потере анатомической и функциональной значимости зуба**

199. Укажите меры профилактики возможных осложнений перед удалением зубов:

- подготовить ребенка к операции, дать рекомендации после операции
- *собрать анамнез, провести адекватное обезболивание**
- провести словесное внушение, физиологическое отвлечение
- подготовить родителей, провести беседу
- провести фармакологическую коррекцию поведения

200. Ребенок 5 лет во время удаления 8.4 зуба произошло повреждение зачатка постоянного 4.4 зуб. Ваша тактика:

- *рентгенография, наблюдение**
- удаление, наблюдение
- удаление, протезирование
- наблюдение, ортодонтическое лечение
- удаление, имплантация

201. Медикаментозную обработку пародонтальных карманов проводят растворами:

- *хлоргексидин+ метронидазол**
- пенициллин + перекись водорода
- дистиллированной воды + хлоргексидин

- 6% раствор перекиси водорода + трипсин
- 3% раствор перекиси водорода + дистиллированной воды

202. Укажите часто встречающуюся форму периодонтитов в молочных зубах у детей:

- острый медикаментозный периодонтит
- острый инфекционный периодонтит
- хронический фиброзный периодонтит
- *хронический гранулирующий периодонтит**
- хронический гранулематозный периодонтит

203. Ребенок 5 лет. Выберите метод обезболивания для удаления 8.5 зуба:

- аппликационная анестезия
- инфильтрационная анестезия
- туберальная анестезия
- палатинальная анестезия
- *мандибулярная анестезия и инфильтрационная**

204. В поликлинику обратился ребенок с непреодолимым негативным отношением к стоматологическим вмешательствам. Выберите метод обезболивания для удаления 4.6 зуба:

- *общее обезболивание**
- мандибулярная анестезия
- туберальная анестезия
- ментальная анестезия
- аппликационная анестезия

205. Укажите анатомические особенности строения молочных зубов у детей:

- несформированная пульповая камера
- широкая пульповая камера, узкие корневые каналы
- *широкая пульповая камера, широкие корневые каналы**
- маленькая пульповая камера, узкие корневые каналы
- маленькая пульповая камера, широкие корневые каналы

206. Ребенок 5 лет. Обратился в клинику с жалобами на боли, припухлость в области верхней челюсти справа. Боли появились 4 дня назад. Объективно: состояние средней тяжести, T- 37.8°, в полости рта 5.4 зуб- разрушен, подвижен, слизистая гиперемирована, инфильтрат вестибулярной поверхности, болезненный с очагом флюктуации. Укажите объем хирургического вмешательства при данной патологии:

- внеротовой разрез и дренирование мягких тканей
- удаление причинного зуба
- *периостотомия и удаление причинного зуба**
- раскрытие причинного зуба, отток гноя через корневые каналы
- периостотомия, ирригация раны

207. Ребенок 4 лет. Жалобы на слабость, насморк, светобоязнь, кашель, боль при приеме пищи. Объективно: ребенок вялый, апатичный, температура тела 39 С, выделения из носа, осиплость голоса. В полости рта: слизистая оболочка гиперемирована, в ретромолярной области- пятна в виде «брызг извести» (пятна Филатова-Коплика), на коже лица и за ушами мелкоточечная сыпь.

Консультация какого специалиста требуется для проведения дальнейшего общего лечения данного заболевания:

- гастроэнтеролога
- *инфекциониста**
- эндокринолога
- иммунолога
- аллерголога

208. Ребенок 3 года. Жалобы: на боли в резце верхний челюсти при приеме пищи. Беспокоит несколько дней. Анамнез: ранее не лечились. Объективно: кп=8, ГИ–1,2. Зуб 6.1 разрушен на 1/3, эмаль хрупкая, дентин светлый, податливый. При зондировании полость не сообщается с полостью зуба, безболезненная. Перкуссия болезненна, отмечается подвижность I степени. Слизистая гиперемирована, реакции на Т-раздражитель нет. Проведите лечение.

- Удаление зуба
- Вскрытие полости зуба, на рог пульпы девитализирующая паста, вр. пломба
- Раскрытие полости зуба, на устье каналов резодент смесь, временная пломба
- *Раскрытие полости зуба, удаление путридных масс, зуб оставлен открытым**
- Раскрытие полости зуба, удаление путридных масс, в канал эвгедент паста

209. В отделение детской челюстно-лицевой хирургии поступил ребенок в возрасте 6 месяцев. При осмотре врачом объективно обнаружена патология верхней губы слева, несрастание всех мягких тканей на всем протяжении губы от красной каймы по фильтруму до дна носовой полости с деформацией кожно-хрящевого отдела носа. Проведите хирургический метод лечения данной патологии

- радикальная уранопластика по Бернадскому
- щадящая ураностафилопластика по Бернадскому
- *хейлопластика по Милларду с треугольниками Лимберга**
- двухсторонняя хейлопластика по Теннисону
- односторонняя хейлопластика по Лимбергу

210. Ребенок 8 лет. Поступил в отделение детской челюстно-лицевой хирургии с жалобами на боль и припухлость в области нижней челюсти справа. Повышение температуры тела, недомогание, головные боли. Объективно асимметрия лица за счет отека мягких тканей. В полости рта 4.6 зуб разрушен полностью, слизистая гиперемирована, отечна, отмечается «муфтообразный» инфильтрат в области альвеолярного отростка нижней челюсти. Укажите комплекс проведения местного лечения данного заболевания:

- внутрикостный лаваж, периостотомия, гипосенсибилизирующая терапия
- *удаление «причинного» зуба, остеоперфорация, внутрикостный лаваж**
- антибактериальная терапия, физиолечение, удаление «причинного» зуба
- внутрикостный лаваж, антибактериальная терапия, физиолечение
- остеоперфорация, антибактериальная терапия, физиолечение

211. Гингивит, образование патологических зубодесневых карманов, обнажение шеек зубов, запах изо рта, прогрессирующая подвижность и потеря отдельных зубов характерны для:

- фиброзной дисплазии
- остеоид- остеомы
- кистозной амелобластомы

- оссифицирующей остеомы
- *эозинофильной гранулемы

212. Укажите клинические особенности саркомы Юинга у детей при проведении диагностики

- экспансивный рост, не выраженная иммунодепрессия, низкая радиочувствительность
- умеренный рост, рецидивы отсутствуют, низкая радиочувствительность
- *инфильтративный рост, быстрое метастазирование, высокая радиочувствительность
- инфильтративный рост без метастазов, низкая радиочувствительность
- медленный рост без метастазов, низкая радиочувствительность

213. Ребенок в возрасте 11 лет обратился в приемное отделение челюстно-лицевой клиники с жалобами на наличие припухлости в области нижней челюсти слева, на что обратили внимание около 1,5 месяца тому назад. При осмотре нарушение конфигурации нижней челюсти слева, при пальпации определяется овальной формы вздутие нижней челюсти. 7.5 зуб окрашен в розовый цвет, имеется пломба. На рентгенограмме деструкция костной ткани с четкими контурами, в проекции деструкции костной ткани зачаток 3.5 зуба. Поставьте диагноз:

- Острый периостит нижней челюсти
- Обострение хронического периодонтита 7.5
- *Одонтогенная воспалительная киста от 7.5
- Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти
- Хронический гиперостозный периостит нижней челюсти

214. Укажите признаки сформированного секвестра при хроническом деструктивном остеомиелите:

- *выбухание из свища грануляционной ткани с гнойным отделяемым
- наличие свища с инфильтратом окружающей ткани
- наличие свища с рубцово-измененными тканями
- наличие свища с геморрагическим отделяемым
- наличие свища с гнойным отделяемым

215. У ребенка Е., 7 лет. Жалобы на припухлость и боли в щечной области слева. При местном осмотре: асимметрия лица за счет отека мягких тканей щечной области слева. В данной области инфильтрат 5,0*4,0 см, кожа над ним гиперемирована, отечна. В центре инфильтрата имеются 4 гнойных стержня, покрытый корочками. Пальпация болезненна. Поставьте предварительный диагноз

- абсцесс щечной области
- *карбункул щечной области
- абсцесс околоушно-жевательной области
- абсцедирующий фурункул щечной области
- флегмона щечной области

216. У ребенка А., 7 лет. Жалобы боли и припухлость в подглазничной, щечной областях слева. При местном осмотре: асимметрия лица за счет отека подглазничной, щечной областей слева. В данной области пальпируется инфильтрат 5,0*4,0см, кожа над инфильтратом гиперемирована, отечна, в складку не собирается, пальпация резко болезненна. Открывание рта болезненное. Коронка 6.4 зуба разрушена на ½, перкуссия болезненна. Переходная складка сглажена, гиперемирована, отечна. Пальпация болезненна. Поставьте предварительный диагноз:

- одонтогенная флегмона скуловой, щечной областей слева
- одонтогенная флегмона подглазничной, скуловой областей слева
- одонтогенная флегмона крылонебной, щечной областей слева
- одонтогенная флегмона подглазничной, крылонебной областей слева
- *одонтогенная флегмона подглазничной, щечной областей слева**

217. Ребенок 10 лет жалуется на боли в полости рта при приеме пищи, при разговоре, в анамнезе периодическое появление эрозий. Общее состояние больного удовлетворительное. Объективно: на боковой поверхности языка слева - эрозия округлой формы размером 0,5 на 0,7 см, окруженная ободком гиперемии, покрытая сероватым налетом. Поставьте предварительный диагноз:

- хронический рецидивирующий герпетический стоматит
- *рецидивирующие афты полости рта**
- хронический гиперпластический кандидоз
- многоформная экссудативная эритема
- контактный аллергический стоматит

218. Эффективное местное лечение экзематозного хейлита:

- 0,5 % бонафтоновая мазь
- *0,5 % преднизолоновая мазь**
- 1 % раствор фуксина
- 10% раствор глюконата кальция
- 1 % мазь клотримазол (кавистен)

219. Самую большую группу постоянно обитающих в полости рта бактерий представляют:

- фузобактерии
- актиномицеты
- пептококки
- *стрептококки**
- грибы

220. Ферменты слюны, разрушая декстраны, находящиеся на поверхности клеток кариесогенного штамма, предупреждают возникновение кариеса. Наибольшей активностью обладают ферменты, расщепляющие:

- жиры и антитела
- белки и жиры
- *белки и углеводы**
- жиры и антиоксиданты
- углеводы и антигены

221. В клинику обратился пациент И., 19 лет с жалобами на изменение цвета зубов, причем цвет зубов изменился с момента прорезывания. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На вестибулярной поверхности 1.4,1.5,1.6,2.4, 2.5, 2.6 зубов имеются пятна желтоватого цвета, различной формы с гладкой, блестящей поверхностью. Пятна не окрашиваются красителями. Поставьте предварительный диагноз:

- *системная гипоплазия**
- кариес эмали

- аплазия
- недоразвития эмали
- флюороз

222. В клинику обратился пациент Е., 37 лет с жалобами на кратковременные боли при приеме пищи. Со слов пациента боли беспокоят в течение 6 месяцев. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 4.7 зуба имеется кариозная полость заполненная остатками пищи. Отмечается болезненность, быстро проходящая от холодной воды. При зондировании целостность дентино-эмалевого соединения нарушена, но дном кариозной полости является неизмененный дентин. Поставьте предварительный диагноз:

- некроз эмали
- *кариес дентина**
- гипоплазия
- кариес эмали
- флюороз

223. В клинику обратился пациент А., 62 лет с жалобами на боли при приеме сладкой пищи. Со слов пациента боли беспокоят в течение 2 лет. Врач поставил диагноз: Кариес эмали 4.5, 4.4, 4.3 зубов. При осмотре: кариозные полости локализуются в области фиссур и естественных углублений резцов, клыков, моляров и премоляров. Определите класс дефекта твердой ткани зуба:

- *I класс**
- II класс
- III класс
- IV класс
- V класс

224. В клинику обратился пациент С., 47 лет с жалобами на боли при приеме холодной пищи. Со слов пациента боли беспокоят в течение 1 года. Врач поставил диагноз: Кариес дентина 1.6 зуба. При осмотре: кариозные полости располагаются на контактных поверхностях моляров и премоляров. Определите класс дефекта твердой ткани зуба:

- I класс
- *II класс**
- III класс
- IV класс
- V класс

225. Пациенту Е., 49 лет поставлен диагноз: Кариес дентина 2.3 зуба. При осмотре: кариозные полости располагаются на контактных поверхностях резцов и клыков без нарушения режущего края. Определите класс дефекта твердой ткани зуба:

- I класс
- II класс
- *III класс**
- IV класс
- V класс

226. Пациенту Ю., 45 лет поставлен диагноз: Кариес дентина 2.2 зуба. При осмотре: кариозные полости располагаются на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением угла коронковой части и его режущего края. Определите класс дефекта твердой ткани зуба:

- I класс
- II класс
- III класс
- *IV класс**
- V класс

227. В клинику обратился пациент А., 58 лет с жалобами на боли при приеме сладкой пищи. Со слов пациента боли беспокоят в течение 2 лет. Врач поставил диагноз: Кариес цемента 2.5, 2.6 зубов. При осмотре: кариозные полости расположены в пришеечной области зубов. Определите класс дефекта твердой ткани зуба:

- I класс
- II класс
- III класс
- IV класс
- *V класс**

228. Пациенту Д., 47 лет поставлен диагноз: Кариес эмали 1.5, 1.6, 1.1, 2.3 зубов. При осмотре: кариозные полости располагаются на вершинах бугров моляров и премоляров, а также на режущих краях резцов и клыков. Определите класс дефекта твердой ткани зуба:

- I класс
- II класс
- III класс
- IV класс
- *VI класс**

229. В клинику обратился пациент Я., 27 лет с жалобами на ноющие постоянные боли в области 4.5 зуба. Со слов пациента болеет в течение 3 суток, 1 год назад 4.5 зуб лечен по поводу кариеса дентина. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На контактной поверхности 4.5 зуба имеется частичная пломба. Зондирование безболезненное. Перкуссия зуба болезненная. При удалении размягченного дентина кариозная полость не сообщается с полостью зуба. Показатели ЭОД=105мкА. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- острый пульпит, окрашивание 4.5 зуба
- хронический пульпит, рентгенография 4.5 зуба
- *острый периодонтит, рентгенография 4.5 зуба**
- хронический периодонтит, рентгенография 4.5 зуба
- обострение хронического периодонтита, цитология

230. В клинику обратился пациент С., 57 лет с жалобами на постоянные ноющие боли в области 3.6 зуба, припухлость щечной области слева. Со слов пациента болеет в течение 5 суток. Состоит на учете с диагнозом сахарный диабет 2 типа, хронический генерализованный пародонтит. При осмотре: асимметрия лица за счет отека щечной области слева. Открывание рта болезненное. Имеется оголение шеек 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубов, глубокий пародонтальный карман в области 3.6 зуба, подвижность зуба I-II степени, болезненна горизонтальная перкуссия. Десна в области 3.6

зуба с вестибулярной стороны гиперемирована, отечна, определяется флюктуация. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

***острый пародонтальный абсцесс в области 3.6 зуба, ортопантомография**

- острый гнойный периостит, рентгенография 3.6 зуба
- острый гнойный периодонтит, рентгенография 3.6 зуба
- хронический периодонтит, рентгенография 3.6 зуба
- обострение хронического периодонтита, ортопантомография

231. В клинику обратился пациент С., 66 лет с жалобами на язву в области спинки языка, затрудненное пережёвывание пищи. На протяжении 10 лет отмечает периодически возникающие язвы в полости рта. При осмотре: снижение высоты нижнего отдела лица, имеется западение спинки носа седловидный нос. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, безболезненны, подвижны. Открывание рта свободное. На спинки языка имеется язва округлой кратерообразной формы с плотными выступающими краями, безболезненная при пальпации. В области мягкого неба рубцовые изменения, язычок отсутствует. Поставьте предварительный диагноз и определите специалиста:

- туберкулезная язва, лечение у фтизиатра
- рак языка, лечение у онколога
- *гуммозный сифилид, лечение у венеролога**
- хроническая афта, лечение у стоматолога
- травматическая язва, лечение у стоматолога

232. В клинику обратилась пациентка А., 68 лет с жалобами на постоянные боли в заднем отделе альвеолярного гребня слева. Боли усиливаются во время еды и при разговоре, беспокоит в течение 1 месяца. Появление боли пациентка связывает с изготовлением полного съемного протеза на нижнюю челюсть. В анамнезе: гипертоническая болезнь II степени. При осмотре: в ретромолярной области слева имеется дефект в пределах слизистой оболочки 1,5*1,5 см, болезненны при пальпации, с неровными краями и дном, покрытым некротическим налетом. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, болезненны, подвижны. Поставьте предварительный диагноз и определите специалиста:

- туберкулезная язва, лечение у фтизиатра
- рак языка, лечение у онколога
- гуммозный сифилид, лечение у венеролога
- хронический афтозный стоматит, лечение у стоматолога
- *травматическая язва, лечение у стоматолога**

233. Пациент, 20 лет, обратился с жалобами на ночную, приступообразную, самопроизвольную боль в зубе верхней челюсти слева, усиливающуюся при приеме пищи. Боль появилась накануне вечером. Ранее беспокоило чувство дискомфорта при приеме пищи. В полости рта: на дистально-жевательной поверхности 2.4 зуба глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование и реакция на раздражители болезненны, перкуссия слабоболезненна, слизистая оболочка в проекции корней 2.4 не изменена. Наиболее вероятный диагноз:

- Острый диффузный пульпит
- *Обострение хронического фиброзного пульпита**
- Острый очаговый пульпит
- Обострение хронического гангренозного пульпита
- Острый верхушечный периодонтит

234. Пациент обратился с жалобами на изменение цвета коронки зуба нижней челюсти слева. Со слов больного зуб ранее лечен. Объективно: на жевательной поверхности 37 зуба глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование безболезненно. Реакция на температурный раздражитель отсутствует. Перкуссия и пальпация безболезненны. Слизистая оболочка в области причинного зуба бледно-розового цвета. На рентгенограмме: расширение периодонтальной щели в области верхушки медиального корня зуба. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- хронический фиброзный пульпит
- хронический гангренозный пульпит
- *хронический фиброзный периодонтит**
- хронический гранулирующий периодонтит
- хронический гранулематозный периодонтит

235. Пациенту 31 год. Глубокая кариозная полость локализована на жевательной поверхности 47 зуба. При лечении произошло случайное вскрытие медиально-щечного рога пульпы. Какой метод лечения наиболее целесообразно провести?

- *биологический**
- витальная ампутация
- витальная экстирпация
- девитальная ампутация
- комбинированный метод

236. Вторичные морфологические элементы, проявляющиеся на слизистой оболочке полости рта?

- *Трещина, язва**
- Розеола, папула
- Афта, везикула
- Гнойничок, рубец
- Пигментация, волдырь

237. Представители микрофлоры полости рта, в процессе жизнедеятельности совершают активные движения, относятся к строгим анаэробам. Они усиленно размножаются в полости рта при значительном размножении других анаэробных микроорганизмов и вызывают патологические процессы в ассоциации с некоторыми штаммами фузобактерий. Представителей данной группы наиболее часто обнаруживают при следующем заболевании:

- кандидозе полости рта
- герпетическом стоматите
- язвенно-некротическом стоматите

***катаральном гингивите**

- пародонтозе

238. Кариесстатическим свойством обладают цементы:

- Цинк-фосфатные
- Цинк-оксид-эвгенольные
- Поликарбоксилатные

***Стеклоиономерные**

- Силикатные

239. Для лечения какого заболевания рекомендуется в первое посещение выполнить препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, после высушивания - наложить лечебную прокладку и временную пломбу. Через 5-7 дней временную пломбу следует заменить на постоянную с наложением лечебной, изолирующей прокладок:

- Клиновидный дефект
- Средний кариес

***Быстропрогрессирующий глубокий кариес**

- Хронический фиброзный периодонтит
- Медленнопрогрессирующий глубокий кариес

240. Пациент, 20 лет, обратился с жалобами на ночную, приступообразную, самопроизвольную боль в зубе верхней челюсти слева, усиливающуюся при приеме пищи. Боль появилась накануне вечера. Ранее беспокоило чувство дискомфорта при приеме пищи. В полости рта: на дистально-жевательной поверхности 2.4 зуба глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование и реакция на раздражители болезненны, перкуссия болезненна, слизистая оболочка в проекции корней 2.4 не изменена. Наиболее вероятный диагноз:

- Острый диффузный пульпит

***Обострение хронического фиброзного пульпита**

- Острый очаговый пульпит
- Обострение хронического гангренозного пульпита
- Острый верхушечный периодонтит

241. Пациент, 27 лет, обратился с жалобами на измененный внешний вид эмали зубов. При осмотре: коронки всех групп зубов пигментированы, имеют желтоватый оттенок, но блеск эмали сохранен. В области фронтальных зубов верхней и нижней челюстей на вестибулярной поверхности имеются отдельные участки пигментации эмали светло-коричневого цвета и дефекты коронок округлой формы диаметром до 1,5 мм и глубиной 0,1–0,3 мм, дно их светло-желтого цвета, плотное. Наиболее вероятный диагноз

- Множественный кариес зубов
- Некроз твердых тканей зуба
- Системная гипоплазия, пятнистая форма

***Флюороз, меловидно-крапчатая форма**

- Эрозия твердых тканей зуба

242. Пациент, 43 лет, жалуется на длительные ноющие боли в зубе верхней челюсти справа, которые возникают при перемене температуры окружающей среды и во время приема пищи. При обследовании в пришеечной области 1.6 зуба обнаружена глубокая кариозная полость.

Зондирование резко болезненно в одной точке. Электровозбудимость пульпы - 50 мкА. Наиболее вероятный диагноз:

- Глубокий кариес
- Хронический гангренозный пульпит
- Обострение хронического фиброзного пульпита
- Острый очаговый пульпит

***Хронический фиброзный пульпит**

243. Пациент, 29 лет обратился с жалобами на боли от химических, механических и температурных раздражителей в области зуба верхней челюсти справа. Впервые боль возникла 3 месяца назад. Объективно: на жевательно-контактной поверхности 1.6 зуба кариозная полость с поражением глубоких слоев дентина. Размягченный дентин легко удаляется экскаватором. Зондирование дна кариозной полости болезненно. На холодной раздражитель реакция положительная, быстропроходящая. Перкуссия отрицательная. ЭОД = 12 мкА. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную диагностику?

- Острый диффузный пульпит
- Поверхностный кариес
- *Хронический фиброзный пульпит**
- Хронический гангренозный пульпит
- Хронический верхушечный периодонтит

244. Пациентка, 24 лет обратилась с целью плановой санации полости рта. При осмотре: на медиально-жевательной поверхности 4.6 зуба кариозная полость с остатком пломбы, после удаления которой определяется сообщение с полостью зуба. Зондирование коронковой части полости зуба и устьев корневых каналов безболезненно. Горизонтальная и вертикальная перкуссия зуба безболезненна. На рентгенограмме: в области верхушки медиального корня зуба равномерное расширение периодонтальной щели. Какова наиболее вероятная реакция на температурный раздражитель?

- Кратковременная, быстропроходящая боль
- Боль от горячего раздражителя
- Длительная, медленнопроходящая боль
- Боль от холодного раздражителя

***Отсутствие болевой реакции**

245. Пациент, 20 лет, обратился с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, приеме твердой пищи, неприятный запах изо рта. Объективно: отек, гиперемия с цианотичным оттенком десневого края и межзубных сосочков, десна рыхлые, легко кровоточат при дотрагивании, наличие мягкого зубного налета и наддесневых зубных отложений. ИГ=4. Скученность фронтальных зубов нижней челюсти. В зубном ряду нижней челюсти отсутствует 3.6 зуб. При рентгенологическом обследовании патологических изменений в костной ткани альвеолярных отростков челюстей не выявлено. Комплекс местных лечебных мероприятий при данной патологии начинают в первую очередь со следующего:

***Коррекция гигиены полости рта (обучение, мотивация)**

- Ортодонтическое лечение
- Профессиональная гигиена полости рта
- Ортопедическое лечение
- Физиолечение (электрофорез с витамином С)

246. Пациент, 18 лет обратился с жалобами на боли в зубе верхней челюсти справа, возникшие сразу после травмы. Анамнез: травму зуба получил 1 час назад. Сопутствующую патологию отрицает. Аллергоанамнез не отягощен. При осмотре: коронка 1.1 зуба отломана на 1/2 длины, полость зуба широко вскрыта, пульпа кровоточит, резко болезненна при зондировании. ЭОД – 30 мкА. Наиболее целесообразный метод лечения:

- Биологический

***Витальная экстирпация**

- Комбинированный
- Витальная ампутация
- Девитальная экстирпация

247. Пациент, 30 лет, обратился с жалобами на кровоточивость, зуд в области десны, наличие зубных отложений. Анамнез: кровоточивость отмечает в течение 4 месяцев, страдает хроническим гастритом. Объективно: десневые сосочки верхней и нижней челюсти застойно-гиперемированные, отечные, рыхлые, кровоточивы. При зондировании десневые карманы в области передних нижних зубов. Зубы устойчивые, имеются обильный мягкий зубной налет и твердые наддесневые зубные отложения, ГИ=3,5. В зубном ряду 3.6 зуб отсутствует. Мероприятие, с которого необходимо начинать комплексное лечение данного заболевания:

- Имплантация в области зуба 3.6
- Общее медикаментозное лечение
- *Удаление зубных отложений**
- Хирургическое лечение (кюретаж)
- Шинирование фронтальных нижних зубов

248. Пациент, 50 лет. Обратился с жалобами на зуд десен, обнажение шеек зубов, боль от термических раздражителей. Анамнез: отмечает прогрессирование этих симптомов в течение 5-6 лет. Сопутствующая патология: гипертоническая болезнь. Объективно: слизистая десны на всем протяжении бледная, анемичная, десневых карманов нет, ретракция десны до 1/2 длины корня. Отмечаются клиновидные дефекты в области 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5 зубов. Какой процесс лежит в основе данной патологии?

- Воспалительный
- Воспалительно-деструктивный
- Деструктивный
- *Дистрофический**
- Опухолевый

249. Пациент, 25 лет, обратился с жалобами на боль в зубе нижней челюсти, перелом коронки зуба после откусывания твердой пищи. Анамнез зуб ранее лечен по поводу пульпита. Объективно: отмечается перелом коронки зуба 4.1 с образованием двух отломков (медиального и дистального) с остатками пломбировочного материала. Отломки подвижны. На рентгенограмме линия перелома проходит от режущего края вдоль коронки в сторону корня до верхушки.

Наиболее вероятная тактика врача-стоматолога:

- Шинирование зуба и динамическое наблюдение в течение 5-7 дней
- Удаление корневой пломбы, временное пломбирование корневого канала
- Удаление корневой пломбы, временное пломбирование корневого канала
- Удаление корневой пломбы, пломбирование корневого канала с использованием твердого штифта
- *Удаление зуба**

250. Во время эндодонтического лечения зуба 1.5 по поводу хронического гранулематозного периодонтита произошел отлом эндодонтического инструмента в корневом канале. Попытки извлечения отломка не увенчались успехом. На рентгенограмме в области верхушки корня определяется отломок эндодонтического инструмента длиной около 2 мм, корень зуба в области верхушки изогнут в дистальную сторону, в периапикальных тканях очаг деструкции костной ткани с четкими контурами размером 3 мм. Врач-стоматолог запломбировал проходимую часть канала

под постоянную пломбу. Какой метод наиболее показан для предотвращения развития возможных осложнений после пломбирования?

- Гемисекция зуба
- Реплантация зуба
- Ампутация корня зуба
- *Резекция верхушки корня
- Коронорадикулярная сепарация

251. Пациент, 25 лет. Жалобы на постоянные ноющие боли в зубе нижней челюсти, чувство «выросшего» зуба. Анамнез: полость в зубе заметил 2 года назад. Вначале беспокоили самопроизвольные, ночные боли, позже периодически вместе с зубом беспокоила десна – отмечалась припухлость, выделение гноя. Объективно: в 3.6 зубе глубокая кариозная полость. Полость зуба вскрыта. Зондирование вскрытой кариозной полости безболезненно, перкуссия резко болезненна. Переходная складка в области 3.6 зуба гиперемирована, отечна, при пальпации болезненна, в области проекции корней выявляется слабозаметный рубец 2,5 мм. Наиболее вероятный диагноз?

- Обострение хронического гранулематозного периодонтита
- Острый периодонтит в стадии экссудации
- *Обострение хронического гранулирующего периодонтита
- Локализованный абсцедирующий пародонтит
- Обострение хронического фиброзного периодонтита

252. Пациент, 27 лет обратился к врачу-стоматологу с целью санации полость рта. Объективно: на вестибулярной поверхности 2.1, 1.2 зубов ограниченные пятна белого цвета. Поверхность гладкая. Зонд скользит. Пятна окрашиваются 2% раствором метиленового синего. ЭОД = 4 мкА. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную диагностику?

- Клиновидный дефект
- Поверхностный кариес
- *Системная гипоплазия
- Травма твердых тканей зуба
- Эрозия эмали

253. Пациентка, 28 лет. Жалобы на болезненность, кровоточивость десны в области верхних зубов. Анамнез: год назад на зубы верхней челюсти изготовлены спаянные металлокерамические коронки. Через 3-4 месяца появилась кровоточивость десны. Объективно: десневые сосочки в области 2.4, 2.5 зубов гипертрофированы, цианотичны, кровоточат при дотрагивании, определяется пародонтальный карман глубиной 3-3,5 мм. Искусственные коронки на 2.4, 2.5 зубах глубоко заходят под десну. Наддесневые зубные отложения у фронтальных зубов нижней челюсти. ГИ=4,0. На рентгенограмме: резорбция костной ткани межзубной перегородки у 2.4, 2.5 зубов до 1/3, в других отделах костная ткань без изменений. Определите мероприятие по этиотропному лечению патологии:

- Снятие зубных отложений с зубов нижней челюсти
- Ротовые ванночки с противовоспалительными средствами
- *Снятие металлокерамических коронок с 2.4, 2.5 зубов
- Хирургическое иссечение гипертрофированных сосочков
- Коррекция гигиены полости рта

254. Мужчина 57 лет, предъявляет жалобы на необычный вид слизистой, чувство стянутости.

Объективно: на слизистой оболочке щек по линии смыкания зубов в переднем отделе с переходом на губы выявляется неравномерное помутнение эпителия с четкими краями. Пятно не выступает над уровнем окружающих участков слизистой оболочки, не поддается соскабливанию. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- хроническая механическая травма
- химическое повреждение
- *плоская форма лейкоплакии**
- веррукозная лейкоплакия
- эрозивная форма лейкоплакии

255. Мужчина 50 лет жалуется на отечность нижней губы. Объективно: губа увеличена в размере, отечна, гиперемирована, покрыта плотно фиксированными корками желто-зеленого цвета. Из протоков желез выделяется слюна с гнойным экссудатом. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- макрохейлит
- атопический хейлит
- актинический хейлит
- эксфолиативный хейлит
- *гландулярный хейлит**

256. Пациентка 45 лет, предъявляет жалобы на зуд и жжение губ. Со слов пациентки эти ощущения появились после применения новой гигиенической помады. Объективно: на фоне гиперемированной и отечной красной каймы губ имеются пузырьки и ограниченные мокнущие участки. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- актинический хейлит
- эксфолиативный хейлит
- гнойный гландулярный хейлит
- метеорологический хейлит
- *контактный аллергический хейлит**

257. Пациентка, 20 лет, жалуется на жжение и болезненность губ при их смыкании. Страдает данной патологией в течение 8 лет. При объективном осмотре: на красной кайме губ, начиная от зоны Клейна до середины красной каймы – чешуйко-корки желтовато-коричневого цвета. После снятия корок обнажается ярко-красная гладкая поверхность. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- актинический хейлит
- экзематозный хейлит
- гландулярный хейлит
- *эксфолиативный хейлит**
- атопический хейлит

258. Пациентка 25 лет явилась на прием с жалобами на кровоточивость, необычный вид десны, ее разрастание. Объективно: десна отечная, гиперемированная, кровоточит. Отмечается разрастание десневых сосочков на ½ коронки зуба, ложные карманы. Какой метод лечения наиболее целесообразный?

- гингивопластика

- гингивотомия

***противовоспалительная, склерозирующая терапия.**

- кюретаж десневых и пародонтальных карманов
- аппликации растворов протеолитических ферментов

259. Пациентка 36 лет жалуется на жжение в полости рта, боль при приеме пищи, наличие налета.

Объективно: на гиперемированной слизистой оболочке языка, щек, губ обнаружены беловатые пленки, напоминающие свернувшееся молоко или творог. Налет возвышается над уровнем слизистой оболочки, легко снимается тампоном. Какой лекарственный препарат наиболее целесообразно применить?

***флуконазол**

- ацикловир
- новопассит
- супрастин
- гидрокортизон

260. Больной 65 лет жалуется на чувство стянутости, жжения, шероховатости, сухости слизистой оболочки полости рта. Объективно: на фоне гиперемированной слизистой оболочки выявляются папулы округлой формы размером 0,2-5 мм с тенденцией слияния в виде рисунка, напоминающего кружевную сетку, растительный узор. Какой лекарственный препарат наиболее целесообразно применить?

***Преднизолон**

- Ацикловир
- Дифлюкан
- Оксолин
- Бонафтон

261. Пациентка 20 лет обратилась к врачу-стоматологу с целью профилактического осмотра. Из анамнеза: отмечает частые головокружения, слабость, любит есть мел. При осмотре: кожные покровы лица бледные, в полости рта – слизистая оболочка полости рта бледной окраски, суховатая. Язык гладкий, блестящий, сосочки атрофированы. Повышенная стираемость режущих краев фронтальных резцов нижней и верхней челюсти. В зубной формуле в 2.6, 4.6 зубах – пломбы. Остальные зубы интактные. Проявлению какого заболевания соответствует описанная клиническая картина в полости рта

- Гиповитаминоз B2
- Железодефицитная анемия
- Агранулоцитоз
- Гиповитаминоз PP

***Полицитемия**

262. Патогистологический процесс характеризуется изменениями в слое эпителия, где в результате скопления жидкости в цитоплазме клеток, ядра приобретают седловидную форму и клетки подвергаются разрушению. Какому из патогистологических процессов характерны описанные изменения?

- Дискератоз
- Спонгиоз
- Акантолиз

- Баллонная дистрофия

- ***Вакуольная дистрофия**

263. 35 -летний пациент жалуется на наличие образования на языке неясной этиологии. При осмотре: на кончике языка обнаружено круглое образование диаметром 8мм в виде ярко-красной эрозии с ровными, слегка приподнятыми краями, плотным хрящевидной консистенции широким основанием. Пальпация безболезненна. Регионарные лимфоузлы увеличены, плотноэластической консистенции. Поставьте предварительный диагноз?

- ***Первичный сифилис**

- Декубитальная язва
- Туберкулезная язва
- Трофическая язва
- Раковая язва

264. 30-летний пациент обратился к стоматологу с жалобами на изменения рельефа спинки языка, которые заметил 2 недели тому назад. Болевые ощущения отсутствуют. При осмотре: в заднем отделе спинки языка определяются круглые диаметром 6-7 мм серовато-белые образования со сглаженными поверхностями, которые напоминают картину скошенного луга. При поскабливании поверхность очагов снимается, обнажая эрозивные поверхности, пальпация безболезненна, очаги плотноватой консистенции. Дифференциальная диагностика проводится со всеми ниже приведенными заболеваниями, исключая одно заболевание:

- ***Острый герпетический стоматит**

- Десквамативный глоссит
- Лейкоплакия
- Красный плоский лишай
- Хронический атрофический кандидоз полости рта

265. Пациент, 16 лет, обратился с жалобами на разрастание десны, зуд, кровоточивость, боли, усиливающиеся во время приема пищи, а также неприятный запах изо рта. Объективно: межзубные сосочки и край десны верхней и нижней челюсти отечные, рыхлые, цианотичны, увеличены в размерах, покрывают коронки зубов до 1/3 их высоты. При зондировании выявляется наличие ложных зубодесневых карманов. ИГ=4. Наиболее вероятный диагноз:

- Хронический пародонтит, легкая степень тяжести
- Гипертрофический гингивит, отечная форма
- Хронический катаральный гингивит
- Гипертрофический гингивит, фиброзная форма

- ***Обострение хронического катарального гингивита**

266. Пациент, 36 лет, обратился с жалобами на изменение цвета зуба верхней челюсти справа. Из анамнеза: зуб не болел, кариозную полость заметил давно, но к врачу не обращался. Объективно: на дистальной поверхности 1.2 зуба глубокая кариозная полость. Полость зуба вскрыта, зондирование и реакция на холод безболезненные, перкуссия безболезненна. На рентгенограмме 1.2 зуба – в области верхушки корня деформация костной ткани, расширение периодонтальной щели с четкими границами. Наиболее вероятный диагноз:

- Хронический фиброзный пульпит

- ***Хронический гангренозный пульпит**

- Хронический фиброзный периодонтит

- Хронический гранулирующий периодонтит
- Хронический гранулематозный периодонтит

267. Больная М., 52 лет, страдающая сахарным диабетом, жалуется на жжение, сухость в полости рта, боль при приеме пищи, выделение вязкой слюны. В течение 12 лет пользуется съемными пластиночными протезами. Объективно: на гиперемированной, отечной слизистой языка, щек и твердого неба скудный трудно снимающийся белесоватый налет, после удаления которого обнажается ярко красная поверхность. Какой диагноз наиболее вероятен?

- Десквамативный глоссит
- Волосатая лейкоплакия

***Хронический атрофический кандидоз**

- Лейкоплакия, эрозивная форма
- Красный плоский лишай, экссудативно- гиперемическая форма

268. Женщина 60 лет жалуется на жжение, сухость и легкую болезненность в области мягкого неба в течение месяца. Объективно: на мягком небе неправильной формы эрозия размером 2х3 см, ярко-красного цвета. Окружающая слизистая бледная. При потирании ватным тампоном отмечается отслоение видимо неизмененного эпителия вокруг эрозии. Симптом Никольского отрицательный. Каков наиболее вероятный предварительный диагноз?

- Вульгарная пузырчатка

***Буллезный пемфигоид**

- Аллергическая реакция на пластмассу
- Герпетиформный дерматит Дюринга
- Эрозивный стоматит

269. Больной М., 30 лет, жалуется на резкую болезненность на слизистой щеки, усиливающуюся при разговоре и еде. Объективно: на слизистой оболочке щеки по линии смыкания зубов на фоне гиперемированной слизистой, афта с ровными краями и венчиком воспаления, покрытая трудно снимающимся желтовато-белым фибринозным налетом. Из анамнеза: характерна сезонность высыпания. Поставьте предварительный диагноз?

- Хроническая механическая травма;
- Рецидивирующий герпетический стоматит
- Опоясывающий лишай;

***Хронический рецидивирующий афтозный стоматит**

- Лейкоплакия

270. Женщина, 35 лет обратилась в стоматологическую поликлинику с жалобами на общее недомогание, повышенную температуру тела, появление красных пятен на лице и шее. Объективно: в полости рта отмечается разлитая эритема и отек слизистой оболочки, пузыри разных размеров, болезненные эрозии, покрытые фибринозным налетом. Каков наиболее вероятный диагноз у больного?

- Системная красная волчанка

***Многоформная экссудативная эритема**

- Хронический рецидивирующий афтозный стоматит
- Рецидивирующие глубокие рубцующиеся афты
- Синдром Бехчета

271. Больная, 32 лет жалуется на высыпания на верхней губе, появившиеся день назад, после переохлаждения. Отмечает периодическое появление подобных высыпаний на губах в течение 5 лет. При осмотре: на границе верхней губы и кожи слева отмечаются мелкие, диаметром 1-2 мм, сгруппированные в одном месте и прилегающие друг к другу пузырьки, болезненные, с мутным содержимым. Результаты цитологического исследования содержимого пузырьков при данном заболевании:

***гигантские клетки Лангханса**

- споры гриба Candida
- Клетки Тцанка
- Бациллы Коха
- фузобактерии

272. В клинику обратился пациент С., 42 лет с жалобами на боли при глотании, припухлость в подчелюстной области справа, ограничение открывания рта, слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38,5°C. Из анамнеза: со слов пациента болеет в течение 5 суток, когда появились боли в 4.6 зубе, 3 суток назад появилась припухлость, состояние ухудшилось. Зуб ранее не лечен. Объективно: общее состояние средней тяжести, асимметрия лица за счет отека поднижнечелюстной области справа. В данной области пальпируется инфильтрат 6,0х4,0 см, кожа над ним гиперемирована, отечна, напряжена. Открывание рта ограничено до 2,0 см. Коронка 4.6 зуб разрушена на 2/3, перкуссия болезненна. Слизистая крыловидно-челюстной складки гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. Поставьте предварительный диагноз:

- флегмона поднижнечелюстной, подподбородочной областей от 4.6 зуба

***флегмона поднижнечелюстной, крыловидно-челюстной областей от 4.6 зуба**

- флегмона окологлоточной, подподбородочной областей от 4.6 зуба
- флегмона подмассетеральной, подподбородочной областей от 4.6 зуба
- флегмона поднижнечелюстной, щечной областей от 4.6 зуба

273. Пациент Н., 46 лет, поступил в клинику с жалобами на наличие гнойного экссудата из свища в поднижнечелюстной области слева. Из анамнеза: 2 месяца назад получил травму, за помощью не обращался. Отмечались боли и припухлость в поднижнечелюстной области слева, которые самопроизвольно исчезли через 2-3 недели. Объективно: в поднижнечелюстной области слева имеется свищевой ход с выбухающими грануляциями и гнойным экссудатом. Открывание рта ограничено до 2,5 см. Прикус нарушен, имеется свищ с грануляциями на десне между 3.6 и 3.7 зубами. Определяется подвижность отломков между 3.6 и 3.7 зубами. На рентгенограмме определяется линия перелома между 3.6 и 3.7 зубами. В линии перелома определяются дистальные корни 3.6 зуба и мелкие секвестры. Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического лечения:

***постравматический остеомиелит нижней челюсти, секвестрэктомия**

- одонтогенный остеомиелит нижней челюсти, дренирование свища
- ментальный перелом нижней челюсти, наложение шины
- перелом ветви нижней челюсти, репозиция отломков
- перелом угла нижней челюсти, остеосинтез

274. В клинику обратился пациент А., 39 лет с жалобами на жгучие боли и побледнение лица справа. Из анамнеза: получил отморожение лица на улице. Объективно: асимметрия лица за счет отека правой половины лица, кожные покровы бледные, при пальпации отсутствует

чувствительность. Имеются множественные пузыри, наполненные жидкостью. Определите степень отморожения

- I
- *II**
- IIIa
- IIIб
- IV

275. Больному У., 25 лет показана туберальная анестезия. Проведите профилактику образования гематомы при проведении этой анестезии:

- анестетик выпустить только у целевого пункта
- *скос иглы должен быть направлен к кости, по ходу выпускать анестетик**
- длина иглы должна быть 6-8 см
- при проведении анестезии поршень шприца потянуть на себя
- не применять анестетик без вазоконстриктора

276. У пациента У., 25 лет за счет воспалительной контрактуры медиальной крыловидной мышцы имеется ограничение открывания рта. Необходимо удалить 4.7 зуб. Контрактура 3-степени. В анамнезе - ограничение открывание рта появилось 3 дня тому назад. Определите метод анестезии при данном клиническом случае:

- *по Берше-Дубову**
- по Вайсбрему
- мандибулярный
- торусальный
- туберальный

277. Больной А., 40 лет обратился с жалобами на попадание жидкости в полость носа при полоскании полости рта. В анамнезе 1.6 зуб верхней челюсти удален 3 дня тому назад. Объективно: лицо симметричное, открывание рта свободное. Лунка 1.6 зуба заполнена грануляциями, при зондировании имеется сообщение с верхнечелюстным синусом. Поставьте предварительный диагноз:

- хронический верхнечелюстной синусит
- хронический этмоидит
- *перфорация дна гайморовой пазухи**
- острый фронтит
- острый сфеноидит

278. В клинику обратился пациент А., 39 лет с жалобами на боли в области верхней челюсти, неприятный запах из полости рта. Поставлен диагноз: обострение хронического периодонтита 2.7 зуба. Показана операция удаление 2.7 зуба. Определите методы местной анестезии:

- туберальная и резцовая
- *туберальная и небная**
- туберальная и резцовая
- подглазничная и резцовая
- резцовая и небная

279. В клинику обратился пациент О., 29 лет, поставлен диагноз: Затрудненное прорезывание 4.8 зуба. После проведения локальной анестезии ультракаином, через 5 минут пациент отмечает чувство онемения правой половины нижней губы, подбородка и кончика языка. Данная клиническая картина характерна для:

***блокирования нижнелуночкового и язычного нервов**

- блокирования небного и резцового нервов
- блокирования верхнелуночкового и небного нервов
- блокирования щечного и подглазничного нервов
- блокирования ветвей лицевого нерва

280. В клинику обратился пациент Р., 30 лет, поставлен диагноз: Острый гнойный периостит верхней челюсти от 2.7 зуба. Планируется операция периостотомия и удаление 2.7 зуба.

Определите методы локальной анестезии для проведения данной операции:

- резцовая и инфильтрационная
- небная и инфильтрационная
- небная и инфраорбитальная
- резцовая и небная

***небная и туберальная**

281. В клинику обратился пациент К., 45 лет с жалобами на боли и припухлость в области верхней челюсти справа, слабость, недомогание, повышение температуры тела до 37,5°C. Из анамнеза: со слов пациента болеет в течение 3 суток, когда появились боли в 1.6 зубе, 1 сутки назад появилась припухлость, состояние ухудшилось. Зуб ранее не лечен. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей верхней челюсти справа. В данной области пальпируется инфильтрат 2,0×2,0 см, кожа над ним гиперемирована. Открывание рта болезненное. Коронка 1.6 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненна. Переходная складка на уровне 1.5,1.6,1.7 зубов сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена, пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод хирургического лечения:

- острый гнойный перикоронит от 1.6 зуба, удаление зуба

***острый гнойный периостит верхней челюсти, периостотомия, удаление 1.6**

- острый гнойный периодонтит 1.6 зуба, периостотомия, удаление зуба
- флегмона щечной области от 1.6 зуба, дренирование гнойника
- абсцесс скуловой области от 1.6 зуба, дренирование гнойника

282. В клинику обратился пациент З., 39 лет с жалобами на боли и припухлость в области нижней челюсти слева, слабость, повышение температуры тела до 37,3°C. Из анамнеза: со слов пациента болеет в течение 4 суток, когда появились боли в 3.6 зубе, 2 суток назад появилась припухлость, состояние ухудшилось. Зуб ранее лечен. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти слева. В данной области пальпируется инфильтрат 2,0×1,5 см, кожа над ним гиперемирована. Открывание рта болезненное. Коронка 3.6 зуба разрушена на 1/2, перкуссия болезненна. Переходная складка на уровне 3.5, 3.6, 3.7 зубов сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена, пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод хирургического лечения:

- острый гнойный перикоронит от 3.6 зуба, удаление зуба
- абсцесс подподбородочной области от 3.6 зуба, дренирование гнойника
- острый гнойный периодонтит 3.6 зуба, периостотомия, удаление зуба
- флегмона подчелюстной области от 3.6 зуба, дренирование гнойника

***острый гнойный периостит нижней челюсти, периостотомия, удаление 3.6**

283. В клинику обратился пациент Л., 30 лет. Врач поставил диагноз: хронический периодонтит 4.7 зуба. Во время удаления 4.7 зуба произошел перелом коронки зуба, медиальный корень остался в лунке. Для удаления медиального корня 4.7 зуба необходимо использовать:

· прямой элеватор

***угловой элеватор «на себя»**

· угловой «от себя»

· элеватор штыковидный

· распатор

284. В клинику обратился пациент У., 37 лет. Врач поставил диагноз: обострение хронического периодонтита 4.6 зуба. Планируется удаление 4.6 зуба под местной анестезией. Определите инструмент для удаления 4.6 зуба и положение врача:

· клювовидные сходящиеся щипцы, положение врача позади и слева

· универсальные щипцы, положение врача позади и слева от пациента

· клювовидные несходящиеся щипцы, положение врача впереди и справа

***клювовидные несходящиеся щипцы, положение врача позади и справа**

· универсальные щипцы, положение врача впереди и слева от пациента

285. В клинику обратился пациент С., 22 лет с жалобами на деформацию нижней челюсти справа. Болен в течение 6 месяцев, 1 месяц назад получил удар в челюсть и после этого деформация увеличилась. При осмотре: асимметрия лица за счет уплотнения угла и ветви нижней челюсти справа. Пальпация безболезненна. Открывание рта болезненное. Слизистая на переходной складке на уровне 36, 37 зуба бледно- розового цвета, при пальпации определяется симптом «пергаментного хруста». На Р- грамме гомогенные очаги просветления с четкими контурами разделенные между собой костными перегородками. В очаге просветления располагается ретинированный 38 зуб. Морфологическое исследование напоминает структуру эмалевого органа. Поставьте клинический диагноз:

· фиброма

· одонтома

· миксома

· хондрома

***амелобластома**

286. В стоматологическую поликлинику обратился больной с жалобами на сильные, постоянные боли позади второго моляра нижней челюсти, усиливающиеся при жевании; иррадирующие в ухо и висок. Открывание рта болезненное. Слизистая позади 3.7 зуба гиперемирована, отечна; видны только медиальные бугры 3.8 зуба. На рентгенограмме — 3.8 зуб в вертикальном положении, расстояние между 3.7 зубом и передним краем ветви нижней челюсти составляет 0,7 см. Выберите тактику лечения:

· Новокаин-антибиотиковая блокада

***Иссечение капюшона**

· Периостотомия

· Удаление 3.8 зуба

· Аппликация Метрогилом

287. У больного выставлен диагноз: фурункул верхней губы. Местно отмечается уплотнение тканей у внутреннего угла глаза в виде синюшного тяжа. Какое возникло осложнение

- повреждение лицевой вены
- *флебит угловой вены лица**
- медиастенит
- перфорация верхнечелюстного синуса
- абсцесс крылонебной ямки

288. Больной, 23 лет, обратился в приёмный покой челюстно-лицевой больницы с диагнозом: двусторонний перелом нижней челюсти: по 4.8 зубу без смещения и со смещением тела между 3.5 и 3.6 зубами. При проведенном обследовании установлено, что 3. 5 зуб интактный. перкуссия его безболезненна, в 3. 6 зубе глубокая кариозная полость, перкуссия резко болезненна. На рентгенограмме - у верхушки медиального корня 3. 6 зуба определяется разряжение тканей в виде очага с неровными контурами. Какова тактика хирурга стоматолога по отношению зубов в линии перелома?

- удаление 3.5, 3.6 и 4.8
- *удаление 3.6 и 4.8 зубов**
- удаление 3.5, 4.8
- удаление 4.8
- удаление 3.5

289. Больной с раком нижней челюсти T4N0M0. Врач направил пациента на МСЭК. Какая группа инвалидности показана:

- *Первая**
- Вторая
- Третья
- Четвертая
- Четвертая

290. В стоматологическую поликлинику обратился больной с жалобами на сильные, постоянные боли позади второго моляра нижней челюсти, усиливающиеся при жевании; иррадиирующие в ухо и висок. Открывание рта болезненное. Слизистая позади 3.7 зуба гиперемирована, отечна; видны только медиальные бугры 3.8 зуба. На рентгенограмме – 3.8 зуб в вертикальном положении.

Выберите тактику лечения:

- Новокаин-антибиотиковая блокада
- *Иссечение капюшона**
- Периостотомия
- Удаление 3.8 зуба
- Аппликация Метрогилом

291. Больной О., 41 год, поступил в приёмный покой челюстно-лицевой больницы, диагноз: ментальный открытый перелом со смещением нижней челюсти слева. Из анамнеза выяснено, что травму получил за 3 часа до обращения, избит неизвестными возле своего дома. Лицо асимметрично за счет посттравматического отека мягких тканей в области нижней челюсти слева. Кожа над ним обычной окраски, не напряжена, при пальпации слабо болезненна. Открывание рта болезненно, ограничено до 1,5 см. В области отсутствующего 3.5 зуба имеется разрыв слизистой оболочки. Прикус нарушен по типу открытого. На рентгенографическом исследовании нижней

челюсти в прямой и боковой проекциях слева определяется линия перелома, в ментальном отделе слева, в виде полосы просветления, со смещения отломков. Какую шину целесообразно применить в этом случае

- двучелюстную шину с зацепными петлями и резиновой тягой
- двучелюстную шину с зацепными петлями без резиновой тяги
- стандартную шину Васильева

***двучелюстную шину с зацепными петлями, резиновой тягой и распорочным изгибом**

- двучелюстную шину с зацепными петлями, резиновой тягой и стандартной транспортной повязкой

292. Больной Г., 37 лет, обратился в приёмный покой челюстно-лицевой больницы, диагноз: ангулярный открытый со смещением перелом нижней челюсти слева. Алкогольное опьянение. Из анамнеза выяснено, что травму получил за 2 часа до обращения, избит неизвестными возле своего дома. Местно: лицо асимметрично за счет посттравматического отека мягких тканей в области нижней челюсти слева. Кожа над ним обычной окраски, не напряжена, при пальпации слабо болезненна. Открывание рта болезненно, ограничено до 1,5 см. За 3.6 зубом имеется разрыв слизистой оболочки. Прикус нарушен по типу открытого. На рентгенографическом исследовании в прямой и боковой проекциях слева нижней челюсти определяется линия перелома со смещения отломков проходящая по 3.6 зубу. Назначьте план лечения?

- фиксация и репозиция двучелюстными шинами с зацепными петлями и резиновыми кольцами

***фиксация и репозиция и двучелюстными шинами с зацепными петлями без резиновых колец**

- фиксация и репозиция двучелюстными шинами с зацепными петлями, остеосинтез костным швом
- фиксация и репозиция двучелюстными шинами с зацепными петлями, остеосинтез спицей Киршнера
- фиксация и репозиция двучелюстными шинами с зацепными петлями, остеосинтез мини-пластинами

293. Больной С., 35 лет, предъявляет жалобы на резкое ограничение открывания рта до 1,0 см, боли при глотании слева, общую слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38,0 °С. Из анамнеза выяснено, что около 5 дней назад было произведено удаление 37 зуба, удаление было сложным. За 2-ое суток до обращения, к вышеперечисленным жалобам присоединились вышеуказанные симптомы. Лицо симметрично. Кожные покровы слабо гиперемированы, несколько напряжены, при глубокой пальпации несколько болезненны. Открывание рта резко ограничено до 1,0 см. В полости рта: определяется гиперемированная слизистая оболочка крылочелюстной складки и небных дужек слева, левая небная дужка смещена к центру. Поставьте диагноз?

- флегмона крылочелюстного пространства
- ангина Людвига
- паратонзиллярный абсцесс

***флегмона крылочелюстного и окологлоточного пространств**

- флегмона окологлоточного пространства

294. Пациент Д., 35 лет, жалуется на боль в области верхней челюсти слева, иррадирующую в глазное яблоко; заложенность и выделение из левой половины носового хода; чувство тяжести, головные боли, повышение температуры тела до 40 С, понижение обоняния, слабость, недомогание. Из анамнеза – 2 дня назад появились головная боль, припухлость щеки слева, заложенность носа. Ткани подглазничной и щечной областей отечные. Кожа без изменений. Слизистая преддверия полости рта в области больших коренных зубов гиперемирована, отечна.

Пальпация в области собачьей ямки болезненна. 2.6 зуб разрушен на 1/3, перкуссия 2.5,2.6,2.7 зубов болезненна. Выберите тактику лечения:

***удаление 2.6 зуба + пункция гайморовой пазухи**

- лечение 2.6 зуба + пункция гайморовой пазухи
- гайморотомия по Колдуэлл-Люку
- радикальная гайморотомия
- вскрытие гнойника наружным доступом + удаление 2.6 зуба

295. Больной А., 29 лет обратился с жалобами на боль и припухлость в области носогубной складки слева. Из анамнеза: болен в течение 2 суток, когда появился «прыщ». Состояние постепенно ухудшилось. Объективно: общее состояние средней тяжести. Температура - 38,0, пульс – 90 ударов в мин, ЧД – 22 в мин. Асимметрия лица за счет отека мягких тканей в области носогубной складки слева. В данной области имеется инфильтрат 4,0х4,0 см, в центре инфильтрата 3 гнойных стержня, покрытых корочками. Кожа гиперемирована, отечна. Пальпация болезненная. Предположите предварительный диагноз:

- Абсцесс в области носогубной складки
- Абсцедирующий фурункул в области носогубной складки
- Флегмона в области носогубной складки
- Флебит угловой вены

***Карбункул в области носогубной складки**

296. Больной А., 28 лет. Из анамнеза: болен в течении 2 суток, когда заболел 25 зуб. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей в области верхней челюсти слева. Пальпация болезненна. Открывание рта болезненное. Коронка 25 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненна. Слизистая вокруг зуба гиперемирована, отечна, пальпация болезненная. Выберите инструмент для удаления 25 зуба:

- Прямые щипцы
- Прямой элеватор
- Клювовидные сходящиеся щипцы
- Клювовидные несходящиеся щипцы

***S-образно изогнутые щипцы**

297. Проведена местная анестезия 2% раствором новокаина. Через 5 минут больной отметил чувство онемения правой половины нижней губы, кончика языка. Данная картина характерна для:

***Неврита нижней ветви тройничного нерва**

- Анестезии язычного и щечного нервов справа
- Анестезии нижнелунного и подбородочного нервов справа
- Анестезии щечного нерва, язычного и подбородочного
- Анестезии нижнелунного и язычного нервов справа

298. В поликлинику обратился пациент Д., 27 лет с жалобами на резкую, постоянную боль в области 1.6 зуба, усиливающуюся при накусывании, отмечает чувство "выросшего" зуба. Объективно: лицо симметричное. Кожные покровы чистые, региональные лимфатические узлы увеличенные, болезненные при пальпации. Открывание рта свободное, слизистая оболочка десны в области 1.6 зуба гиперемирована, отечна. На небной поверхности коронки 1.6 зуба глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином, зондирование

безболезненно, перкуссия резко болезненна. На рентгенограмме - очаг разрежения костной ткани с четкими ровными контурами в области верхушки корня 1.6 зуба, округлой формы, диаметром до 0,3 x 0,3 см, имеется разрежение костной ткани в области бифуркации. Поставьте клинический диагноз и выберите инструмент для удаления 1.6 зуба:

***обострение хронического периодонтита 1.6 зуба, S- образные щипцы с шипом слева**

- хронический периодонтит 1.6 зуба, прямой элеватор
- острый периодонтит 1.6 зуба, S- образные сходящиеся щипцы
- острый пульпит 1.6 зуба, прямые щипцы
- хронический пульпит 1.6 зуба, S- образные щипцы с шипом справа

299. В клинику обратился пациент Х., 48 лет с жалобами на боли и припухлость в области верхней челюсти слева. Из анамнеза: болен в течении 2 суток, когда заболел 2.6 зуб. Зуб ранее лечен по поводу острого периодонтита. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей в области верхней челюсти слева. Пальпация болезненна. Открывание рта болезненное. Коронка 2.6 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненна. Слизистая оболочка десны вокруг 2.6 зуба гиперемирована, отечна. Перкуссия болезненна. На рентгенограмме - очаг разрежения костной ткани с четкими ровными контурами в области верхушки корней 2.6 зуба, диаметром до 0,4 x 0,5 см, имеется разрежение костной ткани в области бифуркации. Поставьте клинический диагноз и выберите инструмент для удаления 2.6 зуба:

- хронический периодонтит 2.6 зуба, прямой элеватор

***обострение хронического периодонтита 2.6 зуба, S- образные щипцы с шипом справа**

- острый периодонтит 2.6 зуба, S- образные сходящиеся щипцы
- острый пульпит 2.6 зуба, прямые щипцы
- хронический пульпит 2.6 зуба, S- образные щипцы с шипом слева

300. Пациент Л., 45 лет обратился в поликлинику с жалобами на боли и припухлость в области верхней челюсти слева. Из анамнеза: болен в течении 2 суток, когда заболел 2.1 зуб. Появилась припухлость. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей в области верхней губы слева. Пальпация болезненна. Открывание рта болезненное. Коронка 2.1 зуба разрушена на 2/3, перкуссия болезненна. Переходная складка сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена. Поставьте предварительный диагноз и определите положение врача при выполнении хирургического вмешательства:

- острый гнойный периодонтит 2.1 зуба, сзади и справа
- острый гнойный лимфаденит от 2.1 зуба, спереди и слева
- *острый гнойный периостит от 2.1 зуба, спереди и справа**
- острый одонтогенный остеомиелит от 2.1 зуба, сзади и слева
- абсцесс верхней губы от 2.1 зуба, сзади и справа

301. В клинику обратился пациент Ф., 35 лет. Поставлен диагноз: Обострение хронического периодонтита 2.4 зуба. Планируется операция удаление 2.4 зуба. Во время проведения операции удаление зуба, врач встал впереди и справа от пациента. Врач отслоил десну, наложил прямые щипцы и приступил к ротации. Коронка 2.4 зуба сломалась. Определите тактическую ошибку врача:

- неправильное положение врача
- неправильное положение головы пациента
- *неправильный выбор щипца и техники удаления зуба**
- неправильная техника удаления зуба и положение врача

- неправильная техника удаления зуба и положение головы пациента

302. Пациенту Ы., 28 лет, для удаления корней 2.6 зуба врач применил штыковидные щипцы. Удалить корни зуба с помощью щипцов не удалось. Небный корень 2.6 зуба располагается близко ко дну верхнечелюстного синуса. Выберите инструмент для успешного завершения операции удаление корней 2.6 зуба:

- S-образные щипцы с шипами
- *бормашина**
- S-образные щипцы без шипов
- клювовидные щипцы несходящиеся
- клювовидные щипцы сходящиеся

303. В клинику обратился пациент В., 20 лет, перед удалением зуба врач-стоматолог левой рукой охватывает голову больного, большим пальцем фиксирует альвеолярный отросток, указательным пальцем оттягивает нижнюю губу. Эти действия хирурга характерны при выполнении операции удаление зуба:

- на нижней челюсти слева
- третьих моляров слева
- на верхней челюсти справа
- на верхней челюсти слева
- *на нижней челюсти справа**

304. В стоматологическую поликлинику обратилась пациентка Б., 29 лет с жалобами на боли в области нижней челюсти слева. Из анамнеза: больна в течении 2 суток. Объективно: коронковая часть 3.6 зуба разрушена на 2/3, перкуссия резко болезненна, слизистая оболочка вокруг зуба гиперемирована, отечна. Пациенту показана мандибулярная анестезия. При выполнении мандибулярной анестезии происходит блокада следующих нервов:

- подглазничного, носонебного
- носонебного, большого небного
- язычного, щёчного и нижнеальвеолярного
- *язычного и нижнеальвеолярного**
- щёчного и нижнеальвеолярного

305. В клинику обратилась пациентка Т., 19 лет с жалобами на боли в области верхней челюсти слева. Объективно: асимметрия лица за счет коллатерального отека мягких тканей верхней челюсти слева. Переходная складка в области 1.6, 1.7 зубов сглажена, гиперемированна, отечна. При пальпации отмечается флюктуация. Наиболее целесообразным методом обезболивания является:

- инфильтрационная анестезия и интралигаментарная
- резцовая анестезия и небная
- палатинальная анестезия и мандибулярная
- *туберальная анестезия и инфильтрационная**
- инфроорбитальная анестезия и небная

306. Пациенту И., 36 лет в целях удаления 3.6 зуба, врач провел мандибулярную анестезию. Через 10 минут приступил к отслоению десневого края 3.6 зуба. С язычной стороны отслойка

производилась без боли, а с вестибулярной - из-за болевых ощущений пациент отсложку проводить не дал. Объясните причину болевых ощущений:

- не проведена блокада подглазничного нерва
- * не проведена блокада щечного нерва
- не проведена блокада нижнечелюстного нерва
- не проведена блокада язычного нерва
- не проведена блокада небного нерва

307. У пациента М., 24 лет, после проведения локальной анестезии убестезином, через 5 минут появилось чувство онемения правой половины нижней губы, подбородка и кончика языка. При проведении данной анестезии произошло блокирование:

***нижнелуночкового, щечного и язычного нервов**

- небного и резцового нервов
- верхнелуночкового и небного нервов
- щечного и подглазничного нервов
- ветвей лицевого нерва

308. В клинику обратилась пациентка З., 25 лет. На рентгенограмме в области 2.1 зуба определяется глубокий костный карман. Определено показание для гингивотомии. Анестезия выполнена следующим образом: по переходной складке с вестибулярной стороны врач вывел анестетик на уровне 2.2, 2.1, 1.1 зубов. С небной стороны, точка вкола располагалась у основания резцового сосочка слева, после вкола выпустил 0,5 мл раствора анестетика, было побледнение резцового сосочка. Определите метод анестезии, выполненный врачом:

- торусальная, небная
- инфраорбитальная, небная
- туберальная, небная
- по Берше-Дубову

***инфильтрационная, резцовая**

309. Пациенту Э., 40 лет врач поставил диагноз: затрудненное прорезывание 4.8 зуба, осложненное острым гнойным перикоронаритом. Для проведения операции удаление 4.8 зуба, наиболее эффективно блокировать следующие ветви нерва:

***нижнелуночковый, язычный, щечный**

- щечный, носонебный, резцовый
- небный, инфраорбитальный, лицевой
- верхний задний луночковый
- верхний передний луночковый

310. У пациента С., 37 лет, во время проведения туберальной анестезии появилась припухлость в щечной области справа. Через 2 часа кожа над припухлостью окрасилась в синюшный цвет. Определите причину образования гематомы при проведении местного обезболивания:

***повреждение венозного сплетения**

- нарушение правил асептики
- быстрое введение анестетика
- аллергия к местному анестетику
- повреждение нервных волокон

311. Появление у пациента М., 19 лет после проведения местной анестезии головной боли, чувство жара, мелькание «мушек» перед глазами характерно, для:

- гипертонического криза
- приступа бронхиальной астмы

***обморока**

- отека Квинке
- инфаркта миокарда

312. В клинику обратился пациент Е., 18 лет, с жалобами на боли, припухлость щечной области справа, недомогание, повышение температуры тела до 37,20С. Болеет в течение 5 суток, когда заболел 4.6 зуб. 2 суток назад появилась припухлость щечной области. При осмотре: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти справа. Пальпация болезненна. Открывание рта болезненное. Коронка 4.6 зуба разрушена на 2/3. Переходная складка сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена. Пальпация болезненна. Поставьте предварительный диагноз и определите принципы лечения:

***острый гнойный периостит от 4.6 зуба, хирургическое лечение**

- острый гнойный периодонтит 4.6 зуба, депульпирование зуба
- острый гнойный пульпит 4.6 зуба, хирургическое лечение
- хронический периостит от 4.6 зуба, депульпирование зуба
- острый остеомиелит от 4.6 зуба, депульпирование зуба

313. В клинику обратился пациент Ж., 45 лет с жалобами на боли и припухлость в области нижней челюсти справа, слабость, недомогание. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей в области нижней челюсти справа. Открывание рта болезненное. Коронка 4.7 зуба разрушена на 1/3, перкуссия болезненна. Переходная складка в области нижней челюсти справа сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена, пальпация болезненна. Поставьте предварительный диагноз и определите тактику лечения:

- острый гнойный периодонтит 4.7 зуба, удаление зуба
- острый гнойный пульпит 4.7 зуба, периостотомия с сохранением зуба

***острый гнойный периостит от 4.7 зуба, периостотомия с удалением зуба**

- острый гнойный лимфаденит от 4.7 зуба, противовоспалительная терапия
- хронический периодонтит 4.7 зуба, эндодонтическое лечение

314. В клинику обратился пациент Л., 18 лет с жалобами на солоноватый вкус в полости рта, припухлость в околоушно-жевательной области справа. При осмотре: асимметрия лица за счет отека околоушно-жевательной области справа. В данной области определяется увеличенная околоушная слюнная железа, при пальпации бугристая, слегка болезненная. Открывание рта свободное. Устье протока околоушной слюнной железы справа гиперемированное, отечное, из протока - мутная вязкая слюна. На сиалографии - расширение протоков II-III порядка, протоки IV-V порядков не определяются. Поставьте клинический диагноз:

***хронический паренхиматозный сиалоаденит**

- хронический интерстициальный сиалоаденит
- калькулезный хронический сиалоаденит
- хронический сиалодохит
- острый эпидемический сиалоаденит

315. В клинику обратился пациент М., 29 лет с жалобами на боли и припухлость в околоушно-жевательных областях. 7 суток назад переболел гриппом. Объективно: асимметрия лица за счет отека околоушно-жевательных областей. Околоушные слюнные железы увеличены с обеих сторон, увеличены и болезненны при пальпации околоушные и подчелюстные лимфатические узлы. Отмечается болезненность при пальпации кпереди от козелка ушной раковины, под вырезкой нижней челюсти и у вершины нижней челюсти. Кожа над припухлостью без изменений. Открывание рта болезненное. Слюна из стенового протока чистая. Поставьте предварительный диагноз:

***эпидемический сиалоденит**

- ложный сиалоденит
- болезнь Микулича
- синдром Шегрена
- острый гнойный сиалоденит

316. Пациент М., 39 лет обратился в клинику с жалобами на боли в зубе нижней челюсти слева, ограничение открывания рта, припухлость щеки, повышение температуры тела до 38,0 °C, слабость, недомогание. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей щечной области слева. Кожа лица обычной окраски. Открывание рта ограничено 2-й степени. Медиальные бугры 4.8 зуба над слизистой, дистальные бугры под слизистой оболочкой полости рта. Из-под капюшона обильное гноетечение. Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны. Поставьте предварительный диагноз:

- острый катаральный перикоронорит

***острый гнойный перикоронорит**

- позадималярный периостит
- абсцесс щечной области слева
- абсцесс крыловидно-нижнечелюстной складки

317. У пациента Н., 50 лет, жалобы на невозможность закрыть рот, боли в верхнем отделе околоушно-жевательных областей. Из анамнеза: при широком открывании рта, во время еды что-то щелкнуло, и пациент не смог закрыть рот. И это продолжается в течение 2 лет. Объективно: асимметрия лица за счет удлинения его нижней трети и смещения подбородка кпереди. Из рта обильно выделяется слюна, но язык сухой. Ткани впереди козелка уха слева и справа западают, а под скуловой дугой пальпируются головки суставных отростков. Прикус открытый. На рентгенограмме отмечается плоская головка нижней челюсти. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

- задний вывих, артропластика
- перелом суставных отростков, остеосинтез

***привычный передний вывих, вправление по Гиппократу**

- анкилоз, артропластика
- деформирующий остеоартроз, остеотомия

318. В клинику обратился пациент Я., 57 лет с жалобами на невозможность закрывания рта, обильное слюнотечение изо рта. Из анамнеза: при зевании появилось щелканье в области височно-нижнечелюстных суставов, после чего пациент не смог закрыть рот. На рентгенограмме: четко определяются суставные головки нижней челюсти, расположенные на переднем скате суставного бугорка. Суставная впадина свободна. Для какого вывиха нижней челюсти характерна данная картина:

***двустороннего переднего вывиха нижней челюсти**

- одностороннего заднего вывиха нижней челюсти
- двустороннего заднего вывиха нижней челюсти
- одностороннего переднего вывиха нижней челюсти
- комбинированного вывиха нижней челюсти

319. В клинику обратился пациент Ш., 29 лет с жалобами на хруст, щелканье в суставе справа, боли при открывании рта. Из анамнеза: болеет в течение 6 месяцев, за помощью не обращался.

Объективно: лицо симметричное, при пальпации височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) определяется хруст, щелканье в правом суставе, при боковых движениях экскурсия суставной головки справа слегка увеличена и болезненна. На рентгенограмме: 3.6 зуб отсутствует, центральная линия нижней челюсти смещена на 0,2 см влево. Поставьте клинический диагноз и определите принципы лечения:

- подвывих нижней челюсти, хирургическое лечение
- артрит ВНЧС, хирургическое лечение
- артроз ВНЧС, хирургическое лечение

***болевая дисфункция ВНЧС, комплексное лечение**

- анкилоз ВНЧС, ортодонтическое лечение

320. В клинику обратился пациент Г., 19 лет с жалобами на хруст и боли в области височно-нижнечелюстного сустава справа. При осмотре: асимметрия лица за счет увеличения мягких тканей околоушно-жевательной области справа. Открывание рта болезненное. Прикус нарушен. Центральная линия нижней челюсти смещена на 0,2 см вправо. Отсутствует 3.6 зуб. Определите дополнительный метод обследования зубочелюстной системы:

***компьютерная томография**

- визиография
- ультразвуковое исследование
- сиалогграфия
- иммунологическое исследование слюны

321. В клинику обратился пациент Ю., 30 лет с жалобами на боли при жевании, ограничение открывания рта. Из анамнеза: 1 сутки назад избили неизвестные лица. Сознание не терял, тошноту и рвоту не отмечал. Объективно: асимметрия лица, за счет отека мягких тканей лица справа. Пальпация болезненна по углу нижней челюсти справа. Ограничение открывания рта до 1,5 см. Положительный симптом «нагрузки» по углу справа. Прикус нарушен. На рентгенограмме: линия перелома по углу справа без смещения. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

- перелом тела нижней челюсти справа, шина Померанцевой-Урбанской
- ментальный перелом нижней челюсти слева, шина Збаржа
- Сперелом суставного отростка нижней челюсти справа, фиксация по Фальтину-Адамсу

***перелом нижней челюсти по углу справа, шина Тигерштедта**

- внутрисуставной перелом, остеосинтез

322. В клинику обратился пациент К., 47 лет с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. При осмотре: асимметрия лица за счет западения верхней губы, опущение углов рта. Открывание рта свободное, отмечается полное отсутствие альвеолярного отростка, резко

уменьшены размеры челюсти и верхнечелюстного бугра, плоское небо, широкий торус.

Определите тип беззубой верхней челюсти по Шредеру:

- I тип
- II тип
- *III тип**
- IV тип
- V тип

323. В клинику обратился пациент А., 43 лет с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. При осмотре: асимметрия лица за счет западения верхней губы, опущение углов рта. Открывание рта свободное, отмечается хорошо выраженный альвеолярный отросток во фронтальном отделе и значительная атрофия в боковых отделах. Определите тип беззубой верхней челюсти по Дойникову А.А.:

- I тип
- II тип
- III тип
- *IV тип**
- V тип

324. В клинику обратился пациент Т., 48 лет с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. При осмотре: асимметрия лица за счет западения верхней губы, опущение углов рта. Открывание рта свободное, отмечается выраженный альвеолярный отросток в боковых отделах и значительная атрофия фронтальном отделе. Определите тип беззубой верхней челюсти по Дойникову А.А.:

- I тип
- II тип
- III тип
- IV тип
- *V тип**

325. Врач стоматолог-ортопед проводит проверку окклюзионных контактов, на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза, при следующих видах окклюзий:

- боковой
- центральной и сагиттальной
- сагиттальной и боковой
- *боковой, передней и центральной**
- центральной и боковой

326. Врач стоматолог-ортопед проводит одонтопрепаровку 2.5 зуба под фарфоровую коронку. Определите место расположения уступа:

- с оральной стороны
- на вестибулярной поверхности
- с оральной и апроксимальных сторон
- на апроксимальных поверхностях
- *по всему периметру шейки зуба**

327. Врач стоматолог-ортопед проводит припасовку штампованной коронки. Определите уровень погружения края штампованной коронки в зубодесневой желобок:

***0,2-0,5**

- 0,5-1,0
- 1,0-1,5
- 1,5-2,0
- 2,0-2,5

328. Причинами непригодности каркаса бюгельного протеза является:

- ощущение во рту инородного тела при припасовке и наложении каркаса
- большая протяженность каркаса и сложность его конструкции

***отсутствие зазора между дугой и слизистой оболочкой**

- применение кламмеров разных типов
- появление повышенной саливации

329. В клинику обратился пациент И., 19 лет с жалобами на изменение цвета зубов, причем цвет зубов изменился с момента прорезывания. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На вестибулярной поверхности 1.4,1.5,1.6,2.4, 2.5, 2.6 зубов имеются пятна желтоватого цвета, различной формы с гладкой, блестящей поверхностью. Пятна не окрашиваются красителями. Поставьте предварительный диагноз:

***системная гипоплазия**

- кариес эмали
- аплазия
- недоразвития эмали
- флюороз

330. Мягкий, прозрачный, клейкий материал, состоящий из бактерий и продуктов их жизнедеятельности, который плотно фиксирован на поверхности зуба и при определенных условиях способен создать кислую среду, достаточную для деминерализации эмали является:

- слюной
- поддесневым зубным камнем
- эмалью

***зубной бляшкой**

- наддесневым зубным камнем

331. В клинику обратился пациент К., 35 лет с целью профилактического осмотра полости рта. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 3.6 зуба имеется пятно белого (мелового) цвета. На температурный раздражитель 3.6 зуб реагирует появлением чувствительности, которая проходит с устранением раздражителя. Белое пятно окрашивается 2% раствором метиленового синего. Поверхность эмали гладкая с участком шероховатости. Поставьте предварительный диагноз:

- кариес дентина
- некроз эмали
- гипоплазия

***кариес эмали**

- флюороз

332. В клинику обратился пациент Е., 37 лет с жалобами на кратковременные боли при приеме пищи. Со слов пациента боли беспокоят в течение 6 месяцев. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 4.7 зуба имеется кариозная полость заполненная остатками пищи. Отмечается болезненность, быстро проходящая от холодной воды. При зондировании целостность дентино-эмалевого соединения нарушена, но дном кариозной полости является неизмененный дентин. Поставьте предварительный диагноз:

- некроз эмали

- *кариес дентина**

- гипоплазия

- кариес эмали

- флюороз

333. В клинику обратился пациент Я., 27 лет с жалобами на ноющие постоянные боли в области 4.5 зуба. Со слов пациента болеет в течение 3 суток, 1 год назад 4.5 зуб лечен по поводу кариеса дентина. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На контактной поверхности 4.5 зуба имеется частичная пломба. Зондирование безболезненное. Перкуссия зуба болезненная. При удалении размягченного дентина кариозная полость не сообщается с полостью зуба. Показатели ЭОД=105мкА. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- острый пульпит, окрашивание 4.5 зуба

- хронический пульпит, рентгенография 4.5 зуба

- *острый периодонтит, рентгенография 4.5 зуба**

- хронический периодонтит, рентгенография 4.5 зуба

- обострение хронического периодонтита, цитология

334. В клинику обратился пациент В., 37 лет с жалобами на незначительные болевые ощущения при накусывании на 3.4 зуба. Со слов пациента болеет в течение 7 суток, 1 год назад 3.4 зуб лечен по поводу острого пульпита. При осмотре: лицо симметричное, открывание рта свободное. На контактной поверхности 3.4 зуба имеется кариозная полость, пломба отсутствует. При зондировании кариозная полость сообщается с полостью зуба, боли отсутствуют. Перкуссия и пальпация 3.4 зуба безболезненны. По переходной складке в проекции корня 3.4 зуба имеется свищ с гнойным экссудатом. Показатели ЭОД=108мкА. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- острый пульпит, окрашивание 3.4 зуба

- хронический пульпит, рентгенография 3.4 зуба

- острый периодонтит, рентгенография 3.4 зуба

- *хронический периодонтит, рентгенография 3.4 зуба**

- обострение хронического периодонтита, цитология

335. В клинику обратился пациент С., 57 лет с жалобами на постоянные ноющие боли в области 3.6 зуба, припухлость щечной области слева. Со слов пациента болеет в течение 5 суток. Состоит на учете с диагнозом сахарный диабет 2 типа, хронический генерализованный пародонтит. При осмотре: асимметрия лица за счет отека щечной области слева. Открывание рта болезненное. Имеется оголение шеек 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубов, глубокий пародонтальный карман в области 3.6 зуба, подвижность зуба I-II степени, болезненна горизонтальная перкуссия. Десна в области 3.6 зуба с вестибулярной стороны гиперемирована, отечна, определяется флюктуация. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

***острый пародонтальный абсцесс в области 3.6 зуба, ортопантомография**

- острый гнойный периостит, рентгенография 3.6 зуба
- острый гнойный периодонтит, рентгенография 3.6 зуба
- хронический периодонтит, рентгенография 3.6 зуба
- обострение хронического периодонтита, ортопантомография

336. В клинику обратился пациент С., 66 лет с жалобами на язву в области спинки языка, затрудненное пережёвывание пищи. На протяжении 10 лет отмечает периодически возникающие язвы в полости рта. При осмотре: снижение высоты нижнего отдела лица, имеется западение спинки носа седловидный нос. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, безболезненны, подвижны. Открывание рта свободное. На спинки языка имеется язва округлой кратерообразной формы с плотными выступающими краями, безболезненная при пальпации. В области мягкого неба рубцовые изменения, язычок отсутствует. Поставьте предварительный диагноз и определите специалиста:

- туберкулезная язва, лечение у фтизиатра
- рак языка, лечение у онколога

***гуммозный сифилид, лечение у венеролога**

- хроническая афта, лечение у стоматолога
- травматическая язва, лечение у стоматолога

337. В клинику обратилась пациентка А., 68 лет с жалобами на постоянные боли в заднем отделе альвеолярного гребня слева. Боли усиливаются во время еды и при разговоре, беспокоит в течение 1 месяца. Появление боли пациентка связывает с изготовлением полного съемного протеза на нижнюю челюсть. В анамнезе: гипертоническая болезнь II степени. При осмотре: в ретромолярной области слева имеется дефект в пределах слизистой оболочки 1,5*1,5 см, болезненны при пальпации, с неровными краями и дном, покрытым некротическим налетом. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, болезненны, подвижны. Поставьте предварительный диагноз и определите специалиста:

- туберкулезная язва, лечение у фтизиатра
- рак языка, лечение у онколога
- гуммозный сифилид, лечение у венеролога
- хронический афтозный стоматит, лечение у стоматолога

***травматическая язва, лечение у стоматолога**

338. В клинику обратилась пациентка К., 48 лет с жалобами на неприятные осушения, жжения, гиперемия слизистой оболочки полости рта, металлический привкус во рту. Со слов пациента эти симптомы появились 2 года назад, после изготовления несъемного протеза из металлокерамики. При осмотре: имеются несъемные протезы из разных материалов, слизистая полости рта вокруг протезов гиперемирована, отечна и покрыта белесоватым налетом. Поставьте предварительный диагноз и определите тактику лечения:

- острый афтозный стоматит, лечение кератопластиками

***гальванизм, замена протезов из однородного металла**

- многоформная экссудативная эритема, антигистаминная терапия
- контактный аллергический стоматит, антигистаминная терапия
- вульгарная пузырчатка, гормональная терапия

339. Пациент 30 лет обратился с жалобами на жжение и пощипывание языка при приеме раздражающей пищи. Страдает канцерофобией. Объективно: на средней линии языка - обнаруживается единичный очаг овальной формы, слегка запавший за счет отсутствия нитевидных сосочков. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

***Ромбовидный глоссит**

- Глоссалгия
- Складчатый язык
- Десквамативный глоссит
- Черный «волосатый» язык

340. Женщина 35 лет, обратилась с жалобами на постоянные ноющие боли, усиливающиеся при накусывании в зубе верхней челюсти справа. Из анамнеза: зуб ранее лечен. Объективно: в 17 зубе постоянная пломба на жевательной поверхности. Перкуссия болезненна. Слизистая оболочка в области 17 зуба гиперемирована, отечна; переходная складка сглажена, болезненна при пальпации. ЭОД – 120 мкА. На рентгенограмме: в области верхушки щечно-медиального корня расширение периодонтальной щели. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- обострение хронического фиброзного пульпита
- обострение хронического гангренозного пульпита
- обострение хронического гранулематозного периодонтита
- обострение хронического гранулирующего периодонтита

***обострение хронического фиброзного периодонтита**

341. Больная 32 лет жалуется на боль от температурных раздражителей в зубе верхней челюсти справа. Объективно: на жевательной поверхности 16 зуба имеется кариозная полость в пределах околопульпарного дентина. Реакция на температурный раздражитель (холод) - быстропроходящая боль. Зондирование дна кариозной полости болезненно. Перкуссия безболезненна. ЭОД-12 мкА. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- Средний кариес

***Глубокий кариес**

- Хронический фиброзный пульпит
- Острый диффузный пульпит
- Острый очаговый пульпит

342. Пациент 28 лет обратился с жалобами на косметические дефекты зубов верхней челюсти. Отмечает изменение цвета зубов с детства. В детстве перенес рахит. При осмотре: на вестибулярной поверхности 11, 12, 21, 22 и буграх 16, 26 зубов имеются симметрично расположенные меловидные пятна. Поверхность пятен ровная, гладкая, не окрашивается 2% раствором метиленового синего. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- Флюороз, пятнистая форма
- Начальный кариес
- Флюороз, штриховая форма

***Гипоплазия, пятнистая форма**

- Флюороз, меловидно-крапчатая форма

343. Пациент 24 лет жалуется на ноющие боли при приеме пищи в зубе нижней челюсти справа. Из анамнеза: отмечались самопроизвольные боли в прошлом. При осмотре 47 зуба коронка

изменена в цвете, на дистально-жевательной поверхности глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Глубокое зондирование болезненное. ЭОД – 80 мкА. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- хронический фиброзный пульпит
- хронический гранулематозный периодонтит

***хронический гангренозный пульпит**

- хронический фиброзный периодонтит
- хронический гранулирующий периодонтит

344. Пациент 52 лет обратился с жалобами на подвижность зубов, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта. Из анамнеза: ранее с заболеванием десен к врачу не обращался. Состоит на учете по поводу хронического холецистита. Объективно: слизистая оболочка десны застойно гиперемирована, отечная, рыхлая, пародонтальные карманы глубиной 6-8 мм с обильным гнойным отделяемым, отложения над- и поддесневого зубного камня в области фронтальных зубов нижней челюсти, верхних и нижних моляров, подвижность зубов II-III степени. На рентгенограмме: горизонтальная и вертикальная резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2-2/3 длины корней. Предварительный диагноз:

- Пародонтолиз
- Пародонтоз III степени
- Хронический генерализованный пародонтит II степени

***Хронический генерализованный пародонтит III степени**

- Обострение хронического генерализованного пародонтита II степени

345. Девушка 28 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на эстетический дефект, связанный с изменением цвета и разрушением коронок зубов, которые отмечает с детства. При объективном осмотре: коронки 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубов хрупкие, имеет желто-соломенный оттенок, форма зубов изменена, высота коронок несколько снижена. Какой метод лечения является наиболее целесообразным?

- Удаление зубных отложений

***Реставрация зубов**

- Изготовление металлических коронок
- Некрозэктомия
- реминерализующая терапия

346. Больная 40 лет жалуется на значительную кровоточивость десен при чистке зубов и откусывании твердой пищи, расшатанность передних зубов нижней челюсти. При осмотре: отмечаются выраженные явления цианоза межзубных десневых сосочков, изменение их конфигурации, выбухание, неплотное прилегание к зубам, кровоточивость. Пародонтальные карманы глубиной 4-5 мм. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

- острый катаральный гингивит
- гипертрофический гингивит
- хронический пародонтит легкой степени

***хронический пародонтит средней степени**

- хронический пародонтит тяжелой степени

347. В пораженном зубе периодически самопроизвольно возникают кратковременные боли длительностью 10-15 минут. Затем прекращаются на длительное время (на 2-3 часа). Различные

раздражители (температурные, механические) провоцируют внеочередной болевой приступ или усиливают уже имеющиеся болевые ощущения. Для какого заболевания характерны указанные болевые ощущения?

- Острый гнойный пульпит
- Острый общий пульпит
- *Острый очаговый пульпит**
- Острый травматический пульпит
- Хронический простой пульпит

348. В пораженном зубе периодически самопроизвольно возникают длительные боли продолжительностью 1-2 часа, которые успокаиваются на 10-15 минут. Боль иррадирует по ходу нервных ветвей, усиливается в ночное время и от воздействия раздражителей. Ранее зуб не беспокоил. Для какого заболевания характерны указанные болевые ощущения?

- Острый гнойный пульпит
- *Острый диффузный пульпит**
- Острый частичный пульпит
- Острый травматический пульпит
- Обострение хронического простого пульпита

349. При какой форме воспаления пульпы в области верхушечного периодонта и окружающей костной ткани обнаруживаются изменения, определяемые рентгенологически?

- Острый общий пульпит
- Хронический простой пульпит
- Острый частичный пульпит
- Хронический гипертрофический пульпит
- *Хронический гангренозный пульпит**

350. Клиническими симптомами острого очагового пульпита является:

- *Приступообразная самопроизвольная боль с длительными межболевыми промежутками**
- Приступообразная самопроизвольная боль с короткими межболевыми приступами
- Кратковременная боль от температурных раздражителей
- Боль, усиливающаяся при контакте с зубом -антагонистом
- Продолжительная боль от химических раздражителей

351. Пациентка, 20 лет обратилась с жалобами на наличие дефектов на коронках фронтальных зубов нижней и верхней челюстей. Из анамнеза: дефекты заметила давно, со времени прорезывания зубов. Объективно: на вестибулярной поверхности резцов и клыков верхней и нижней челюстей в пришеечной трети коронок определяются горизонтальные дефекты эмали, расположенные на одном уровне. При зондировании эмаль гладкая, плотная, реакция на температурные раздражители безболезненна. Наиболее вероятный диагноз:

- эрозия зубов
- клиновидный дефект
- *системная гипоплазия, бороздчатая форма**
- некроз твердых тканей зубов
- флюороз зубов, эрозивная форма

352. Какой из перечисленных ниже клинических признаков НАИБОЛЕЕ соответствует глубокому кариесу?

- Изменение цвета эмали
- Полость в пределах эмали
- Полость в пределах плащевого дентина
- *Полость в пределах околопульпарного дентина**
- Имеется сообщение с полостью зуба

353. Мужчина, 25 лет обратился к врачу с жалобами на неприятный запах из зуба. Из анамнеза: зуб в прошлом сильно болел, после приема горячего возникает длительная боль. При осмотре: коронка 2.6 зуба изменена в цвете, глубокая кариозная полость сообщается с полостью зуба. Поверхностное зондирование пульпы безболезненное, глубокое-болезненное. ЭОД-80мкА. Клинике какого пульпита соответствует данная картина?

- *Хронического гангренозного пульпита**
- Хронического фиброзного периодонтита
- Хронического фиброзного пульпита
- Хронического гранулирующего периодонтита
- Хронического гранулематозного периодонтита

354. Пациент 50 лет, жалуется на ноющие боли и чувство распирания в зубе верхней челюсти слева. При осмотре: 2.7 зуб изменен в цвете, на медиально- жевательной поверхности глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Перкуссия зуба безболезненна, слизистая в области проекции верхушек корней цианотична, рубец от свища. На рентгенограмме в области верхушки небного корня очаг разрежения костной ткани с неровными очертаниями размером до 4 мм. Какой диагноз является наиболее вероятным?

- Хронический фиброзный периодонтит
- Хронический гранулематозный периодонтит
- *Хронический гранулирующий периодонтит**
- Хронический гангренозный пульпит
- Хронический фиброзный пульпит

355. При лечении среднего кариеса врач-стоматолог провел препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение изолирующей прокладки на дно кариозной полости, кондиционирование эмали и дентина, нанесение адгезива, заполнение полости постоянной пломбой химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы. Какая ошибка допущена при проведении лечения?

- *Изолирующая прокладка не наложена еще и на стенки кариозной полости**
- На дно полости не наложена лечебная прокладка
- Не отсвечен адгезив
- Не отсвечена пломба
- Не отсвечены адгезив и послойно пломба

356. Патология, при которой проводится в первое посещение – обезболивание, препарирование кариозной полости, высушивание, лечебная прокладка, временная пломба. Через 5-7 дней наложение лечебной, изолирующей прокладок, постоянная пломба:

- *глубокий кариес, быстро прогрессирующее течение**
- поверхностный кариес

- глубокий кариес, медленно прогрессирующее течение
- средний кариес, быстро прогрессирующее течение
- средний кариес, медленно прогрессирующее течение

357. Пациент, 20 лет, обратился с жалобами на ночную, приступообразную, самопроизвольную боль в зубе верхней челюсти слева, усиливающуюся при приеме пищи. Боль появилась накануне вечером. Ранее беспокоило чувство дискомфорта при приеме пищи. В полости рта: на дистально-жевательной поверхности 2.4 зуба глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование и реакция на раздражители болезненны, перкуссия слабоболезненна, слизистая оболочка в проекции корней 2.4 не изменена. Наиболее вероятный диагноз:

- Острый диффузный пульпит
- *Обострение хронического фиброзного пульпита**
- Острый очаговый пульпит
- Обострение хронического гангренозного пульпита
- Острый верхушечный периодонтит

358. Пациент, 26 лет обратился к врачу-стоматологу с целью профилактического осмотра.

Объективно: на вестибулярной поверхности в пришеечной области 1.5, 1.4, 2.5 зубов на фоне очагов деминерализации определяются неглубокие дефекты в пределах эмали и поверхностных слоев дентина, при зондировании поверхность дефектов шероховатая. Реакция на термические раздражители кратковременная. ЭОД=4 мкА. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную диагностику?

- Кариес в стадии пятна
- *Клиновидный дефект**
- Системная гипоплазия
- Флюороз
- Травма твердых тканей зуба

359. Пациент Т., 20 лет, обратился с жалобами на боли и припухлость в щечной области слева. Из анамнеза: припухлость появилась 2-ое суток назад после выдавливания «прыща». Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей щечной области слева. В данной области определяется инфильтрат диаметром 1,5×2,0 см, в центре инфильтрата имеется гнойный стержень, пальпация болезненна. Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического лечения:

- целлюлит щечной области, периостотомия
- флегмона щечной области, дренирование гноя
- *абсцедирующий фурункул щечной области, дренирование гноя**
- карбункул щечной области, остеоперфорация
- лимфаденит щечной области, пункция

360. В клинику обратился пациент С., 42 лет с жалобами на боли при глотании, припухлость в подчелюстной области справа, ограничение открывания рта, слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38,5. Из анамнеза: со слов пациента болеет в течение 5 суток, когда появились боли в 4.6 зубе, 3 суток назад появилась припухлость, состояние ухудшилось. Зуб ранее не лечен. Объективно: общее состояние средней тяжести, асимметрия лица за счет отека поднижнечелюстной области справа. В данной области пальпируется инфильтрат 6,0 4,0 см, кожа над ним гиперемирована, отечна, напряжена. Открывание рта ограничено до 2,0 см. Коронка 4.6

зуб разрушена на 2/3, перкуссия болезненна. Слизистая крыловидно-челюстной складки гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. Поставьте предварительный диагноз:

· флегмона поднижнечелюстной, подподбородочной областей от 4.6 зуба

***флегмона поднижнечелюстной, крыловидно-челюстной областей от 4.6 зуба**

· флегмона окологлоточной, подподбородочной областей от 4.6 зуба

· флегмона подмассетеральной, подподбородочной областей от 4.6 зуба

· флегмона поднижнечелюстной, щечной областей от 4.6 зуба

361. Пациент Н., 46 лет, поступил в клинику с жалобами на наличие гнойного экссудата из свища в поднижнечелюстной области слева. Из анамнеза: 2 месяца назад получил травму, за помощью не обращался. Отмечались боли и припухлость в поднижнечелюстной области слева, которые самопроизвольно исчезли через 2-3 недели. Объективно: в поднижнечелюстной области слева имеется свищевой ход с выбухающими грануляциями и гнойным экссудатом. Открывание рта ограничено до 2,5 см. Прикус нарушен, имеется свищ с грануляциями на десне между 3.6 и 3.7 зубами. Определяется подвижность отломков между 3.6 и 3.7 зубами. На рентгенограмме определяется линия перелома между 3.6 и 3.7 зубами. В линии перелома определяются дистальные корни 3.6 зуба и мелкие секвестры. Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического лечения:

***постравматический остеомиелит нижней челюсти, секвестрэктомия**

· одонтогенный остеомиелит нижней челюсти, дренирование свища

· ментальный перелом нижней челюсти, наложение шины

· перелом ветви нижней челюсти, репозиция отломков

· перелом угла нижней челюсти, остеосинтез

362. В клинику пациенту П., 25 лет, поставлен диагноз: Хронический периодонтит 4.6 зуба и запланировано удаление 4.6 зуба. Во время проведения мандибулярной анестезии произошел отлом кончика инъекционной иглы. Отломок иглы, находящийся в мягких тканях, визуально не определяется. Определите тактику дальнейшего ведения пациента:

· расщепить мягкие ткани, извлечь его самостоятельно

***направить больного на рентгенографию**

· наблюдение в условиях стационара

· выжидательная тактика до отграничения инородного тела

· лечебных мероприятий не требуется

363. В клинику обратилась пациентка Ю., 35 лет с жалобами на постоянные, ноющие боли в лунке удаленного 4.6 зуба, иррадирующие по ходу ветвей тройничного нерва, нарушение приема пищи, повышение температуры тела по вечерам. Из анамнеза: 4.6 зуб удален 3 дня назад. За медицинской помощью не обращался. Объективно: лицо симметричное, открывание рта болезненное, слизистая вокруг лунки гиперемирована, лунка 4.6 зуба заполнена гнойным экссудатом. Поставьте предварительный диагноз:

***острый гнойный одонтогенный альвеолит**

· острый ограниченный остеомиелит

· неврит нижне- луночкового нерва

· острый гнойный периостит нижней челюсти

· актиномикоз нижней челюсти

364. В клинику обратилась пациентка Х., 28 лет с жалобами на боли и покраснение лица слева. Из анамнеза: получила ожог в солярии, во время процедуры. Объективно: асимметрия лица за счет отека левой половины лица, кожные покровы гиперемированы, отечны, пальпация болезненна. Эпидермис и сосочковый слой дермы разрушены. Не повреждены лишь волосяные фолликулы и потовые железы. Определите степень ожога:

- I
- II
- IIIa
- IIIб
- *IV**

365. В клинику обратился пациент А., 39 лет с жалобами на жгучие боли и побледнение лица справа. Из анамнеза: получил отморожение лица на улице. Объективно: асимметрия лица за счет отека правой половины лица, кожные покровы бледные, при пальпации отсутствует чувствительность. Имеются множественные пузыри, наполненные жидкостью. Определите степень отморожения

- I
- *II**
- IIIa
- IIIб
- IV

366. Больному У., 25 лет показана туберальная анестезия. Проведите профилактику образования гематомы при проведении этой анестезии:

- анестетик выпустить только у целевого пункта
- *скос иглы должен быть направлен к кости, по ходу выпускать анестетик**
- длина иглы должна быть 6-8 см
- при проведении анестезии поршень шприца потянуть на себя
- не применять анестетик без вазоконстриктора

367. Больной А., 40 лет обратился с жалобами на попадание жидкости в полость носа при полоскании полости рта. В анамнезе 1.6 зуб верхней челюсти удален 3 дня тому назад. Объективно: лицо симметричное, открывание рта свободное. Лунка 1.6 зуба заполнена грануляциями, при зондировании имеется сообщение с верхнечелюстным синусом. Поставьте предварительный диагноз:

- хронический верхнечелюстной синусит
- хронический этмоидит
- *перфорация дна гайморовой пазухи**
- острый фронтит
- острый сфеноидит

368. В клинику обратился пациент К., 45 лет с жалобами на боли и припухлость в области верхней челюсти справа, слабость, недомогание, повышение температуры тела до 37,5°C. Из анамнеза: со слов пациента болеет в течение 3 суток, когда появились боли в 1.6 зубе, 1 сутки назад появилась припухлость, состояние ухудшилось. Зуб ранее не лечен. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей верхней челюсти справа. В данной области пальпируется инфильтрат 2,0×2,0 см, кожа над ним гиперемирована. Открывание рта болезненное. Коронка 1.6 зуба разрушена на

2/3, перкуссия болезненна. Переходная складка на уровне 1.5,1.6,1.7 зубов сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена, пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод хирургического лечения:

- острый гнойный перикоронит от 1.6 зуба, удаление зуба

***острый гнойный периостит верхней челюсти, периостотомия, удаление 1.6**

- острый гнойный периодонтит 1.6 зуба, периостотомия, удаление зуба

- флегмона щечной области от 1.6 зуба, дренирование гнойника

- абсцесс скуловой области от 1.6 зуба, дренирование гнойника

369. В клинику обратился пациент З., 39 лет с жалобами на боли и припухлость в области нижней челюсти слева, слабость, повышение температуры тела до 37,3°C. Из анамнеза: со слов пациента болеет в течение 4 суток, когда появились боли в 3.6 зубе, 2 суток назад появилась припухлость, состояние ухудшилось. Зуб ранее лечен. Объективно: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти слева. В данной области пальпируется инфильтрат 2,0×1,5 см, кожа над ним гиперемирована. Открывание рта болезненное. Коронка 3.6 зуба разрушена на 1/2, перкуссия болезненна. Переходная складка на уровне 3.5, 3.6, 3.7 зубов сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена, пальпация болезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод хирургического лечения:

- острый гнойный перикоронит от 3.6 зуба, удаление зуба

- абсцесс подподбородочной области от 3.6 зуба, дренирование гнойника

- острый гнойный периодонтит 3.6 зуба, периостотомия, удаление зуба

- флегмона подчелюстной области от 3.6 зуба, дренирование гнойника

***острый гнойный периостит нижней челюсти, периостотомия, удаление 3.6**

370. В клинику обратился пациент У., 37 лет. Врач поставил диагноз: обострение хронического периодонтита 4.6 зуба. Планируется удаление 4.6 зуба под местной анестезией. Определите инструмент для удаления 4.6 зуба и положение врача:

- клювовидные сходящиеся щипцы, положение врача позади и слева

- универсальные щипцы, положение врача позади и слева от пациента

- клювовидные несходящиеся щипцы, положение врача впереди и справа

***клювовидные несходящиеся щипцы, положение врача позади и справа**

- универсальные щипцы, положение врача впереди и слева от пациента

371. В клинику обратился пациент С., 22 лет с жалобами на деформацию нижней челюсти справа. Болен в течение 6 месяцев, 1 месяц назад получил удар в челюсть и после этого деформация увеличилась. При осмотре: асимметрия лица за счет уплотнения угла и ветви нижней челюсти справа. Пальпация безболезненна. Открывание рта болезненное. Слизистая на переходной складке на уровне 36, 37 зуба бледно- розового цвета, при пальпации определяется симптом «пергаментного хруста». На Р- грамме гомогенные очаги просветления с четкими контурами разделенные между собой костными перегородками. В очаге просветления располагается ретинированный 38 зуб. Морфологическое исследование напоминает структуру эмалевого органа. Поставьте клинический диагноз:

- фиброма

- одонтома

- миксома

- хондрома

***амелобластома**

372. У больного, находящегося на стационарном лечении имеется плотный, болезненный инфильтрат в области верхней губы слева, в центре имеется гнойный стержень, покрытый корочкой. Кожа над инфильтратом гиперемирована. Пальпаторно определяется тяж по ходу вен лица. Поставьте диагноз

- Абсцедирующий фурункул верхней губы
- *Абсцедирующий фурункул верхней губы, флебит вен лица**
- Абсцедирующий карбункул, флебит вен лица
- Карбункул в стадии инфильтрации
- Нагноившаяся одонтогенная подкожная гранулема

373. После проведения анестезии у больного появилась припухлость в области щеки. Стоматолог-хирург удалил верхний зуб «мудрости», рекомендовал холод. Через три дня появились боли в области верхней челюсти, иррадирующие в ухо и висок, повысилась температура тела. При осмотре - симптом песочных часов. Открывание рта ограничено, контрактура III-степени. В области переходной складки верхних коренных зубов определяется резкая болезненность. Лунка верхнего зуба «мудрости», заполнена кровяным сгустком. Поставьте предварительный диагноз

- Постинъекционная гематома височной и подвисочной области
- Постинъекционная гематома щечной и височной области
- *Нагноившиеся постинъекционная гематома подвисочной и крылонебной ямки**
- Постинъекционная гематома подвисочной и щечной ямки
- Постинъекционная гематома крылонебной и височной ямки

374. Больной с жалобами на наличие свищевого хода в области тела нижней челюсти. Из свищевого хода грануляции с гнойным отделяемым. Тело нижней челюсти утолщено. Месяц назад находился на стационарном лечении с диагнозом - острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти. На рентгенограмме-новообразование костной ткани в центре, которого очаг резорбции костной ткани с четкими границами, расположенный к основанию нижней челюсти. Выберите метод лечения:

- Кюретаж
- *Секвестрэктомия**
- Антибиотикотерапия
- Иммуномодуляторы
- Биогенные стимуляторы

375. Больной с жалобами на боль в области верхней челюсти, иррадирующую в глазное яблоко; заложенность и выделение из носового хода; чувство тяжести, головные боли, повышение температуры тела до 40С, понижение обоняния, слабость и недомогание. В анамнезе – 2 дня назад появились головные боли, припухлость щечной области, заложенность носа. Ткани щечной и подглазничной области отечные. Кожа без изменений. Слизистая преддверия полости рта в области больших коренных зубов гиперемирована, отечна. Пальпация в области собачьей ямки болезненна. 2.6 зуб разрушен на 1/3, перкуссия 2.5, 2.6, 2.7 зубов болезненна. Выберите тактику лечения:

- *Удаление 2.6 зуба и гайморотомия**
- Лечение 2.6 зуба и пункция гайморовой пазухи
- Пункция гайморовой пазухи
- Радикальная гайморопластика

- Вскрытие гнойника наружным доступом и удаление 2.6 зуба

376. Больная обратилась в стоматологическую поликлинику с жалобами на усиливающие боли в области лунки удаленного правого верхнего 2 моляра. Зуб был удален за 3 дня до обращения. Местно при осмотре: лунка правого верхнего 2 моляра заполнена кровяным сгустком, признаков воспаления нет, при пальпации врач определил острый край альвеолы с вес-тибулярной стороны. Какой предварительный диагноз возможно выставить

- альвеолит лунки

***неврит лунки 2.7 зуба**

- 2.7 причинный зуб периостит
- 2.7 причинный зуб остеомиелит
- невралгия второй ветви тройничного нерва

377. Больная В. 45 лет, обратилась в клинику с диагнозом – фиброма щёчной области справа. Назначьте лечение.

***Иссечение в пределах здоровых тканей**

- Склерозирующая терапия
- Физиотерапия
- Медикаментозное
- Прижигание снегом угольной кислоты

378. Больному А., 25 лет. Жалобы: на боли в области верхней челюсти слева. Объективно: лицо ассиметричное, за счет отека мягких тканей верхней челюсти слева. Открывание рта болезненное. Коронка 26 зуба разрушена на 1/2, переходная складка сглажена, гиперемирована, отечна. Пальпация болезненна. Выберите метод хирургического лечения:

***Удаление 26 зуба, остеоперфорация**

- Остеоперфорация, лечение 26 зуба
- Периостотомия, резекция корня
- Удаление 26 зуба, периостотомия
- Лечение 26 зуба, периостотомия

379. У больного А., 37 лет. Диагноз: Перфорация дна верхнечелюстного синуса. Выберите положение основания нёбного лоскута формируемого для пластики ороантрального сообщения:

- В сторону нёбного шва
- В сторону фронтальных зубов

***В сторону мягкого нёба**

- В сторону ороантрального сообщения
- В сторону переходной складки

380. В клинику доставлен пациент 18 лет в крайне тяжелом состоянии из отдаленного села. Выяснить анамнез не удалось. При осмотре: отек и гиперемия верхнего и нижнего век справа. Экзофтальм, хемоз, боль при надавливании на глазное яблоко. На рентгенограмме определяется затемнение в верхнечелюстном синусе. Какой метод оперативного доступа целесообразен?

- Разрез по верхнему краю орбиты
- Разрез по нижнему краю орбиты
- Разрез по нижне-наружному углу орбиты

***Гайморотомия с трепанацией верхней стенки пазухи**

- Разрез по верхне-наружному углу орбиты с контрапертурой

381. При удалении камня из вартонова протока врач провел язычную анестезию. Прошил лигатурой проток через прилежащие ткани позади локализации камня. Сделал разрез слизистой над протоком, удалил камень и ушил послойно проток и слизистую. В чем заключалась ошибка врача ?

- Выбор анестезии
- Неправильно сделал разрез
- Нельзя дренировать рану
- *Нельзя ушивать рану
- Нельзя оперировать проток

382. Пациент 22г. обратился в клинику через 1,5 месяца после травмы, с жалобами на нарушение ограничение открывания рта, деформация лица. При осмотре: кожные покровы лица обычной окраски. Деформация лица за счет уплощения скуловой области слева, симптом "ступеньки" по нижнему краю глазницы, онемение кожи подглазничной области и крыла носа слева. Какой из перечисленных методов лечения целесообразен?

- Контурная пластика скуловой области
- Устранение деформации методом имплантации
- Устранение деформации методом аутоотрансплатации
- *Рефрактура скуловой кости и репозиция ее в правильное положение
- Репозиция скуловой кости крючком Лимберга в правильное положение

383. Больной А., 39 лет обратился к челюстно-лицевому хирургу с жалобами на резкую боль, незначительную припухлость в области нижней челюсти справа, боль и ограничение открывании рта, невозможность приема пищи. Из анамнеза: травму получил за 2 часа до обращения в приемный покой, избит неизвестными. На рентгенологическом исследовании нижней челюсти в прямой и правой боковой проекциях линия перелома, проходит по 36 зубу, без смещения отломков, в виде полосы просветления. Определите тактику врача.

- остеосинтез спицей Киршнера
- остеосинтез костным швом
- *репозиция и фиксация шинами с зацепными петлями
- шинирование гладкой шиной скобой
- лигатурное связывание по Айви

384. Больной, 23 лет, поступил в приёмный покой челюстно-лицевой больницы с диагнозом: двусторонний перелом нижней челюсти со смещением костных отломков: между 4.4 и 4.5 зубами и по 3.8 зубу. Прикус нарушен. Каков план лечения?

- остеосинтез костным швом суставного отростка слева
- двучелюстное шинирование с наложением прокладки
- *репозиция и иммобилизация костных отломков шинами Тигерштедта
- остеосинтез костным швом в ментальном отделе
- остеосинтез по методу Донского-Кручинского

385. Молодой мужчина во время соревнований получил травму. При осмотре – верхний центральный резец в лунке, подвижный, болезненный при дотрагивании. Слизистая оболочка в области зуба гиперемированна. Определите тактику врача:

***репозиция + фиксация**

- удаление зуба
- фиксация зубов+ физиотерапия
- репозиция зуба
- фиксация

386. У больного выставлен диагноз: одонтогенная флегмона подчелюстной области. Хирург провел экстренное оперативное вмешательство. Выберите наиболее рациональный доступ разреза очага?

- подбородочная область
- окаймляющий угол нижней челюсти
- слизистой по крылочелюстной складке
- от угла нижней челюсти до угла, дугообразной формы и параллельно краю нижней челюсти

***в подчелюстной области отступя на 1,5 см края нижней челюсти и вдоль нее**

387. К лоскутным операциям на пародонте относятся следующие методы:

- Кюретаж
- Гингивотомия
- Операция по Мюллеру
- Операция по Кларку

***Операция по Киселеву**

388. У больного выставлен диагноз: фурункул верхней губы. Местно отмечается уплотнение тканей у внутреннего угла глаза в виде синюшного тяжа. Какое возникло осложнение

- повреждение лицевой вены

***флебит угловой вены лица**

- медиастенит
- перфорация верхнечелюстного синуса
- абсцесс крылонебной ямки

389. У больного А., выставлен диагноз одонтогенная флегмона подподбородочной области. Хирург назначил хирургический метод лечения – вскрытие «гнойника», вскрытие считается правильным, если сделать разрез в области

- флюктуации
- корня языка
- границы гиперемии кожи
- наибольшей болезненности

***на всю ширину инфильтрата**

390. Повышение физико-механической характеристики коронки естественного зуба за счет циркулярного охвата зубной культи единой конструкцией, возможность воспроизвести морфологию зуба, возможность выполнить функцию опорного элемента несъемного или съемного протеза, является достоинством:

***искусственной коронки**

- виниров
- вкладки
- штифтовых зубов

- импланта

391. В клинику обратился пациент А., 25 лет с жалобами на отсутствие зубов. При осмотре: на верхней челюсти отсутствуют жевательные зубы с обеих сторон. Поставьте предварительный диагноз, согласно классификации Кеннеди:

- дефект зубного ряда по II классу
- дефект зубного ряда по III классу
- дефект зубного ряда по IV классу
- дефект зубного ряда по I подклассу II класса
- *дефект зубного ряда по I классу**

392. Краевой замыкающий клапан является основным условием хорошей фиксации протеза на беззубой челюсти. Для его образования необходимо получить оттиск тканей протезного ложа и его границ во время функции. Определите вид оттиска:

- *функциональный**
- анатомический
- физиологический
- патологический
- компрессионный

393. Врач проводит припасовку индивидуальной ложки пациенту с беззубой верхней челюстью. Затем предлагает пациенту широко открыть рот, втянуть щеки, вытянуть губы для уточнения границ ложки при припасовке. Определите вид пробы, проводимой врачом:

- проба Гаврилова
- *проба Гербста**
- проба Рубинова
- проба Оксмана
- проба Бетельмана

394. Врач стоматолог-ортопед проводит проверку окклюзионных контактов, на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза, при следующих видах окклюзий:

- боковой
- центральной и сагиттальной
- сагиттальной и боковой
- *боковой, передней и центральной**
- центральной и боковой

395. читывая, что согласно одонтопародонтограмме Курляндского В.Ю. изготовление несъемных шин-протезов показано при резорбции костной ткани альвеолярного отростка менее ¼ длины корня, выберите рациональную ортопедическую конструкцию у пациента 28 лет, с отсутствием 4.4 зуба и подвижностью 1 степени 4.5 зуба:

- бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами на 4.3, 4.5 и 4.6
- частичный съемный протез с удерживающими кламмерами на 4.4 и 4.5
- консольный мостовидный протез с опорой на 4.4
- *мостовидный протез с опорой на 4.3, 4.5 и 4.6**
- мостовидный протез с опорой на 4.3, 4.5

396. Согласно статическим жевательным коэффициентам Оксмана И.М. при отсутствии, каких зубов в боковом отделе возможно изготовление металлокерамического мостовидного протеза, без риска перегрузки опорных зубов:

***4.5**

- 4.5 и 4.6
- 4.6 и 4.7
- 4.4; 4.5 и 4.6
- 4.5; 4.6 и 4.7

397. Высота препарирования окклюзионной поверхности под несъемную конструкцию не должна превышать 1/3 высоты коронковой части зуба, в связи с ее опасностью :

- перегрузки пародонта
- повышенного износа
- вторичного кариеса

***плохой фиксации**

- расцементировке

398. Создание шероховатой поверхности эмали мелкозернистыми алмазными борами и удаление ее поверхностного резистентного слоя проводят с целью:

- исключения рецидива пародонтита
- устранения воспаления в периодонте

***шинирования армирующим композитом**

- восстановления разрушенных периодонтальных тканей
- установления оптимальных окклюзионных соотношений

399. Пациенту 28 лет был поставлен диагноз: Ложный сустав тела нижней челюсти. Месяц назад было проведено лечение с наложением шины Тигерштедта на 1,5 недели. Из анамнеза: пациент страдает инсулин-зависимым сахарным диабетом. Назовите причины образования ложного сустава:

- долгий срок иммобилизации

***маленький срок иммобилизации**

- влияние соматического заболевания
- неправильное сопоставление отломков
- неадекватный выбор шинирующей конструкции в данном клиническом случае.

400. Пациент 30 лет, рабочий химической фабрики, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на повышенную чувствительность к холодному, сладкому, горячему, эстетический дефект передних зубов. При осмотре полости рта выявлено уменьшение высоты коронок нижних фронтальных зубов на 1/3, выраженный альвеолярный отросток, фасетки стирания в пределах дентина с гладкими поверхностями. На верхних фронтальных зубах – коронки из безметалловой керамики, отвечающие клиническим требованиям. Поставьте диагноз, определите план лечения, исходя из результатов предыдущего протезирования:

- кариес зубов; прямые реставрации
- гиперестезия; реминерализующая терапия
- кислотный некроз; протезирование встречными вкладками
- повышенная декомпенсированная стираемость; цельнолитые коронки

***повышенная компенсированная стираемость; коронки из безметалловой керамики**

401. Какие положительные стороны и преимущества имеют вкладки по сравнению с искусственными коронками на современном этапе:

- Эстетические;
- Лучшее краевое прилегание;
- *Минимальное одонтопрепарирование поврежденных зубов;**
- Прочнее, хорошо восстанавливают межзубный контактный пункт;
- Отсутствие аллергических реакций;

402. У пациента 67 лет полная отсутствие зубов на верхней челюсти. Равномерная атрофия альвеолярного отростка средней степени, маловыраженные бугры, средняя глубина неба, выраженный торус. Поставить клинический диагноз?

- полная адентия, I- тип по Оксману
- *полная адентия, II- тип по Оксману**
- полная адентия, II- тип по Суппле
- полная адентия, III- тип по Оксману
- полная адентия, III- тип по Суппле

403. На клиническом приеме во время припасовке и введения в полость рта восковой конструкции частичных съемных пластиночных протезов на верхней и нижней челюсти нижняя треть лица удлинена, губы смыкаются с трудом, складки лица сглажены, при разговоре имеется щель между фронтальными зубами, слышен стук зубов. В боковых отделах антагонизирующие зубы смыкаются равномерно и плотно. Какая врачебная ошибка была допущена и методы устранения?

- высота прикуса завышена- пришлифовывать окклюзионный поверхность боковых зубов
- неправильная постановка фронтальных зубов- разогреть воск и глубже установить фронтальные зубы
- *высота прикуса завышена- заново определить центральную окклюзию**
- высота прикуса занижена- зависить прикус разогретой пластинкой воска
- высота прикуса завышена- пришлифовывать окклюзионный поверхность фронтальных зубов

404. Требуется ли снятие временной шинирующей конструкции Ribbond пациенту, получившему комплексное лечение по поводу локализованного пародонтита фронтальных зубов нижней челюсти с подвижностью I степени. Выберите тактику дальнейшего лечения:

- нет; провести коррекцию имеющейся временной конструкции
- да; реставрировать зубы после временного шинирования
- *да; постоянная интердентальная шина Копейкина**
- нет; полировка поверхности фронтальных зубов
- да; шина Мамлока с пульпарными штифтами

405. На определении центрального соотношения челюстей в полном съемном протезировании высота окклюзионного валика верхней челюсти при полуоткрытом рте не выведена на 1 – 2 мм ниже из-под верхней губы и не отмечена линия «улыбки». Какая ошибка обнаружится на четвертом клиническом этапе; тактика врача:

- ошибки нет, ничего не исправлять
- *короткие фронтальные искусственные зубы; заново определить центральное соотношение**
- длинные фронтальные искусственные зубы; определить протетическую плоскость по зрачковой линии

- короткие боковые искусственные зубы; определить протетическую плоскость по носо - ушной линии
- длинные фронтальные искусственные зубы; сформировать вестибулярный овал на верхнем окклюзионном валике

406. При припасовки узкого колпачка металлокерамической коронки (из кобальто-хромового сплава), при правильно отпрепарированном зубе, необходимо:

***переснять оттиск, отлить колпачок по модели, покрытой двумя слоями лака**

- допрепарирование зуба, снятие оттиска, заново отлить колпачок
- переснять оттиск, края колпачка подрезать абразивным инструментом
- крампонными щипцами собрать края колпачка полировка края колпачка
- края колпачка подрезать абразивным инструментом шлифовка, полировка

407. Какое осложнение возникнет, если опорная металлическая вкладка мостовидного протеза завышает высоту прикуса:

- ее отлом

***перегрузка опорных зубов**

- развитие вторичного кариеса
- распределение жевательного давления на тело протеза
- распределение жевательного давления на опорные зубы

408. У пациента 30 лет, отсутствует 3.3 зуб. Соседние с дефектом зубы относятся к двум разным функциональным группам. Какую ортопедическую конструкцию предпочтительнее изготовить:

- пластмассовый мостовидный протез с опорой на 3.2 и 3.4 зубы
- штампованный мостовидный протез с опорой на 3.2 и 3.4 зубы
- металлокерамический консольный протез с опорой на 3.4 зуб
- консольный металлический протез с опорой на 3.4 зуб

***протезирование на имплантате в области 3.3 зуба**

409. Беспрепятственное наложение пластиночного протеза на этапе его припасовки может быть затруднено, вследствие:

- занижения высоты нижнего отдела лица
- завышения высоты нижнего отдела лица
- ошибки при постановке искусственных зубов
- дефектов базиса при недопаковке пластмассы

***расположения базисной пластмассы в области поднутрения**

410. Причинами непригодности каркаса бюгельного протеза является:

- ощущение во рту инородного тела при припасовке и наложении каркаса
- большая протяженность каркаса и сложность его конструкции

***отсутствие зазора между дугой и слизистой оболочкой**

- применение кламмеров разных типов
- появление повышенной саливации

411. Пациент обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на боли под протезом. Объективно: наклон опорного зуба в дистальном направлении, внедрение промежуточного тела в слизистую с образованием декубитальной язвы. На рентгенограмме

расширение периодонтальной щели опорного зуба в пришеечной трети и половины длины стенки лунки. Исходя из перечисленных данных, какой протез был изготовлен данному пациенту:

- Балочный
- бюгельный
- * консольный**
- мостовидный
- частичный съемный

412. Какое осложнение в дальнейшем может сделать сам пациент в период адаптации к бюгельному протезу, если плечо опорно-удерживающего кламмера располагается возле шейки зуба:

- функциональная перегрузка опорного зуба в момент снятия кламмера
- * механическая травма маргинальной десны в момент снятия кламмера**
- травма тканей периодонта в момент соприкосновения протеза с зубом
- механическая травма маргинальной десны в момент соприкосновения протеза с зубом
- функциональная перегрузка опорного зуба в момент соприкосновения протеза с зубом

413. После препарирования зубов под литые опорные коронки, в случае нефиксированного прикуса, после снятия двухслойного рабочего и однослойного вспомогательного, необходимо еще:

- снять оттиск в прикусе в положении центральной окклюзии
- * зафиксировать центральную окклюзию с помощью восковых шаблонов**
- фиксировать центральную окклюзию с помощью восковых шаблонов необязательно
- отлить модели по рабочему и вспомогательному оттиску и сопоставить их у кресла при пациенте
- отлить модели по рабочему и вспомогательному оттиску и сопоставить их в зуботехнической лаборатории

414. Во время припасовки колпачка врач обнаружил щель между колпачком и десной. Толщина колпачка 0,4 мм, на внутренней поверхности наплывов металла нет. Колпачок плотно соприкасается со всеми поверхностями зуба. Тактика врача:

- удлинить край колпачка с помощью молоточка
- закрыть эту щель с помощью керамической массы
- * переснять оттиск и повторно изготовить колпачок**
- провести коррекцию внутренней поверхности колпачка
- допрепарировать культю зуба для более глубокой припасовки

415. В клинику обратился пациент Д., 23 лет с жалобами на неправильное положение зубов, боли при жевании в правом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). При осмотре: асимметрия лица за счет увеличения околоушно-жевательной мышцы справа. Средняя линия зубной дуги нижней челюсти смещено вправо на 2,5 мм. Отсутствует 4.6 зуб, вестибулярно расположены 1.2, 2.2, 3.3, 4.3 зубы. Поставьте предварительный диагноз и определите метод функциональной диагностики:

- * вестибулярное положение резцов и клыков, функциография**
- язычное положение резцов и клыков, миография
- перекрестный прикус, функциональная проба
- открытый прикус, гнатометрия
- прямой прикус, метод Изарда

416. В клинику обратился пациент К., 25 лет с жалобами на неправильное положение зубов, боли при жевании в правом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). При осмотре: асимметрия лица за счет увеличения околоушно-жевательной мышцы справа. Средняя линия зубной дуги нижней челюсти смещено вправо на 1,5 мм. Отсутствует 4.6 зуб, вестибулярно расположены 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубы. Интенсивность дисфункции по индексу М. Helkimo - средняя. По результатам функциографии установлено ограничение амплитуды движений нижней челюсти. Поставьте предварительный диагноз и определите метод лучевой диагностики:

- язычное положение резцов и клыков, рентгенография нижней челюсти
- *вестибулярное положение резцов и клыков, компьютерная томография**
- перекрестный прикус, магнитно-резонансная томография
- открытый прикус, ультразвуковое исследование
- прямой прикус, телерентгенография

417. В клинику обратился пациент С., 26 лет с жалобами на неправильное положение зубов, боли при жевании в правом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). При осмотре: средняя линия зубной дуги нижней челюсти смещено вправо на 2,5 мм. Отсутствует 4.6 зуб, вестибулярно расположены 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубы. На компьютерной томографии - мезиальное смещение головки нижней челюсти в левом височно-нижнечелюстном суставе. Поставьте клинический диагноз и определите технику лечения:

- язычное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, рубцовый анкилоз ВНЧС
- глубокий прикус, костный анкилоз ВНЧС
- перекрестный прикус, артроз ВНЧС
- *вестибулярное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, дисфункция ВНЧС**
- прямой прикус, ретрогения

418. В клинику обратилась пациентка А., 13 лет с жалобами на нарушение эстетики лица, некрасивые зубы. Объективно: лицо симметричное. Открывание рта свободное. Резцы верхней челюсти перекрывают резцы нижней челюсти на 8 мм, сагитальная щель между резцами 11мм, дистоокклюзия в боковых участках зубных рядов. Тремы между передними зубами верхней челюсти. Имеется некариозное поражение эмали на вестибулярной поверхности передних зубов верхней челюсти. Поставьте предварительный диагноз:

- язычное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, кариес цемента
- мезиоокклюзия, острый гнойный пульпит
- перекрестный прикус, острый гнойный периодонтит
- открытый прикус, кариес дентина
- *глубокое резцовое перекрытие, гипоплазия эмали**

419. В клинику обратился пациент К., 25 лет с жалобами на неправильное положение зубов, боли при жевании в правом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). При осмотре: асимметрия лица за счет увеличения околоушно-жевательной мышцы справа. Средняя линия зубной дуги нижней челюсти смещено вправо на 1,5 мм. Отсутствует 4.6 зуб, вестибулярно расположены 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубы. Анализ записи показал, что причинами изменений были аномалии смыкания зубных рядов, нарушения ВНЧС и функции жевательных мышц. На компьютерной томографии - мезиальное смещение головки нижней челюсти в левом височно-нижнечелюстном суставе. Определите технику ортодонтического лечения:

- несъемная вестибулярная техника
- съемные ретейнеры

***несъемная ортодонтическая техника «прямая дуга»**

- аппараты трансфорсы W. Clark
- аппараты Spring jet

420. В клинику обратился ребенок И., 8 лет с жалобами на нарушение жевания. Из анамнеза: состояние после хейло-урано-стафиллопластики. При осмотре: осанка нарушена – имеется искривление позвоночника. Асимметрия лица за счет недоразвития верхней челюсти. Открывание рта свободное, отсутствует верхний боковой резец слева. Имеется межзубное положение кончика языка. На рентгенограмме кисти руки установлена запоздавшая оссификация скелета на 2 года. Поставьте диагноз и определите технику ортодонтического лечения:

***мезиоокклюзия, регулятор функций Френкеля III типа**

- дистоокклюзия, съемные ретейнеры
- открытый прикус, несъемная ортодонтическая техника «прямая дуга»
- перекрестный прикус, аппараты трансфорсы W. Clark
- глубокий прикус, аппараты Spring jet

421. В клинику обратился ребенок К., 7 лет. Врач поставил диагноз: Дистальная окклюзия. Маму интересовал вопрос длительности лечения. Длительность лечения дистоокклюзии гнатической разновидности в периодах активного роста челюстей, при круглосуточном пользовании регулятором функций Френкеля, за исключением времени приема пищи, составляет:

- 1 - 1,5 года
- *2 - 2,5 года**
- 3 - 3,5 лет
- 4 - 4,5 лет
- 5 - 5,5 лет

422. При морфологических изменениях в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС) исправление аномалий прикуса и нормализация артикуляции зубных рядов способствует устранению перегрузки суставов и оптимизации их функций, потому что основой патогенеза, являются:

- микротравма структур ВНЧС, спазм жевательных мышц
- нарушение положения нижней челюсти, изменение тонуса мышц
- нарушение движения нижней челюсти, спазм жевательных мышц
- воспалительные и дегенеративные изменения в структуре ВНЧС

***окклюзионные нарушения, мышечно-суставная дисфункция**

423. Для ускорения ортодонтического лечения выраженных зубочелюстных аномалий и деформаций, а также получения более эффективных и устойчивых результатов, показано предварительное хирургическое вмешательство:

- остеосинтез
- *компактостеотомия**
- остеоперфорация
- периостотомия
- артропластика

424. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при нормальной окклюзии и резко выраженном тесном положении передних зубов на $6,7 \pm 0,84$ мм, при

дистоокклюзии на $6,4 \pm 0,93$ мм, при мезиоокклюзии на $6,3\text{мм} \pm 0,91$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- лечения отдельных зубов
- лечения боковых резцов
- удаления клыков
- *удаления отдельных зубов**
- удаления моляров

425. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при нормальной окклюзии и резко выраженном тесном положении передних зубов на $6,7 \pm 0,84$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- *лечения отдельных зубов**
- лечения боковых резцов
- удаления клыков
- удаления отдельных зубов
- удаления моляров

426. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при дистоокклюзии на $6,4 \pm 0,93$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- лечения отдельных зубов
- лечения боковых резцов
- удаления моляров
- удаления клыков
- *удаления отдельных зубов**

427. Укорочение трех сегментов верхней челюсти (переднего, среднего, заднего) при мезиоокклюзии на $6,3\text{мм} \pm 0,91$ мм является одним из показаний к лечению аномального прикуса путем:

- *удаления отдельных зубов**
- лечения боковых резцов
- удаления клыков
- лечения отдельных зубов
- удаления моляров

428. Укорочение трех сегментов (переднего, среднего, заднего) до $6,7 \pm 0,84$ мм. верхней челюсти, расположение зачатков клыков впереди резцового канала и уменьшение ретромолярного пространства на нижней челюсти являются показаниями к нормализации прикуса путем удаления на соответствующей челюсти:

- вторых временных моляров и зачатков первых моляров
- *первых временных моляров и зачатков первых премоляров**
- временных клыков и зачатков вторых моляров
- временных центральных резцов и зачатков первых моляров
- временных боковых резцов и зачатков третьих моляров

429. В мезиальном прикусе гнатической разновидности у девочек в возрасте 11 лет и у мальчиков 13 лет, с целью задержки развития нижнего зубного ряда при адентии аналогичных верхних зубов, целесообразно удаление:

- зачатков первых моляров в младшем школьном возрасте
- зачатков первых премоляров в старшем школьном возрасте
- *зачатков нижних третьих моляров в препубертатном периоде**
- зачатков вторых премоляров в среднем школьном возрасте
- зачатков вторых моляров в дошкольном возрасте

430. В клинику обратился ребенок А., 14 лет. Диагноз: состояние после хейло-урано-стафиллопластики, мезиальный прикус. В мезиальном прикусе, обусловленном сквозным несращением верхней губы, альвеолярного отростка и неба слева, целесообразно удаление:

- *зачатков третьих моляров в препубертатном периоде**
- зачатков первых премоляров в старшем школьном возрасте
- зачатков первых моляров в младшем школьном возрасте
- зачатков вторых премоляров в среднем школьном возрасте
- зачатков вторых моляров в дошкольном возрасте

431. Хронические воспалительные процессы вокруг дистального корня второго временного моляра, могут быть причиной изменения угла наклона продольной оси:

- второго моляра до его прорезывания
- третьего моляра до его прорезывания
- *первого моляра до его прорезывания**
- второго премоляра до его прорезывания
- первого премоляра до его прорезывания

432. Корпусное и наклонное смещение зубов, укорочение зубного ряда, смещение постоянного первого моляра мезиально в более узкую часть зубной дуги развиваются, в результате удаления больше чем за 1 год до периода их физиологической смены:

- временного клыка
- временного бокового резца
- временного центрального резца
- временных премоляров
- *временных моляров**

433. Цефалометрический анализ, показывающий рост ребенка, определение сроков прорезывания зубов, их соответствие норме, а также наличие всех постоянных зубов на рентгенограмме, правильность порядка их прорезывания являются основой для планирования:

- *времени удаления зубов**
- времени проведения остеотомии
- времени проведения френулопластики
- времени проведения гингивотомии
- времени проведения альвеолотомии

434. Несоответствие длины альвеолярной дуги нижней челюсти, более чем на 4 мм, при прорезывании боковых резцов и смещении средней линии на эту сторону является показанием для удаления:

- временных резцов
- временных моляров
- *временных клыков**
- постоянных резцов
- постоянных моляров

435. Пациент 20 лет. Обратилась в стоматологическую клинику с жалобами на нарушение эстетику лица, на неправильное расположения верхних передних зубов. Оценка внешнего осмотра: лицо симметричное, вертикальные размеры лица изменены – средняя треть лица удлинена, выступает вперед, состояние носогубных складок – сглажены, супраментальная борозда слабо выражена, нижнечелюстной угол не выражен, тупой. Оценка осмотра полости рта: глубина преддверия полости рта в пределах 5-6 мм,слизистая оболочка во фронтальном отделе в цвете изменена, оголение шеек в области нижних резцов. Соотношение моляров по 2 классу Энгля с сагиттальной щелью во фронтальном отделе зубных рядов. Наиболее вероятная причина в образовании сагиттальной щели:

***протрузия верхних и ретрузия нижних резцов**

- тортоаномалия боковых резцов
- транспозиция 2.4 и 3.4
- адентия 1.8 и 2.8
- ретенция клыка

436. Пациент 20 лет. Обратилась в стоматологическую клинику с жалобами на нарушение эстетики лица. При внешнем осмотре: лицо симметричное, изменены вертикальные размеры лица. При антропометрическом измерении лица была проведена измерения от точки, расположенной на границе со лбом и волосистой частью головы и точкой гнатион по сагиттальной плоскости. Укажите в данном случае была произведена измерения:

***физиономическую высоту лица**

- физиологическую высоту лица
- верхнюю морфологическую высоту лица
- нижнюю морфологическую высоту лица
- полную морфологическую высоту лица

437. У ортодонтического пациента с значительным сужением верхней и нижней зубных дуг проведены методы Шмудта, Фусса и Шварца на контрольно-диагностических моделях челюстей. Для чего применяются данные методы биометрии:

- Для определения формы зубных рядов
- *для определения симметричности зубных рядов**
- для определения глубины небного свода
- для определения формы и размера языка
- для определения симметричности небной дужки

438. Пациент 22 лет. На этапе ортодонтического лечения у врача-ортодонта. При биометрическом исследовании моделей челюстей у пациента оказалась укорочение апикальных базисов челюстей II степени – ширина 12 зубов 39-32%, длина-37-26%, на нижней челюсти соответственно- 38-34% и 36-31%. Ваш план лечения в данной ситуации:

***Сошлифовывания бугров молочных моляров**

- Обнажения коронок ретенированных зубов

- удаления отдельных зубов
- Сошлифовывания апроксимальных поверхностей зубов
- Проведение компактоosteотомии

439. К врачу-ортодонту обратилась пациентка 19 лет с жалобой на неправильное расположения зубов на верхней челюсти. Пациентка направлена на ортопантомографию челюстей . При анализе ортопантомографического снимка обнаружен дистопированный клык справа. Скажите при рентгенологической оценке положения дистопированного клыка кроме определения местоположения его по отношению к рядом стоящим зубам и зубной дуге должны учитываться что :

***Наличия резорбции корней центрального или бокового резцов**

- Наличие перестройки костной ткани
- Наличие очага около верхушечной области
- Наличие расширение периодонтальной щели
- Наличие некроза костной ткани

440. Мальчик 7 лет. При профилактическом осмотре определяется изменение лицевых параметров, при физиологическом покое нижняя челюсть находится впереди верхней челюсти, нижнечелюстной угол выражен, вывернут кзади, из-за снижение нижней трети лица носогубные и подбородочная складки углублены, верхняя губа западает, губы смыкаются свободно без напряжения, углы рта не опущены. После диагностических исследований ребенка врачом-ортодонтом поставлен диагноз – мезиальная окклюзия зубных рядов, гнатическая форма. Для задержки роста нижней челюсти в сагиттальном направлении и для уменьшения величины нижнечелюстных углов выберите аппарат;

- лицевая маска
- протезирования ортопедическими коронками

***працевидная повязка с головной шапочкой**

- шинирование зубов
- применение миниимплантов

441. Пациентка А. 20 лет обратилась в клинику с жалобами на выступание верхних фронтальных зубов вперед. Оценка лицевых параметров и внешнего осмотра: Асимметрия лица не отмечена, корень носа выражен, спинка прямая, крылья носа не функционируют, западают, апатичные. Высота нижнего отдела лица в покое 73 мм, в положении центральной окклюзии – 68 мм, губы смыкаются с трудом, ротовая щель постоянно зияет, углы рта не опущены. Оценка окклюзии зубных рядов: мезио-дистальное соотношение моляров-: мезиально-щечные бугры верхних первых моляров с двух сторон лежат в межбугровых фиссурах нижних первых моляров, увеличение сагиттального резцового перекрытия, размер сагиттальной щели в пределах 10 мм, верхние центральные резцы веерообразно выступают вперед, оттягивая верхнюю губу, промежутки между фронтальными зубами – 2-3 мм, зубной ряд нижней челюсти правильной формы и величины. Формы и размеры верхнего зубного ряда изменены, режущие края фронтальных зубов верхней челюсти сместились вестибулярно на 6 мм. Поставьте предварительный диагноз:

***сагиттальная резцовая дизокклюзия, протрузия верхних резцов**

- Трансверсальная резцовая дизокклюзия, протрузия верхних резцов
- Вертикальная резцовая дизокклюзия, ретрузия верхних резцов
- Глубокая резцовая окклюзия

- Глубокая резцовая дизокклюзия, протрузия нижних резцов

442. Девочка 5 лет. Родители ребенка обратились к врачу ортодонту с жалобами на вредную привычку – сосание большого пальца, на щепелявость речи. В анамнезе: аденоиды, ринит. При внешнем осмотре ребенка- лицо симметричное, вертикальные размеры лица изменены- нижняя треть удлинена. Нижнечелюстной угол слабо выражен. Рот полуоткрыт, губы смыкаются с напряжением, тонус губ слабый. Объективно: преддверия полости рта в пределах нормы, размер и прикрепления уздечек в норме. Форма зубных дуг правильной формы, зубной ряд интактный, соответствует к возрасту, имеются кариозные полости 5.5 и 8.4. Во фронтальном отделе зубных рядов имеется вертикальная щель, размером 3 мм. Выберите метод лечения с учетом возраста ребенка:

- аппаратный метод
- Ортопедический метод
- Реконструктивные операции

***Лечебная гимнастика**

- хирургическая коррекция

443. 10 летний ребенок находится на диспансерном учете у врача-ортодонта с диагнозом «Трансверзальная окклюзия зубных рядов». В полости рта носит функциональный съемный аппарат в течение 6 месяцев. Назовите элемент функциональных съемных аппаратов, покрывающий жевательные поверхности боковых зубов и не имеющая отпечатков зубов антагонистов?

***окклюзионная накладка**

- накусочная площадка
- наклонная плоскость
- дентоальвеолярные кламмера
- кламмера Адамса

444. Пациент 21 лет. Находиться на этапе ортодонтического лечения с помощью эджуайз-техники. Укажите активно действующий элемент несъемной ортодонтической конструкции у пациентов в постоянном прикусе для перемещения зубов в трех направлениях:

***проволочная ортодонтическая дуга**

- Замки-трубки
- небный бюгель
- ортодонтическая пружина
- ортодонтическое кольцо

445. Девочка 7 лет находится на этапе ортодонтического лечения у врача-ортодонта. В полости рта во фронтальном отделе зубных рядов обратно резцовое перекрытие, в боковых отделах зубных дуг по 1 классу Энгля. Пациентка носит съемный аппарат на нижнюю челюсть с наклонной плоскостью, вестибулярной дугой и опорными кламмерами. Назовите вид комбинированного ортодонтического аппарата, для перемещения верхних передних зубов в вестибулярном направлении :

- аппарат Шонхера
- аппарат Катца

***аппарат Брюкля**

- аппарат Крауза

- аппарат Кербита

446. У 10 летнего ребенка 1 класс резцового соотношения, особенности строения лица характерны для невыраженного 3 класса, незначительно увеличенные вертикальные размеры, удовлетворительная эстетика лица и улыбки. Признаков заболевания ВНЧС и другой патологии нет. Состояние мягких тканей: функция губ несколько ослаблена, нижняя губа в состоянии покоя находится впереди верхних резцов, тонус губ средний. Оценка осмотра полости рта: глубина преддверия полости рта в пределах 5-6 мм, состояние уздечек губ – уздечка верхней губы прикреплена в середину альвеолярного отростка, размер уздечки нижней губы – короткая, имеется оголение шеек в области нижних резцов, форма верхнего зубного ряда изменена – трапецевидной формы, аномальное положения верхних передних зубов, форма нижнего зубного ряда – суженная в области премоляров, имеется скученность зубов на нижней зубной дуге и умеренная скученность верхних зубов, выраженная ротация на верхней дуге, а так же щечное смещение 1.3. Проведен биометрическое измерение на моделях челюстей. Назовите биометрический метод для определения сагиттальной длины переднего отрезка зубной дуги на верхней челюсти у данного пациента://

***Метод Коркхауза**

- Метод Герлаха
- Метод Нанса
- Метод Тона
- Метод Пона

447. Подросток, 14 лет. При осмотре в полости рта отмечается нахождение переднего щечного бугра верхнего первого постоянного моляра впереди нижнего одноименного зуба.

Предварительный диагноз:

- Мезиальный прикус

***Дистальный прикус**

- Глубокий прикус
- Открытый прикус
- Перекрестный прикус

448. На основании изучения суммы мезиодистальных размеров коронок 4-ех резцов верхней челюсти определена абсолютная макродентия , ее величина должна :

***35 мм и более**

- 21 мм
- 15 мм
- 16-18 мм
- 11-12 мм

449. Ребенок, 12 лет. Ребенок невысокого роста, отмечается гипоплазия обеих ключиц, выпуклый лоб, средняя зона лица западает. В полости рта все зубы временные, имеются первые постоянные моляры атипичной формы. Выберите дополнительный метод исследования:

- Телерентгенография
- Изготовление диагностических моделей
- Томография ВНЧС

***Ортопантомография**

- Дентальный снимок

450. Ребенок, 12 лет. Жалобы на нарушение речеобразования, рот полуоткрытый. В полости рта отмечается сагиттальная щель размером 6 мм, перекрытие нижних передних зубов верхними фронтальными зубами. Дыхание ротовое, прикусывает нижнюю губу. Предварительный диагноз:

***Дистальный прикус**

- Открытый прикус
- Перекрестный прикус
- Мезиальный прикус
- Ортогнатический прикус

451. Ребенок, 5 лет. При профилактическом осмотре отмечается более выраженный тяж уздечки языка более выражен, расположение ближе к кончику языка и ограничивающий его движение.

Предварительный диагноз:

- Нейтральный прикус
- Ортогнатический прикус
- Прямой прикус
- Мезиальный прикус

***Дистальный прикус**

452. Ребенок, 6 лет. Пользуется подбородочной пращей в течение года в ночное время, но безрезультатно. При внешнем осмотре отмечается незначительное выступание нижней губы. В полости рта отмечаются тремы, зубные ряды формы полукруга, обратное перекрытие фронтальных зубов. Соотношение боковых зубов не нарушено. Предварительный диагноз:

- Дистальный прикус
- Глубокий прикус
- Открытый прикус
- Перекрестный прикус

***Мезиальный прикус**

453. Ребенок 5 лет. При профилактическом осмотре отмечается нарушение функции глотания. Глотательная проба положительна с образованием симптома «наперстка». Укажите, нарушения состояния каких мышц определяются клинически при нарушении функции глотания:

- жевательных мышц
- мышц глаз
- мышцы мягкого неба
- височных мышц

***мышц приротовой области**

454. Выберите методику постановки брекетов при которой определяется позиция, затем приклеивание брекета на гипсовой модели, с последующим переносом в полость рта?

***методика непрямого приклеивания брекетов**

- методика прямого приклеивания брекетов
- методика комбинированного приклеивания брекетов
- методика двухэтапного приклеивания брекетов
- методика переносного приклеивания брекетов

455. В клинику обратился ребенок О., 2 лет, с жалобами на припухлость и боли в подчелюстной области справа. Со слов мамы ребенок 1 неделю назад болел ангиной. При осмотре: в подчелюстной области пальпируется болезненный инфильтрат 2.0х2.0см, подвижный, с кожей и подлежащими тканями не спаян. Кожа над ним в цвете не изменена, собирается в складку.

Поставьте предварительный диагноз:

- боковая киста шеи
- хронический гиперпластический лимфаденит

***острый серозный лимфаденит**

- острый гнойный лимфаденит
- острый серозный сиалоаденит

456. В клинику обратился ребенок Н., 12 лет с жалобами на боли при жевании, от холодного и горячего в области бокового резца справа. Из анамнеза: ударился во время игры в бокс. При местном осмотре: асимметрия лица за счет отека верхней губы справа. Коронка 1.2 зуба повреждена полностью с захватом корневой части. Отмечается боли от температурных раздражителей. Вскрыта пульповая камера, определяется кровоточивость пульпы. На рентгенограмме: имеется линия перелома на границе корня и коронки зуба. Поставьте предварительный диагноз:

- верхушечный перелом корня 1.2 зуба
- срединный перелом корня 1.2 зуба

***коронковый перелом корня 1.2 зуба**

- полный отлом коронки 1.2 зуба
- продольный коронково-корневой перелом 1.2 зуба

457. В клинику обратился ребенок М., 11 лет с жалобами на боли и отек десны нижних зубов. При местном осмотре: лицо симметричное. Открывание рта свободное. Глубина преддверия полости рта составляет 3 мм, нижняя губа малоподвижна во время акта речи. Уздечка нижней губы мало выражена. В области десневого края 3.1, 4.1 зубов имеется гиперемия и болезненность при пальпации. Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического вмешательства:

- короткая уздечка языка, френулопластика
- короткая уздечка верхней губы, хейлопластика
- деформация альвеолярного отростка, альвеолопластика

***мелкое преддверие полости рта, вестибулопластика**

- слизистые тяжи преддверия полости рта, альвеолопластика

458. В стоматологическую клинику обратился ребенок Г., 11 лет с жалобами на выпадение пломбы в 2.4 зубе, изменение его в цвете. Из анамнеза: 2.4 зуб ранее лечен по поводу кариеса дентина, пломба выпала неделю назад. Объективно: лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 2.4 зуба имеется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование вскрытой полости зуба, перкуссия безболезненны. Реакция на температурные раздражители отсутствует. ЭОД=100мкА. На рентгенограмме: расширение периодонтальной щели в области верхушки корня зуба. Поставьте клинический диагноз и определите вид лечения:

***хронический фиброзный периодонтит 2.4 зуба, эндодонтическое лечение**

- острый гнойный периостит от 2.4 зуба, периостотомия
- хронический гранулематозный периодонтит 2.4 зуба, удаление

- хронический гранулирующий периодонтит 2.4 зуба, эндодонтическое лечение
- обострение хронического фиброзного периодонтита 2.4 зуба, удаление

459. В клинику обратилась мама ребенком Л., 7 лет с жалобами на дефект коронки 3.6 зуба. При осмотре: Лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 3.6 зуба имеется дефект эмали с захватом дентина 0,1 см Зондирование безболезненное, дно и края полости плотные. Показатели ЭОД = 10 мкА. Поставьте диагноз и определите метод лечения:

- кариес эмали, реставрация стеклоиномером
- кариес цемента, штампованные коронки
- *кариес дентина, реставрация профилактика композитом**
- клиновидный дефект, реставрация амальгаммой
- системная гипоплазия, реставрация фиссурным герметиком

460. В клинику обратилась мама ребенком П., 3 лет с жалобами на периодические боли в 7.5 зубе во время приема пищи, с сохранением болевых ощущений 10 мин. При осмотре: на жевательной поверхности 7.5 зуба имеется кариозная полость, заполненная размягченным дентином. При удалении размягченного дентина, обнажилась пульпа 7.5 зуба. Пульпа кровоточит, при зондировании болезненно, перкуссия безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- хронический периодонтит, ультразвуковое исследование 7.5 зуба
- острый пульпит, магнитно-резонансная томография 7.5 зуба
- острый периодонтит, компьютерная томография 7.5 зуба
- *хронический фиброзный пульпит 7.5 зуба, визиография зуба**
- хронический гангренозный пульпит, ортопантомография

461. В клинику обратилась мама ребенком Ж., 5 лет с жалобами на периодические боли в 8.4 зубе во время приема пищи, с сохранением болевых ощущений 15 мин. При осмотре: на жевательной поверхности 8.4 зуба имеется кариозная полость, заполненная размягченным дентином, коронка зуба изменена в цвете. При удалении размягченного дентина, обнажилась пульпа 8.4 зуба. Пульпа серого цвета, при зондировании болезненно, перкуссия безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- хронический периодонтит, ультразвуковое исследование 8.4 зуба
- острый пульпит, магнитно-резонансная томография 8.4 зуба
- острый периодонтит, компьютерная томография 8.4 зуба
- хронический фиброзный пульпит 8.4 зуба, ортопантомография
- *хронический гангренозный пульпит, визиография зуба**

462. В клинику обратилась мама ребенком Ю., 12 лет с жалобами на быстропроходящие в боли во время приема пищи и на дефект коронки 4.6 зуба. При осмотре: Лицо симметричное, открывание рта свободное. На жевательной поверхности 4.6 зуба имеется кариозная полость заполненная остатками пищи. При зондировании дно болезненное, дно и края полости покрыта размягченным дентином. Реакция на температурный раздражитель выражена слабо. Показатели ЭОД = 12 мкА. Поставьте диагноз и определите метод лечения:

- кариес эмали, ультразвуковое исследование 4.6 зуба
- кариес цемента, окрашивание 4.6 зуба
- *кариес дентина, визиография 4.6 зуба**
- клиновидный дефект, сиалография

- системная гипоплазия, биохимический анализ крови

463. В клинику обратился ребенок 10 лет с жалобами на припухлость в подъязычной области справа. Со слов мамы ребенок болен в течение 6 месяцев, когда появилась припухлость и периодически увеличивалась и вновь уменьшалась. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела -36,4С, ЧДД -20 в мин, ЧСС-88 в мин. Лицо симметричное, открывание рта свободное. В подъязычной области справа пальпируется инфильтрат 3,0;2,0 см, слизистая оболочка над ним бледно-розового цвета с синюшным оттенком, пальпация безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического лечения:

- дермоидная киста дна полости рта, цистоэктомия
- ретенционная киста правой слюнной желез, цистотомия
- ретенционная киста околоушно-слюнной железы, цистоэктомия
- *ретенционная киста подъязычной слюнной железы справа, цистотомия**
- ретенционная киста подчелюстно слюнной железы справа, цистоэктомия

464. В клинику обратился ребенок Н. 13 лет с жалобами на боли и припухлость в щечной области слева, повышение температуры тела до 38,5 С, слабость, недомогание. Со слов мамы ребенок болен в течение 5 суток, состояние ухудшилось. Общее состояние средней степени тяжести. Температура тела -38,4С, ЧДД -24 в мин, ЧСС-106 в мин. Лицо симметричное, открывание рта свободное. Асимметрия лица за счет отека в щечной области слева. В данной области имеется инфильтрат 4,0х4,0, кожа над инфильтратом гиперемирована, отечна и напряжена. В центре инфильтрата имеется 4 гнойных стержня, пальпация болезненна. Открывание рта болезненное, слизистая полости рта бледно- розового цвета. Поставьте предварительный диагноз и определите вид разреза:

- флегмона щечной области слева, разрез по нижнему краю инфильтрата
- *карбункул щечной области слева, крестообразный разрез**
- абсцедирующий фурункул щечной области слева, разрез по центру инфильтрата
- лимфаденит щечной области слева, разрез по нижнему краю инфильтрата
- целлюлит щечной области слева, разрез по верхнему краю инфильтрата

465. Ребенок 1,5 лет. Мама заметила изменение цвета вокруг щек верхних резцов в виде пятен. В анамнезе: ребенок недоношенный, искусственное вскармливание, рахит 1 степени, диспепсия средней тяжести. При осмотре: эмаль тусклая в области щек резцов и клыков, при зондировании шероховатость. Поставьте предварительный диагноз

- Начальный кариес, компенсированная форма
- Поверхностный кариес, компенсированная форма
- Начальный кариес, декомпенсированная форма
- *Поверхностный кариес, декомпенсированная форма**
- Системная гипоплазия, пятнистая форма

466. Ребенку 11 лет. Жалоб нет. В полости рта: 1.6 зуб изменен в цвете, на жевательной поверхности полость, заполненная пищевыми остатками. Зондирование устьев корневых каналов слабо болезненно, определяется распад в виде маркового налета, неприятный запах. Перкуссия безболезненна. На рентгенограмме корни сформированы, в околокорневых тканях патологических изменений нет. Поставьте предварительный диагноз.

- Хронический фиброзный периодонтит
- Хронический фиброзный пульпит

- Хронический гранулирующий периодонтит

- *Хронический гангренозный пульпит**

- Хронический гипертрофический пульпит

467. Ребенок 3 лет. При осмотре: в 8.5 зубе на жевательной поверхности глубокая кариозная полость. После удаления размягченного дентина пульпа вскрыта, при зондировании болезненна и кровоточит, кп=5. Поставьте предварительный предварительный диагноз

- Острый серозный пульпит

- *Хронический фиброзный пульпит**

- Хронический гранулирующий периодонтит

- Хронический гангренозный пульпит

- Хронический гипертрофический пульпит

468. Укажите препараты для проведения электрофореза с целью реминерализующей терапии при кариесе в стадии пятна декомпенсированной формы у детей в постоянных зубах:

- электрофорез с 10% иодидом калия и 2% фторидом натрия

- *электрофорез 10% глюконатом кальция и 2% фторидом натрия**

- электрофорез с гепарином и трипсином

- электрофорез с трипсином и аскорбиновой кислотой

- электрофорез с аскорбиновой кислотой и линкомицином

469. Ребенку 12 лет. Жалобы: на косметический дефект зубов. При осмотре полости рта: 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 зубы имеют меловидный оттенок, блеск отсутствует, очаги пигментации светло-коричневого цвета. На эмали небольшие, округлой формы дефекты диаметром 1,5 мм, дно их темного цвета. Поставьте диагноз

- Поверхностный кариес, декомпенсированная форма

- *Флюороз, меловидно-крапчатая форма**

- Системная гипоплазия, пятнистая форма

- Флюороз, пятнистая форма

- Системная гипоплазия, эрозивная форма

470. Ребенок 3 года. Жалобы: на боли в резце верхний челюсти при приеме пищи. Беспокоит несколько дней. Анамнез: ранее не лечились. Объективно: кп=8, ГИ 1,2. Зуб 6.1 разрушен на 1/3, эмаль хрупкая, дентин светлый, податливый. При зондировании полость не сообщается с полостью зуба, безболезненная. Перкуссия болезненна, отмечается подвижность I степени. Слизистая гиперемирована. Проведите лечение.

- Удаление зуба

- Вскрытие полости зуба, на рог пульпы девитализирующая паста, временная пломба

- Раскрытие полости зуба, на устье каналов резодент смесь, временная пломба

- *Раскрытие полости зуба, удаление путридных масс, зуб оставлен открытым**

- Раскрытие полости зуба, удаление путридных масс, в канал эвгедент паста

471. Ребенок 10 лет. В полости рта: в 4.6 зубе полость, коронковая пульпа некротизирована, зондирование устьев каналов болезненно. На R-грамме: корни сформированы на ¾ длины. У обоих корней очаги разрежения кости с нечеткими границами. Проведите лечение.

- Удаление зуба

- Девитальная глубокая ампутация

***Раскрытие полости зуба, коагуляция, временная obturation каналов, временная пломба**

- Раскрытие полости зуба, удаление putridных масс, зуб оставлен открытым, назначено внутриротовое тепло
- Раскрытие полости зуба, удаление putridных масс, в канал эвгедент паста, постоянная пломба

472. Укажите метод, определяющий наличие истинного пародонтального кармана у детей:

- визуальный
- пальпаторный
- *рентгенологический**
- капилляроскопический
- реопародонтографический

473. Периоды обострения и ремиссии характерны у детей при заболеваниях слюнных желез:

- Острый вирусный сиалоденит
- Сиалоденит новорожденного
- Острый бактериальный сиалоденит
- Острый сиалодохит

***Хронического паренхиматозного сиалоденита**

474. Ребенку 7 лет, проживающему в местности с содержанием фтора 2 мг/л с интактными зубами необходимо назначить:

- Лечебно-профилактическую пасту, содержащую экстракт лечебных трав
- Лечебно-профилактическую пасту, содержащую фтор
- *Лечебно-профилактическую пасту, содержащую фосфорно-кальциевые соли**
- Гигиеническую зубную пасту с экстрактами лечебных трав
- Зубной порошок с соединениями фтора и фосфора

475. Предпочтительным методом лечения при отломе части коронки 1.1, 2.1 в результате травмы с обнажением пульпы у ребенка 7 лет является:

- Биологический метод
- *Витальная ампутация**
- Витальная экстирпация
- Девитальная ампутация
- Девитальная экстирпация

476. Ребенок 11 месяцев направлен на консультацию. Со слов мамы в полости рта имеется язва слизистой оболочки в области твердого неба. Ребенок недошенный, на искусственном вскармливании. В полости рта на твердом небе с переходом на мягкое обнаружена глубокая язва 1,2* 0,6 см., покрыта желто-серым налетом. Поставьте диагноз:

- Острый герпетический стоматит
- Кандидоз
- *Афта Беднара**
- Хронический рецидивирующий герпетический стоматит
- Язвенно-некротический стоматит

477. Ребенок обратился с жалобами на косметический дефект зубов с момента их прорезывания. При осмотре зубы обычной величины, формы, цвета. На поверхности эмали всех зубов

расположены бороздки, придающие ей рифленый вид, расположенные хаотично. На рентгенограмме-полость зуба и корни без видимых изменений. Поставьте диагноз.

- Системная гипоплазия, бороздчатая форма
- Флюороз, штриховая форма
- Несовершенный остеогенез
- *Несовершенный амелогенез
- Несовершенный дентиногенез

478. Ребенок 2 лет заболел остро. Температуры до 38°C. Объективно: состояние средней тяжести. На коже лица в приротовой области и красной кайме губ определяется группа пузырьков. В подчелюстной области с обеих сторон пальпируются значительно увеличенные, плотные, болезненные лимфатические узлы. Кожа над лимфатическими узлами несколько гиперемирована, собирается в складку. Флюктуация не определяется. Предполагаемый диагноз:

- Острый серозный одонтогенный лимфаденит
- *Острый серозный стоматогенный лимфаденит
- Абсцедирующий лимфаденит
- Аденофлегмона подчелюстной области
- Аденоабсцесс подчелюстной области

479. Ребенок 6 месяцев находится на естественном вскармливании. Мама заметила, что девочка в последнее время стала беспокойна, отказывается от груди. Объективно: на фоне гиперемированной слизистой оболочки губ, языка имеется белесоватый творожистый налет, легко снимающийся при соскабливании. Какие фармакологические средства следует использовать в данном случае:

- кератопластические
- антибактериальные
- кортикостероидные
- *противогрибковые
- противовирусные

480. У ребенка 8-ми лет со слов мамы определяется запах изо рта и связано это с разрушенными зубами. При осмотре: в 5.5 зубе вскрыта полость зуба, пульпа грязно-серого цвета с неприятным запахом, глубокое зондирование болезненно. На рентгенограмме выявлены деструктивные изменения в околоворхушечной области с вовлечением в процесс зачатка постоянного зуба. Какой метод лечения целесообразно использовать:

- *удаление зуба
- метод депофореза
- метод пульпэктомии
- консервативное лечение
- эндодонтическое лечение

481. У мальчика 13-ти лет жалобы на пульсирующие боли в 4.7 зубе, усиливающиеся ночью и от горячей пищи. Объективно: ГИ-2,0; КПУ-2; на жевательной поверхности 4.7зуба имеется глубокая кариозная полость, зондирование болезненно по всему дну, при перкуссии возникают болевые ощущения. Проведите дополнительный метод исследования

- общий анализ крови, электроодонтометрия
- электроодонтометрия, термометрия

***рентгенография, термометрия**

- флюоресценция, трансиллюминация
- общий анализ крови, витальное окрашивание

482. Мышьяковистая интоксикация периодонта у детей купируется:

- экстирпацией пульпы и пломбированием канала в то же посещение
- ампутацией пульпы с наложением тампона с обезболивающим препаратом под временную повязку

***удалением пульпы, медикаментозной обработкой канала, введением в корневой канал турунды с препаратами йода или унитиолом**

- удалением пульпы, наложением тампона с резорцин-формалиновой жидкостью
- удалением пульпы, зуб оставляем открытым на 24 часа

483. Ребенок 9 лет. При объективном осмотре на вестибулярной поверхности фронтальных зубов имеются поражения эмали в виде меловидных полосок. Содержание фтора в питьевой воде в регионе составляет 2,5 мг/л. Сформируйте диагноз:

***флюороз штриховая форма**

- очаговая одонтодисплазия
- флюороз эрозивная форма
- флюороз деструктивная форма
- флюороз меловидно- крапчатая форма

484. К врачу-стоматологу обратился ребенок 11 лет. Шесть дней назад во время игры в футбол он получил травму зуба. Зуб выпал, за помощью не обращался из-за страха перед родителями. При осмотре: лицо симметричное, кожные покровы не изменены. В полости рта 1.1 зуб отсутствует. Лунка частично эпителизирована. Слизистая в области зуба без изменений. Какой предварительный диагноз поставил врач стоматолог?

- Первичная адентия 1.1
- Вторичная адентия 1.1

***Полный вывих 1.1**

- Вколоченный вывих 1.1
- Перелом коронки 1.1

485. У пациента при осмотре наблюдается мостовидный протез верхней челюсти с опорными коронками 2.3-2.6 зубы 2.7-2.8 зубы отсутствуют. После снятия мостовидного протеза ранее удален 2.6 так как зуб полностью разрушен. Поставьте диагноз

***II класс по кеннеди**

- III класс по кеннеди
- IV класс по кеннеди
- I класс по кеннеди
- V класс по гаврилову

486. К врачу-стоматологу обратился мужчина 36 лет с жалобами на приступообразные боли в области зуба нижней челюсти. Лицо симметричное правильной формы кожные покровы чистые. В полости рта в 4.8 зубе кариозная полость которая не сообщается с полостью зуба зондирование болезненно в одной точке. Перкуссия безболезненна. Какова лечебная тактика по отношению данному зубу?

- витальная ампутация
- *витальная экстрипация**
- девитальная ампутация
- девитальная экстрипация
- удаление зуба

487. При отливке модели по оттиску с нечеткими отображениями зубодесневого желобка препарированного зуба под металлакерамическую коронку у коронки будет отсутствовать контакт с

***уступом**

- антаганистом
- завышать прикус
- рядом стоящими зубами
- протетической плоскостью

488. Мужчине 52 лет запланирован частичный съмный пластиночный протез на верхнюю челюсть, При осмотре имеется дефект зубного ряда в переднем отделе с выраженной атрофией альвелярного гребня. Определите вариант постановки зубов

- на мягкой подкладке
- на металлическом базисе
- *на искусственном базисе**
- на двухслойном базисе
- на приточке

489. В стоматологическую клинику обратился мужчина 67 лет предъявляет жалобы на полное отсутствие зубов верхней и нижней челюстей. При осмотре выявлены экзостозы на верхней челюсти и резкая атрофия альвелярного гребня на нижней челюсти. Выерите базис для изготовление полного съемного протеза данному пациенту

***пластмассовый**

- металлический
- силиконовый
- нейлоновый
- двухслойный

490. Отказ от защиты препарированных недепульпированных зубов временными конструкциями отсутсвие защитного барьера эмали и вскрытие дентинных трубочек с повреждением одонтобластов в первые сутки приводит к

- пародонтиту
- периодонтиту
- смещению зубов
- повышенной стираемости

***повышенной болевой чувствительности**

491. В челюстно-лицевой отделение поступил мужчина 42 лет с травмой челюстно-лицевой области. Со слов пациента сознание не терял рвоты не было. Общее состояние средней тяжести . Челюстно-Лицевой хирург сразу отправил его на рентгеновский снимок. На снимке линия перелома проходила у основания грушевидного отверстия альвелорного отростка через бугор

верхней челюсти и крыловидный отросток. Какой предварительный диагноз в данной клинической ситуации?

***перелом верхней челюсти по Ле-Фор-I**

- перелом верхней челюсти по Ле-Фор-II
- перелом скуловой дуги
- сочетанная травма
- частичный перелом верхней челюсти

492. Пациент М 62 год.Объективно: на верхней и нижней челюсти имеются хорошо выраженные альвеолярные отростки.покрытые слегка податливой слизистой оболочкой.Небо так же покрыто равномерным слоем слизистой оболочки умеренно податливой в задней его трети.Естественные складки слизистойоболочки(уздечка губ,щек и языка) как на верхней так и на нижней челюсти достаточно удалены от вершины альвеолярной части. Выберите предварительный диагноз

***I класс по суппле**

- III класс по суппле
- IV класс по суппле
- V класс по суппле
- II класс по суппле

493. 494. Ребенок 4 лет,Жалобы на боли в зубе ночью и во время пищи. Анамнез аллергоанамнез отягощен. Часто болеет простудными заболеваниями.В полости рта на жевательных поверхностях 5.4,5.5,7.5,8.5,6.4 зубов имеются глубокие кариозные полости,зондирование болезненное в одной точке перкуссия безболезненна. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета Какой вид обезболивание эффективен в данной клинической ситуации?

***общее обезболивание**

- седация
- премедикация
- инфильтрационная
- проводниковая

495. Ребенок 10 лет.Анамнез заболевания;после консультации у врача ортодонта было рекомендовано удаление ретенированного зуба у ребенка аллергия на антибиотики,клубнику,цитрусовые, который проявляются высыпанием На панорамной рентгренграмме отмечается сужение верхней челюсти между 1.1 и 1.3 зубами в горизонтальном положении находится ретинированный 1.2 зуб . Какие препараты необходимо назначить до операции удаления зубов?

***Кортикостероиды**

- Противовоспалительные
- Антигистаминные
- Детоиксикационные
- Сульфаниламидные

496. Пациент Ж 52 года обратился с жалобами наощущение привкуса металла и чувство кислоты во рту.Анамнез протеризовался 2 месяц назад .Объективно слизистая оболочка полости рта без изменений в полости рта имеются протезы из разнородных материалов(мостовидные протезы из сплава золота, нержавеющей стали) прикус фиксированный.Кожный пробы на никель хром кобальт отрицательные .Поставьте диагноз:

***Гальваноз**

- Аллергический стоматит
- травматический стоматит
- химико-токсический стоматит
- токсический стоматит

497. У ребенка 4 лет на жевательной поверхности 8.5 зуба в пределах эмали и дентина имеется кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Дентин рыхлый, влажный, светло-желтого цвета. Зондирование, перкуссия безболезненны. Реакция на термический раздражитель положительна. Слизистая вокруг бледно-розового цвета. Какой пломбировочный материал показан и механизм его применения?

- Силикатный цемент, так как обладает плохой растворимостью в слюне//
- Силикофосфатный цемент, так как обладает хорошей адгезией к тканям зуба//
- Галлодент, так как обладает высокой прочностью//
- Композиционный материал, так как можно подобрать по цвету//

***Стеклоиономерный цемент, так как обладает реминерализующими свойствами**

498. Ребенок 1,5 лет. Мама заметила изменение цвета вокруг шеек верхних резцов в виде пятен. В анамнезе: ребенок недоношенный, искусственное вскармливание, рахит 1 степени, диспепсия средней тяжести. При осмотре: эмаль тусклая в области шеек резцов и клыков, при зондировании шероховатость. Поставьте предварительный диагноз.

- начальный кариес, компенсированная форма
- поверхностный кариес, компенсированная форма
- начальный кариес, декомпенсированная форма

***поверхностный кариес, декомпенсированная форма**

- системная гипоплазия, пятнистая форма

499. У ребенка 4-х лет при осмотре на жевательной поверхности в 8.5 зубе глубокая кариозная полость со светлым влажным, легко отслаивающимся дентином. Зондирование болезненно по эмалево-дентинному соединению, индекс кп – 6. Какую тактику лечения из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразно применить?

- изолирующая прокладка, постоянная пломба

***лечебная прокладка, временная пломба;//**

- герметизация фиссур, пломбирование;//
- реминерализующая терапия;//
- временная пломба

500. У ребенка 13 лет жалобы на быстрое, малоболезненное разрушение зубов. Боль в зубах при приеме холодной и сладкой пищи, при чистке зубов. Индекс КПУ=14. Кариозные полости расположены в пришеечной области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти. На вестибулярной поверхности и в пришеечной области наряду с запломбированными и незапломбированными зубами меловидные пятна. Какова тактика лечения?

- санация полости рта
- назначение внутрь препаратов Са и F
- рациональное протезирование
- рациональная гигиена полости рта

***санация полости рта и назначение внутрь препаратов Са и F**

501. Во время санации полости рта ребенка 14 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 14,13,12,11, 21,22,23,24,25 зубов верхней челюсти обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, пористая, КПУ= 9, ГИ= 1,4. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес дважды отит, болел ОРЗ. В первую очередь следует назначить:

***реминерализирующую терапию с препаратами Са и F**

- тщательную гигиену полости рта с использованием лечебно профилактических зубных паст
- сошлифование пораженного участка эмали
- лечебное питание
- внутрь препараты Са, Р и F

502. Ребенку 4 года. Жалобы на острые самопроизвольные боли в области 8.5 с короткими светлыми промежутками. Боль от холодного и горячего, а также боли при накусывании. Объективно: у ребенка декомпенсированная форма кариозного процесса. В 8.5 зубе глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином и пищевыми остатками. После удаления размягченного дентина экскаватором зондирование дна кариозной полости болезненно. Перкуссия резко болезненна. Десна области 8.5 слегка гиперемирована, при пальпации болезненна. При остром воспалении пульпита начальным пусковым механизмом является

- пролиферация

***альтерация**

- экссудация
- секреция
- некротизация

503. Ребенок 3 лет. При осмотре: в 8.5 зубе на жевательной поверхности глубокая кариозная полость. После удаления размягченного дентина пульпа вскрыта, при зондировании болезненна и кровоточит, кп=5. Поставьте предварительный ДЗ.

- Острый серозный пульпит
- Хронический гипертрофический пульпит
- *Хронический фиброзный пульпит**
- Хронический гранулирующий периодонтит
- Хронический гангренозный пульпит

504. Ребенок 1 года 8 мес плохо спит последние 2 ночи. Коронки меловидного цвета. При экскавации размягченных эмали и дентина в 51 и 61 зубов вскрылась кровоточащая пульпа. Поставьте диагноз:

- острый очаговый пульпит
- острый диффузный пульпит
- *обострение хронического фиброзного пульпита**
- обострение хронического гипертрофического пульпита
- обострение хронического гангренозного пульпита

505. При профилактическом осмотре у ребенка 4 лет на жевательной поверхности 75 зуба выявлена кариозная полость, заполненная размягченным дентином коричневого цвета. На дне кариозной полости определяется сообщение с полостью зуба, при зондировании которого

возникает болезненность и кровоточивость. Перкуссия зуба безболезненна, кп=5. Какой метод лечения целесообразно использовать в данном случае?

- Девитальная экстирпация

- *Девитальная ампутация**

- Биологический метод

- Витальная ампутация

- Витальная экстирпация

506. На прием обратилась мама с ребенком 4 лет с жалобами на острые боли в верхнем зубе справа. При осмотре: на жевательной поверхности 5.4 зуба кариозная полость с размягченным дентином, при удалении которого легко вскрылась полость зуба с выделением гнояного экссудата, глубокое зондирование болезненно. Индекс кп-2. Какой предварительный диагноз

- острый периодонтит

- острый серозный пульпит

- *острый гнойный пульпит**

- хронический фиброзный пульпит

- хронический фиброзный периодонтит

507. В клинику обратилась мама ребенком Ж., 5 лет с жалобами на периодические боли в 8.4 зубе во время приема пищи, с сохранением болевых ощущений 15 мин. При осмотре: на жевательной поверхности 8.4 зуба имеется кариозная полость, заполненная размягченным дентином, коронка зуба изменена в цвете. При удалении размягченного дентина, обнажилась пульпа 8.4 зуба. Пульпа серого цвета, при зондировании болезненно, перкуссия безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите метод диагностики:

- хронический периодонтит, ультразвуковое исследование 8.4 зуба

- острый пульпит, магнитно-резонансная томография 8.4 зуба

- острый периодонтит, компьютерная томография 8.4 зуба

- хронический фиброзный пульпит 8.4 зуба, ортопантомография

- *хронический гангренозный пульпит, визиография зуба**

508. Укажите препараты для проведения электрофореза с целью ремтерапии при кариесе в стадии пятна декомпенсированной формы у детей в постоянных зубах:

- электрофорез с 10% иодидом калия и 2% фторидом натрия

- *электрофорез с 10% иодидом калия и 2% фторидом натрия**

- электрофорез с гепарином и трипсином

- электрофорез с трипсином аскорбиновой кислотой

- электрофорез с аскорбиновой кислотой и линкомицином

509. Ребенку 10 лет. В полости рта: в 46 зубе полость, коронковая пульпа некротизирована, зондирование устьев каналов болезненно. На R-грамме: корни сформированы на $\frac{3}{4}$ длины. У обоих корней очаги разрежения кости с нечеткими границами. Проведите лечение

- Удаление зуба

- девитальная глубокая ампутация

- Раскрытие полости зуба, коагуляция, временная obturация каналов, временная пломба

- *Раскрытие полости зуба, удаление putridных масс зуб оставлен открытым, назначено внутриротовое тепло**

- Раскрытие полости зуба, удаление putridных масс, в канал эвгедент паста, постоянная пломба

510. Периоды обострения и ремиссии характерны у детей при заболеваниях слюнных желез:

- острый вирусный сиалоденит
- сиалоденит новорожденного
- острый бак сиалоденит
- острый сиалодохит

***хронического паренхиматозного сиалоденита**

511. К врачу-стоматологу обратилась мама с ребенком в возрасте 7 лет. Объективно: зубы нормальной величины и формы, но окраска зубов водянисто-серая с перламутровым блеском, эмаль зубов легко скалывается. Какой предварительный диагноз, из перечисленных ниже, вероятен?

***Синдром Стентона-Капдепона**

- Несовершенный амелогенез
- Синдром Олбрайта
- Болезнь Фролика
- Синдром Ослера

512. Ребенок 6 месяцев находится на естественном вскармливании. Мама заметила, что девочка в последнее время стала беспокойна, отказывается от груди. Объективно: на фоне гиперемированной слизистой оболочки губ, языка имеется белесоватый творожистый налет, легко снимающийся при соскабливании. Какие фармакологические средства следует использовать в данном случае:

- кертопластические
- антибактериальные
- Кортикостероидные

***Противогрибковые**

- противовирусные

513. Мышьяковистая интоксикация периодонта у детей купируется:

- экстирпацией пульпы и пломбированием канала в то же посещение
- экстирпацией пульпы и пломбированием канала в то же посещение

***удалением пульпы, медикаментозной обработкой канала, введением в корневой канал турунды с препаратами йода или унитиолом**

- удалением пульпы, наложением тампона с резорцин-формалиновой жидкостью
- удалением пульпы, зуб оставлен открытым на 24 часа

514. Девочка 11 месяцев направлена на консультацию. Со слов мамы в полости рта имеется язва слизистой оболочки в области твердого неба. Ребенок недошенный, на искусственном вскармливании. В полости рта на твердом небе с переходом на мягкое обнаружена глубокая язва 1,2* 0,6 см., покрыта желто-серым налетом. Ваш диагноз

- афта Сеттона
- афта Бехчета

***афта Беднара**

- афта рецидивирующая
- язва декубитальная

515. Предпочтительным методом лечения при отломе части коронки 1.1 ,2.1 в результате травмы с обнажением пульпы у ребенка 7 лет является:

- биологический метод
- *витальная ампутация**
- витальная экстирпация
- девитальная ампутация
- девитальная экстирпация

516. Ребенок 10 лет жалуется на боли в полости рта при приеме пищи, при разговоре, на периодические появления эрозий. Общее состояние больного существенно не страдает.

Объективно: на боковой поверхности языка слева-эрозия округлой формы размером 0,5 на 0,7 см, окруженная ободком гиперемии, покрытая сероватым налетом. Поставьте диагноз

- хронический рецидивирующий герпетический стоматит//
- *хронический рецидивирующий афтозный стоматит//**
- хронический гиперпластический кандидоз//
- многоформная экссудативная эритема//
- контактный аллергический стоматит

517. Ребенок 4 лет. Жалобы на слабость, насморк, светобоязнь, кашель, боль при приеме пищи.

Объективно: ребенок вялый, апатичный, температура тела 39 С, выделения из носа, осиплость голоса. В полости рта: слизистая оболочка гиперемирована, в ретромолярной области- пятна в виде брызгов извести (пятна Филатова-Коплика), на коже лица и за ушами мелкоточечная сыпь.

Консультация какого специалиста требуется для проведения дальнейшего общего лечения данного заболевания://

- гастроэнтеролога//
- *инфекциониста//**
- эндокринолога//
- кардиолога//
- хирурга

518. В стоматологическую клинику обратилась мама с ребенком Ш., 4 лет с целью профилактического осмотра. Лицо симметричное, открывание рта свободное. Коронка 8.4 зуба изменена в цвете, десна в области 8.4 зуба посиневшая, зондирование и перкуссия безболезненны, пальпаторно в области верхушки 8.4 зуба отмечается отечность, на рентгенограмме: изменение в виде "языков пламени".Какой предварительный диагноз в данной клинической ситуации?ПОХОЖ: При какой форме периодонтита рентгенологически определяется очаг резорбции костной ткани в виде языков пламени?//

- острый гнойный периодонтит
- хронический фиброзный периодонтит//
- *хронический гранулирующий периодонтит//**
- хронический гранулематозный//
- острый серозный

519. Укажите наиболее рациональный метод обезболивания для удаления 3.6 зуба по поводу обострения хронического периодонтита у ребенка 12 лет

- Электрообезболивание//
- Общее обезболивание//

· Аппликационное обезболивание//

***Проводниковое обезболивание//**

· Акупунктура

520. В клинику обратился пациент И., 16 лет с жалобами на боли и выделение гноя из свища в подчелюстной области слева. 1,5 месяца назад находился на стационарном лечении с диагнозом: перелом тела нижней челюсти по 3.6 зубу. При осмотре: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти слева. В подчелюстной области имеется свищевой ход с выбухающими грануляциями и гнойным экссудатом. Открывание рта ограничено до 3,0 см. Лунка 3.6 зуба заполнена грануляциями. На рентгенограмме: в области тела нижней челюсти в проекции лунки 3.6 зуба имеются мелкие секвестры. Поставьте клинический диагноз и определите тактику лечения:

***хронический постравматический остеомиелит, секвестрэктомия**

- острый постравматический остеомиелит, периостотомия
- фиброзная дисплазия, мукогингивопластика
- нагноившаяся радикулярная киста, цистэктомия
- острый гнойный периостит, остеоперфорация

521. В клинику обратился пациент Е., 15 лет, с жалобами на боли, припухлость щечной области справа, недомогание, повышение температуры тела до 37,20С. Болеет в течение 5 суток, когда заболел 4.6 зуб. 2 суток назад появилась припухлость щечной области. При осмотре: асимметрия лица за счет отека мягких тканей нижней челюсти справа. Пальпация болезненна. Открывание рта болезненное. Коронка 4.6 зуба разрушена на 2/3. Переходная складка сглажена, гиперемирована, отечна, напряжена. Пальпация болезненна. Поставьте предварительный диагноз и определите принципы лечения:

***острый гнойный периостит от 4.6 зуба, хирургическое лечение**

- острый гнойный периодонтит 4.6 зуба, депульпирование зуба
- острый гнойный пульпит 4.6 зуба, хирургическое лечение
- хронический периостит от 4.6 зуба, депульпирование зуба
- острый остеомиелит от 4.6 зуба, депульпирование зуб

522. В поликлинику обратился пациент Д., 16 лет с жалобами на резкую, постоянную боль в области 1.6 зуба, усиливающуюся при накусывании, отмечает чувство "выросшего" зуба. Объективно: лицо симметричное. Кожные покровы чистые, региональные лимфатические узлы увеличенные, болезненные при пальпации. Открывание рта свободное, слизистая оболочка десны в области 1.6 зуба гиперемирована, отечна. На небной поверхности коронки 1.6 зуба глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином, зондирование безболезненно, перкуссия резко болезненна. На рентгенограмме - очаг разрежения костной ткани с четкими ровными контурами в области верхушки корня 1.6 зуба, округлой формы, диаметром до 0,3 x 0,3 см, имеется разрежение костной ткани в области бифуркации. Поставьте клинический диагноз и выберите инструмент для удаления 1.6 зуба:

***обострение хронического периодонтита 1.6 зуба, S- образные щипцы с шипом слева**

- хронический периодонтит 1.6 зуба, прямой элеватор
- острый периодонтит 1.6 зуба, S- образные сходящиеся щипцы
- острый пульпит 1.6 зуба, прямые щипцы
- хронический пульпит 1.6 зуба, S- образные щипцы с шипом справа

523. Ребенок 2 лет заболел остро. Температуры до 38°C. Объективно: состояние средней тяжести. На коже лица в приротовой области и красной кайме губ определяется группа пузырьков. В подчелюстной области с обеих сторон пальпируются значительно увеличенные, плотные, болезненные лимфатические узлы. Кожа над лимфатическими узлами несколько гиперемирована, собирается в складку. Флюктуация не определяется. Предполагаемый диагноз:

· Острый серозный одонтогенный лимфаденит

***острый серозный стоматогенный лимфаденит**

· абсцедирующий лимфаденит

· аденофлегмона подчелюстной области

· аденоабсцесс подчелюстной области

524. У ребенка 8-ми лет со слов мамы определяется запах изо рта и связано это с разрушенными зубами. При осмотре: в 5.5 зубе вскрыта полость зуба, пульпа грязно-серого цвета с неприятным запахом, глубокое зондирование болезненно. На рентгенограмме выявлены деструктивные изменения в околоверхушечной области с вовлечением в процесс зачатка постоянного зуба. Какой метод лечения целесообразно использовать

***удаление зуба**

· метод депофореза

· метод пульпоэктомии

· консервативное лечение

· эндодонтическое лечение

525. Для фиксации отломков, какой шиной необходима предварительная сепарация контактных поверхностей клыков и первых моляров

· Порта

***Шура**

· Вебера/

· Збаржа

· Ванкевич

526. У мальчика 2 лет в подчелюстной области справа пальпируется болезненный «шарик», подвижный, с кожей и подлежащими тканями не спаян, размером 2.0х2.0см. Кожа над ним в цвете не изменена, берется в складку. 2 недели назад ребенок болел ангиной. Поставьте предварительный диагноз:

· Боковая киста шеи

· Хронический гиперпластический лимфаденит

***Острый серозный лимфаденит**

· Острый гнойный лимфаденит

· Абсцесс подчелюстной области

527. В клинику обратился ребенок Р., 5 лет. Врач поставил диагноз: обострение хронического периодонтита от 6.5 зуба. Планируется операция удаление 6.5 зуба под локальной анестезией. Определите вид инструмента для удаления 6.5 зуба и положение врача:

· прямые щипцы, впереди и справа от пациента

· прямой элеватор, впереди и слева от пациента

· универсальные щипцы, впереди и справа от пациента

***S-образные несходящиеся щипцы с шипом справа, впереди и справа**

- S-образные сходящиеся щипцы, впереди и слева от пациента

528. В клинику обратился ребенок Ж., 12 лет, жалобы на хруст в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) справа во время открывания рта. При осмотре: лицо симметричное. При пальпации височно-нижнечелюстного сустава справа отмечается болезненность, хруст при выдвигании нижней челюсти вправо. Положителен симптом нагрузки в области височно-нижнечелюстного сустава справа. Открывание рта болезненное справа. Прикус нарушен. Уздечка языка в виде толстого, короткого тяжа прикреплена к кончику языка. Имеется скученность 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 зубов. Поставьте предварительный диагноз:

- вторичный деформирующий остеоартроз ВНЧС
- *болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава справа**
- костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава справа
- рубцовый анкилоз височно-нижнечелюстного сустава справа
- неоартроз височно-нижнечелюстного сустава справа

529. Ребенку М., 14 лет, планируется операция удаление 1.6 зуба под локальной анестезией. Определите направление и глубину продвижения иглы при проведении туберальной анестезии у ребенка:

- вниз, назад, внутрь на глубину 1,5 см
- назад, внутрь на глубину 2,0 см
- *вверх, вперед, внутрь на глубину 1,5 см**
- вверх, назад, кнаружи на глубину 2,5 см
- вниз, вперед, внутрь на глубину 1,5 см

530. В клинику обратился ребенок 10 лет с жалобами на припухлость в подъязычной области справа. Со слов мамы ребенок болен в течение 6 месяцев, когда появилась припухлость и периодически увеличивалась и вновь уменьшалась. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела -36,4С, ЧДД -20 в мин, ЧСС-88 в мин. Лицо симметричное, открывание рта свободное. В подъязычной области справа пальпируется инфильтрат 3,0х2,0 см, слизистая оболочка над ним бледно-розового цвета с синюшным оттенком, пальпация безболезненная. Поставьте предварительный диагноз и определите вид хирургического лечения:

- дермоидная киста дна полости рта, цистоэктомия
- ретенционная киста правой слюнной желез, цистотомия
- ретенционная киста околоушно-слюнной железы, цистоэктомия
- *ретенционная киста подъязычной слюнной железы справа, цистотомия**
- ретенционная киста подчелюстно слюнной железы справа, цистоэктомия

531. В клинику обратился ребенок Н. 13 лет с жалобами на боли и припухлость в щечной области слева, повышение температуры тела до 38,5 С, слабость, недомогание. Со слов мамы ребенок болен в течение 5 суток, состояние ухудшилось. Общее состояние средней степени тяжести. Температура тела -38,4С, ЧДД -24 в мин, ЧСС-106 в мин. Лицо симметричное, открывание рта свободное. Асимметрия лица за счет отека в щечной области слева. В данной области имеется инфильтрат 4,0х4,0, кожа над инфильтратом гиперемирована, отечна и напряжена. В центре инфильтрата имеется 4 гнойных стержня, пальпация болезненна. Открывание рта болезненное, слизистая полости рта бледно-розового цвета. Поставьте предварительный диагноз и определите вид разреза:

- флегмона щечной области слева, разрез по нижнему краю инфильтрата

***карбункул щечной области слева, крестообразный разрез**

- абсцедирующий фурункул щечной области слева, разрез по центру инфильтрата
- лимфаденит щечной области слева, разрез по нижнему краю инфильтрата
- целлюлит щечной области слева, разрез по верхнему краю инфильтрата

532. . Ребенок 5 лет. Обратился в клинику с жалобами на боли, припухлость в области верхней челюсти справа. Боли появились 4 дня назад. Объективно: состояние средней тяжести, Т- 37.8°, в полости рта 5.4 зуб- разрушен, подвижен, слизистая гиперемирована, инфильтрат вестибулярной поверхности, болезненный с очагом флюктуации. Укажите объем хирургического вмешательства при данной патологии:

- внеротовой разрез и дренирование мягких тканей
- удаление причинного зуба

***периостотомия и удаление причинного зуба**

- раскрытие причинного зуба, отток гноя через корневые каналы
- периостотомия, ирригация раны

533. . В отделение детской челюстно-лицевой хирургии поступил ребенок в возрасте 6 месяцев. При осмотре врачом объективно обнаружена патология верхней губы слева, несрастание всех мягких тканей на всем протяжении губы от красной каймы по фильтруму до дна носовой полости с деформацией кожно-хрящевого отдела носа. Проведите хирургический метод лечения данной патологии

- радикальная уранопластика по Бернадскому
- щадящая ураностафилопластика по Бернадскому

***хейлопластика по Милларду с треугольниками Лимберга**

- двухсторонняя хейлопластика по Теннисону
- односторонняя хейлопластика по Лимбергу

534. К врачу-стоматологу обратился ребенок 11 лет. Шесть дней назад во время игры в футбол он получил травму зуба. Зуб выпал, за помощью не обращался из-за страха перед родителями. При осмотре: лицо симметричное, кожные покровы не изменены. В полости рта 1.1 зуб отсутствует. Лунка частично эпителизирована. Слизистая в области зуба без изменений. Какой предварительный диагноз поставил врач стоматолог?

- Первичная адентия 1.1
- Вторичная адентия 1.1

***Полный вывих 1.1**

- Вколоченный вывих 1.1
- Перелом коронки 1.1

535. У ребенка 10 лет появилась припухлость в области нижней губы после травмы. В области нижней губы имеется припухлость 1,0х1,0 см, слизистая истончена, голубовато-розового цвета. Пальпация безболезненна. Предположите предварительный диагноз:

- Лимфангиома

***Ретенционная киста**

- Гемангиома
- Абсцесс
- Гематома

536. К врачу стоматологу обратились родители ребенка 6 лет с жалобами на затрудненное открывание рта, деформацию нижнего отдела лица. При опросе установлено: в возрасте 2 лет ребенок упал с лавки и получил травму подбородка. Занимались самолечением, к врачу не обращались. В прошлом году появилось затрудненное открывание рта, которое прогрессировало. Полгода назад появилась асимметрия лица и западение подбородочного отдела. При осмотре: рот открывается на 1,5см. Какой предварительный диагноз поставил врач стоматолог?

- Вторичный деформирующий остеоартроз правого височно-нижнечелюстного сустава
- Вторичный деформирующий остеоартроз обоих височно-нижнечелюстных суставов
- Остеоартрит правого и левого височно-нижнечелюстного сустава

***Односторонний костный анкилоз правого и левого височно-нижнечелюстного сустава**

- Врожденная патология правого и левого височно-нижнечелюстного сустава

537. В стоматологическую клинику обратился подросток 14 лет с жалобами на изменение формы языка справа, затрудненный прием пищи. Впервые изменение на языке в виде уплотнения появилось 2 года назад, медленно увеличивалось в размере с ростом ребенка. При осмотре: на боковой поверхности языка определяется образование мягко-эластичной консистенции, с четкими границами, безболезненное спаянное со слизистой оболочкой, имеющей желтоватый оттенок. При пальпации определяется дольчатое строение. На УЗИ: образование в толще мышц боковой поверхности языка, имеющее местами выраженную капсулу дольчатого строения, без признаков распада, без воспалительной инфильтрации по периферии. Какой диагноз поставил врач стоматолог?

- Пиогенная гранулема
- Рабдомиома
- Миобластома

***Десмопластическая фиброма**

- Гемангиоэндотелиома

538. Новорожденный М., 2 сутки. Жалобы на дефект в области верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба, нарушение питания, дыхания. Из анамнеза: патология врожденная. Ребенок родился в гипоксии. При местном осмотре: асимметрия лица за счет дефекта в области верхней губы, продолжающийся на альвеолярный отросток, твердое и мягкое небо. Имеется укорочение среднего отдела верхней губы, деформация кожно-хрящевого отдела носа справа. Открывание рта свободное. В области альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба имеется дефект, сообщающийся с полостью носа. Имеется укорочение мягкого неба, расширен средний отдел глотки. Предположите начальные этапы комплексноэтапной реабилитации ребенка:

- хейлопластика, ураностафиллопластика

***ортодонтическое, хейлопластика**

- ураностафиллопластика, ортодонтическое лечение
- хейлопластика, логопедическое лечение
- ураностафиллопластика, логопедическое лечение

539. Ребенку 4 мес. Объективно: ширина дефекта в области губы и альвеолярного отростка 22 мм. Отсутствует дно носа. Язык постоянно занимает высокое положение. Дефект распространяется на твердое и мягкое небо. Поставьте диагноз

- бионатор

***обтуратор**

- активатор
- стимулятор
- кинетор

540. Ребенок, 5 лет, обратилась по поводу неправильного прикуса и западания верхней губы. При осмотре полости рта выявлено, что у ребенка имеются молочные зубы и первые постоянные моляры. Зубные ряды полукруглой формы, тремы между фронтальными зубами отсутствуют. Отмечено обратное резцовое перекрытие, смыкание моляров правильное. Антропометрическое исследование моделей по З. И. Долгополовой позволило обнаружить, что имеется сужение верхнего зубного ряда между 5.2 и 6.2 на 1 мм, между 5.3 и 6.3 на 3 мм. Укорочение зубного ряда на 3,5 мм. Нижний зубной ряд сужен между клыками и первыми молочными молярами в пределах 1 мм, в переднем отделе укорочен на 2 мм. Из нижеперечисленного выберите метод лечения для данной патологии:

- расширение верхнего и нижнего зубного рядов

***расширение верхнего зубного ряда**

- удлинение верхнего зубного ряда
- расширение нижнего зубного ряда
- удлинение верхнего и нижнего зубного ряда

541. Пациентке 14 лет. В полости рта: Протрузия верхних клыков из-за нехватки места в зубной дуге. Прикус ортогнатический. При биометрическом исследовании моделей челюстей выявлены индексы по Пону: премолярный – 80; молярный – 64. Для данной патологии наиболее целесообразно проведение:

- удаление 13 и 23 зуба без применения ортодонтического аппарата
- удаление 14 и 24 зуба без применения ортодонтического аппарата

***удаление 14 и 24 зуба с применением ортодонтического аппарата**

- применение ортодонтического аппарата без хирургического метода
- удаление 13 и 23 зуба с дальнейшим протезированием

542. Девушке 17 лет. Форма головы долихоцефалическая. В полости рта тесное положение верхних и нижних фронтальных зубов. Биометрическое измерение апикального базиса челюстных костей показало уменьшение ширины и длины II степени. Для данной патологии наиболее целесообразно проведение:

- Межапроксимальная сепарация
- Расширение зубных рядов
- Протрагирование зубов
- Дистализация зубов

***Удаление отдельных зубов**

543. У больного 10 лет, на телерентгенограмме угол наклона верхних резцов по отношению к плоскости основания верхней челюсти больше 71 градусов. Ваш диагноз

***протрузия резцов**

- ретрузия резцов
- прогенический прикус
- тремы
- диастема

544. Ребенку 10 лет, направлен школьным стоматологом. Смыкание в области первых постоянных моляров по III классу Энгля, при проведении клинической функциональной пробы ребенок установить зубы встык не может. Какой из дополнительных методов исследования применяют для определения причины аномалии

***Телерентгенографию**

- Ортопантомографию
- Фотометрию
- Антропометрию
- Биометрию

545. Пациент 11 лет. Жалуется на неправильное положение передних зубов. При объективном исследовании отмечается – скученность зубов во фронтальном отделе верхней челюсти, мезиальное смещение 16, 26, нарушение речи, глотание, несмыкание губ. Ваш план действия:

***панорамная рентгенография**

- томография
- аксиография
- реография
- электромиография

546. Ребенку 14 лет. На КЛКТ и ТРГ клыки верхней челюсти расположены вестибулярно со значительным недостатком места для них в зубном ряду. Выберите метод лечения

- удаление клыков

***удаление первых премоляров и дистальное перемещение клыков**

- пластика уздечки верхней губы
- удаление моляров
- расширение верхней челюсти с помощью аппарата Хургинной

547. Пациентке 11 лет. Диагноз – небное положение 2.1, при наличии блокирования его зубами – антагонистами. В течение 3 месяцев пользуется пластинкой с секторальным распилом, винтом, разобщением боковых зубов. Какой элемент ортодонтического аппарата обеспечивает разобщение зубов:

- секторальный распил
- толкающий кламмер
- опорно-удерживающий кламмер

***окклюзионная накладка**

- ортодонтический винт

548. Пациентке 12 лет. Объективно: 1.3 и 2.3 зуба вне зубной дуги, в вестибулярном положении. Была изготовлена расширяющая пластинка с М-образными кламмерами по всей площади коронок 1.3 и 2.3 зуба на вестибулярной дуге. Укажите характер перемещения зубов:

- коронковое перемещение

***корпусное перемещение**

- перемещение вокруг продольной оси
- вертикальное перемещение
- перемещение корней зубов

549. Ребенок 7 лет. Соотношение первых постоянных моляров по 1 классу Энгля. Протрузия верхних передних зубов. Между ними тремы, диастема. Назовите аппарат:

***Аппарат Эйнсворта**

- Аппарат Шварца с вестибулярной дугой
- Аппарат Лури
- Аппарат Айзенберга
- Скользящий аппарат Энгля

550. Ребенок 8 лет. В полости рта: при смыкании зубных рядов определяется сагиттальная щель 6 мм, коронки 6/6 разрушены. Поставьте диагноз.

***глубокое резцовое перекрытие.**

- перекрестному
- прогнатическому
- ортогнатическому
- прямому

551. В клинику обратилась пациентка А., 13 лет с жалобами на нарушение эстетики лица, некрасивые зубы. Объективно: лицо симметричное. Открывание рта свободное. Резцы верхней челюсти перекрывают резцы нижней челюсти на 8 мм, сагитальная щель между резцами 11мм, дистоокклюзия в боковых участках зубных рядов. Тремы между передними зубами верхней челюсти. Имеется некариозное поражение эмали на вестибулярной поверхности передних зубов верхней челюсти. Поставьте предварительный диагноз:

- язычное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, кариес цемента
- мезиоокклюзия, острый гнойный пульпит
- перекрестный прикус, острый гнойный периодонтит
- открытый прикус, кариес дентина

***глубокое резцовое перекрытие, гипоплазия эмали**

552. В клинику обратился ребенок И., 8 лет с жалобами на нарушение жевания. Из анамнеза: состояние после хейло-урано-стафиллопластики. При осмотре: осанка нарушена – имеется искривление позвоночника. Асимметрия лица за счет недоразвития верхней челюсти. Открывание рта свободное, отсутствует верхний боковой резец слева. Имеется межзубное положение кончика языка. На рентгенограмме кисти руки установлена запоздавшая оссификация скелета на 2 года. Поставьте диагноз и определите технику ортодонтического лечения:

***мезиоокклюзия, регулятор функций Френкеля III типа**

- дистоокклюзия, съемные ретейнеры
- открытый прикус, несъемная ортодонтическая техника «прямая дуга»
- перекрестный прикус, аппараты трансфорсы W. Clark
- глубокий прикус, аппараты Spring jet

553. В мезиальном прикусе гнатической разновидности у девочек в возрасте 11 лет и у мальчиков 13 лет, с целью задержки развития нижнего зубного ряда при адентии аналогичных верхних зубов, целесообразно удаление:

- зачатков первых моляров в младшем школьном возрасте
- зачатков первых премоляров в старшем школьном возрасте
- *зачатков нижних третьих моляров в препубертатном периоде**
- зачатков вторых премоляров в среднем школьном возрасте

- зачатков вторых моляров в дошкольном возрасте

554. Девочка 5 лет. Родители ребенка обратились к врачу ортодонту с жалобами на вредную привычку – сосание большого пальца, на щепелявость речи. В анамнезе: аденоиды, ринит. При внешнем осмотре ребенка- лицо симметричное, вертикальные размеры лица изменены-нижняя треть удлинена. Нижнечелюстной угол слабо выражен. Рот полуоткрыт, губы смыкаются с напряжением, тонус губ слабый. Объективно: преддверия полости рта в пределах нормы, размер и прикрепления уздечек в норме. Форма зубных дуг правильной формы, зубной ряд интактный, соответствует к возрасту, имеются кариозные полости 5.5 и 8.4. Во фронтальном отделе зубных рядов имеется вертикальная щель, размером 3 мм. Выберите метод лечения с учетом возраста ребенка:

***.Аппаратный метод**

- Ортопедический метод
- Реконструктивные операции
- Лечебная гимнастика
- хирургическая коррекция

555. Ребенок 12 лет .Жалобы на нарушение речеобразования ,рот полуоткрытый .В полости рта отмечается сагитальная щель размером 6 мм, перекрытие нижних передних зубов верхними фронтальными зубами Дыхание ротовое , прикусывает нижнюю губу. Предварительный диагноз :

***Дистальный прикус**

- открытый прикус
- Перекрестный прикус
- Мезиальный прикус
- ортогнатический прикус

556. Какой характер кровотечения служит признаком наружного артериального кровотечения

- Медленное кровотечение
- Кровь сочится по каплям
- Медленное и тягучее кровотечение
- Кровь темно-красного цвета

***Быстрое и пульсирующее кровотечение**

557. Достоверным признаком клинической смерти является

***Отсутствие пульса на сонной артерии**

- Сужение зрачков
- Бледность кожных покровов
- Появление трупных пятен
- Понижение АД

558. Эффективным мероприятием оказания неотложной помощи при отёке лёгких является

- усаживание пациента в положение Фаулера, наложение жгутов на бёдра до исчезновения пульса
- придание пациенту положение с поднятым ножным концом
- подача дыхательных аналептиков через небулайзер
- применение наркотических анальгетиков

***усаживание пациента в положение ортопноэ, наложение жгутов на бёдра и плечо одной руки до исчезновения пульса**

559. Для эффективной реанимации взрослому, частота компрессий грудной клетки должна составлять

- 60-80 в минуту
- *100-120 в минуту**
- более 120 в минуту
- 80-120 в минуту
- не менее 90 в минуту

560. Появление у пациента при кашле мокроты алого цвета указывает на

- отёк лёгких
- *лёгочное кровоотечение**
- желудочное кровоотечение
- рак лёгких
- бронхоэктатическую болезнь

561. Определите диагностическое исследование, которое позволит провести дифференциальный диагноз. У ребенка 6 лет недомогание, слабость, боль в животе, тошнота рвота, шумное дыхание, запах ацетона в выдыхаемом воздухе.

- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- *Определение уровня сахара в крови**
- Ультразвуковое исследование
- Компьютерная томография

562. Шкала Глазго используется для оценки

- *уровня угнетения сознания**
- степени тяжести шока
- выраженности дыхательных расстройств при коме
- состояния новорожденного
- вида комы

563. Какие конструкции несъемного протезирования применяются при патологической стираемости и некариозных поражениях?

- мостовидные протезы;
- дентальные импланты;
- вкладки, виниры, полукоронки
- адгезивные мостовидные протезы.
- *искусственные коронки;**

564. У пациента 25 лет дефект коронковой части 1.1 зуба, 4 класс по Блэку перед протезированием на приеме у врача стоматолога – ортопеда первый клинический этап изготовления металлокерамической коронки состоит из:

- обследование, постановка диагноза, выбор конструкции протеза, препарирование зуба, обезболивание, снятие двухслойного слепка
- *обследование, рентген снимок, постановка диагноза, выбор конструкции, обезболивание, препарирование, формирование уступа, ретракция зубодесневого края, снятие двухслойного слепка**

- постановка диагноза, выбор конструкции, обезболивание, препарирование уступа, снятие двухслойного слепка
- обследование, постановка диагноза, выбор конструкции, формирование уступа, препарирование зуба, ретракция зубодесневого края, снятие слепка
- обследование, снятие слепка, препарирование зуба

565. Какое осложнение может возникнуть после протезирования штифтовым зубом по Ильиной-Маркосян, если кубической формы вкладка неплотно прилежит к сформированной полости в устье корневого канала:

- подвижность антагониста
- отлом коронковой части
- *расцементировка штифта**
- воспалительные изменения в периодонте
- воспалительные изменения в краевой десне

566. У пациентки 55 лет при протезировании металлокерамическим мостовидным протезом какие зуботехнические методы изготовления данной конструкции применялись?

- протяжка
- волочение
- *литье**
- ковка
- штамповка

567. Пациенту 28 лет был поставлен диагноз: Ложный сустав тела нижней челюсти. Месяц назад было проведено лечение с наложением шины Тигерштедта на 1,5 недели. Из анамнеза: пациент страдает инсулин-зависимым сахарным диабетом. Назовите причины образования ложного сустава:

- долгий срок иммобилизации
- *маленький срок иммобилизации**
- влияние соматического заболевания
- неправильное сопоставление отломков
- неадекватный выбор шинирующей конструкции в данном клиническом случае

568. Пациент 30 лет, рабочий химической фабрики, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на повышенную чувствительность к холодному, сладкому, горячему, эстетический дефект передних зубов. При осмотре полости рта выявлено уменьшение высоты коронок нижних фронтальных зубов на 1/3, выраженный альвеолярный отросток, фасетки стирания в пределах дентина с гладкими поверхностями. На верхних фронтальных зубах – коронки из безметалловой керамики, отвечающие клиническим требованиям. Поставьте диагноз, определите план лечения, исходя из результатов предыдущего протезирования:

- кариес зубов, прямые реставрации
- гиперестезия, реминерализующая терапия
- кислотный некроз, протезирование встречными вкладками
- повышенная декомпенсированная стираемость; цельнолитые коронки
- *повышенная компенсированная стираемость, коронки из безметалловой керамики**

569. На определении центрального соотношения челюстей в полном съемном протезировании высота окклюзионного валика верхней челюсти при полуоткрытом рте не выведена на 1 – 2 мм ниже из-под верхней губы и не отмечена линия «улыбки». Какая ошибка обнаружится на четвертом клиническом этапе; тактика врача:

***длинные фронтальные искусственные зубы; заново определить центральное соотношение**

- ошибки нет, ничего не исправлять
- длинные фронтальные искусственные зубы; определить протетическую плоскость по зрачковой линии
- короткие боковые искусственные зубы; определить протетическую плоскость по носо - ушной линии
- длинные фронтальные искусственные зубы; сформировать вестибулярный овал на верхнем окклюзионном валике

570. Пациенту 75 лет на ортопедическом приеме при проведении во время припасовки индивидуальной ложки на нижнюю челюсть использовали функциональные пробы по Гербсту, в момент глотания индивидуальная ложка смещается с нижней челюсти, ваша тактика

- ложку укорачивают в зоне между клыками с вестибулярной стороны
- ложку необходимо укоротить на участке от места позади бугорка до челюстно-подъязычной линии
- *ложку в таких случаях укорачивают по вестибулярному краю сзади**
- ложку укорачивают по вестибулярному краю спереди
- ложку укорачивают вдоль челюстно-подъязычной линии

571. Какая патология зубочелюстной системы является относительным противопоказанием для имплантации?

- Наличие ограниченных включенных дефектов зубного ряда

***Патологический прикус**

- Полное отсутствие зубов
- Отсутствие одного зуба во фронтальном отделе
- Заболевания ЖКТ., обусловленные утратой зубов и нарушением пережевывания пищи

572. После одонтопрепарирования 23 зуба под металлокерамическую коронку перед снятием двухслойного оттиска необходимо провести:

- тщательное высушивание
- уточнение границы коронки
- точный отпечаток пришеечной части зуба
- защита зуба от химических и температурных раздражителей

***ретракция тканей десны**

573. У пациента 50 лет на ортопедическом приеме при осмотре полости рта обнаружен дефект зубного ряда зубная формула: 1817161501211/ 2122232425000. Поставьте диагноз и определите жевательную эффективность по Агапову:

- III класс IV подкласс по Кеннеди, 20 %//

***II класс III подкласс по Кеннеди, 30 %**

- I класс III подкласс по Кеннеди, 40 %
- III класс 1 подкласс по Кеннеди, 50 %
- III класс IV подкласс по Кеннеди, 60 %

574. Пациентка 40 лет, обратилась в стоматологическую клинику, при осмотре на 23 зубе отсутствует коронковая часть «индекс ИРОПЗ, по В.Ю.Миликевичу составляет 0,9 (90% разрушения)», на рентген снимке корневой канал запломбирован до верхушки корня, воспалительных процессов не обнаружено. Какая штифтово-культевая конструкция показана при покрытии металлокерамической коронкой?,

· стандартный анкерный штифт из нержавеющей стали и культея из композита

***цельнолитая металлическая штифтово-культевая вкладка**

· стекловолоконный штифт и культея из композита

· стандартный анкерный титановый штифт и культея из композита

· стандартный анкерный медный штифт и культея из композита

575. В клинику обратился пациент Т., 39 лет с жалобами на нарушение приема пищи, речи, отсутствие центральных зубов на нижней челюсти. При осмотре полости рта определен включенный дефект переднего отдела зубного ряда на нижней челюсти, при отсутствии 41,31,32 зубов. Определите вид протеза для закрытия данного дефекта:

***несъемный мостовидный протез**

· консольный протез

· полный съемный протез

· адгезивный мостовидный протез

· частичный съемный протез

576. В клинику обратился пациент У., 49 лет с жалобами на нарушение приема пищи, отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти. При осмотре полости рта определен включенный дефект бокового отдела зубного ряда на нижней челюсти слева, при отсутствии 35,36 зубов. Определите вид протеза для закрытия данного дефекта

· консольный протез

***несъемный мостовидный протез**

· полный съемный протез

· адгезивный мостовидный протез

· частичный съемный протез

577. В клинику обратился пациент Е., 32 лет после операции имплантация зубов. Пациенту показано временное протезирование. При осмотре полости рта определены дефекты зубного ряда на нижней челюсти справа и слева, при наличии имплантатов в области 34,35,36,45,46,47 зубов. Определите вид временного протеза для закрытия данного дефекта:

· полный съемный протез

· несъемный мостовидный протез

· консольный протез

***адгезивный мостовидный протез**

· частичный съемный протез

578. В клинику обратился пациент С., 26 лет с жалобами на неправильное положение зубов, боли при жевании в правом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). При осмотре: средняя линия зубной дуги нижней челюсти смещено вправо на 2,5 мм. Отсутствует 4.6 зуб, вестибулярно расположены 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубы. На компьютерной томографии - мезиальное смещение головки нижней челюсти в левом височно-нижнечелюстном суставе. Поставьте клинический диагноз и определите технику лечения:

***язычное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, рубцовый анкилоз ВНЧС**

- глубокий прикус, костный анкилоз ВНЧС
- перекрестный прикус, артроз ВНЧС
- вестибулярное положение 1.2, 2.2, 3.3, 3.4 зубов, дисфункция ВНЧС
- прямой прикус, ретрогения

579. Выберите местный анестетик, предназначенный для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, аллергией и астмой, не содержащий вазоконстриктор, средняя продолжительность действия которого 20 – 40 минут:

***Mepivastesin**

- Lidocain
- Septonest
- Ubistesin
- Ubistesin™ Forte

580. Пациент 27 лет, обратился в клинику с целью дальнейшего протезирования. При объективном осмотре выявлено: отсутствие 1.7, 1.6, 2.5, 2.6, 2.7 зубов. Вертикальная супраокклюзия 3.7 зуба, окклюзионная поверхность которого находится выше протетической плоскости на 5 мм. Выберите план ортопедического лечения данного пациента:

***дефект зубного ряда верхней челюсти 3 класс по Кеннеди, потеря жевательной эффективности 44 % по Агапову Н.И.; депульпирование зубов, подлежащих значительному укорочению, подготовки зубов перед гемисекцией, ампутацией корней**

- дефект зубного ряда верхней челюсти 3 класс, 4 подкласс по Кеннеди, потеря жевательной эффективности 45% по Оксману И.М.; удаление рубцов по переходной складке, углубление преддверия полости рта, удаление эпюлисов
- дефект зубного ряда верхней челюсти 2 класс по Кеннеди, потеря жевательной эффективности 30% по Агапову Н.И.; пластика вершины беззубой альвеолярной части, введение поднадкостничного имплантата, лечение зубов
- дефект зубного ряда верхней челюсти 2 класс, 4 подкласс по Кеннеди, потеря жевательной эффективности 31% по Оксману И.М.; удаление острых костных выступов на аль-веолярном отростке, подготовка зубов перед гемисекцией, лечение зубов
- дефект зубного ряда верхней челюсти 2 класс по Кеннеди, потеря жевательной эффективности 62% по Оксману И.М.; исправление положения отдельных зубов и зубочелюстных аномалий, устранение деформаций окклюзионной поверхности

581. У пожилых пациентов, имеющих перемещение первых и вторых постоянных моляров по отношению к окклюзионной плоскости на 4-5 мм, при помощи чего показано исправление деформаций зубного ряда?

***депульпирования и укорочения зубов**

- удаления зубов
- ортодонтического вколачивания
- избирательное пришлифовывание
- аппаратно-хирургического метода

582. В клинику обратился пациент Н., 62 лет с жалобами на нарушение приема пищи, полное отсутствие зубов. Асимметрия лица за счет западения губ и щек. Выражены носогубные складки, опущены углы рта. Нижняя челюсть смещена вверх и кпереди, высота нижнего отдела лица

снижена. Открывание рта свободное, наблюдается полное отсутствие зубов, атрофия вестибулярной поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти и язычной поверхности альвеолярного отростка нижней челюсти. Определите вид прикуса, развившееся при полном отсутствии зубов:

- ювенильная дизокклюзия
- ювенильная мезиоокклюзия
- старческая микрогения
- старческая прогнатия

***старческая прогения**

583. В клинику обратился пациент Д., 45 лет с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. При осмотре: асимметрия лица за счет западения верхней губы, опущение углов рта. Открывание рта свободное, отмечается средняя степень атрофии альвеолярного отростка, умеренно выражены верхнечелюстные бугры, средней глубины небо, торус выражен. Определите тип беззубой верхней челюсти по Шредеру:

- I тип

***II тип**

- III тип
- IV тип
- V тип

584. В клинику обратился пациент Я., 66 лет с жалобами на нарушение приема пищи, полное отсутствие зубов. Асимметрия лица за счет западения губ и щек. Выражены носогубные складки, опущены углы рта. Нижняя челюсть смещена кверху и кпереди, высота нижнего отдела лица снижена. Открывание рта свободное. Наблюдается полное отсутствие зубов на нижней челюсти, альвеолярная часть атрофирована во фронтальном отделе и хорошо выражена в области жевательных зубов. Определите вид атрофии беззубой нижней челюсти по Келлеру:

- 1-й тип
- 2-й тип

***3-й тип**

- 4-й тип
- 5-й тип

585. 1. Пациент, рабочий химического предприятия жалуется на появление дефектов в зубах верхней челюсти. Объективно: на вестибулярной поверхности 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 зубов определяются углубления в пределах эмали и верхних слоев дентина овальной формы, с гладкими, плотными стенками и дном. Зондирование слегка болезненно по дентино-эмалевому соединению. Реакция на температурные раздражители кратковременна. Врач рекомендовал обязательное применение во время работы индивидуальных средств защиты. Дополните лечение:

- курс реминерализующей терапии//
- препарирование полостей с последующим пломбированием композитными материалами
- полирование зубов в области поражений полировочными пастами//

***курс реминерализующей терапии с последующим пломбированием композитными материалами и повторением курса ремтерапии**

- покрытие фторлаком в области поражений

586. Пациентка 18 лет обратилась с жалобами на наличие белых и светло-коричневых пятен на зубах. Анамнез - изменение цвета зубов отмечает с детства, аналогичные изменения цвета зубов имеются у родственников. При осмотре на эмали зубов верхней и нижней челюсти выявляются множественные меловидные, в некоторых участках светло-коричневые пятна, расположенные по всей поверхности. Эмаль в области пятен гладкая, блестящая, зонд скользит по поверхности участков поражения, не окрашивается 2% раствором метиленового синего. Вероятная причина этого заболевания:

- плохая гигиена полости рта
- избыточное употребление углеводов
- *избыточное содержание фтора в питьевой воде**
- недостаточное содержание фтора в питьевой воде
- заболевания детского возраста (до 3 лет)

587. В стоматологическую клинику обратился пациент 24 лет с жалобами на косметический дефект в области зубов верхней челюсти. Анамнез: изменение цвета зубов отмечает с детства. В детстве болел рахитом. При осмотре: на вестибулярной поверхности центральных, боковых резцов и буграх первых моляров верхней челюсти выявляются симметрично расположенные, одинаковой величины меловидные пятна. Поверхность пятен ровная, гладкая, границы четкие. Дополнительный метод исследования для уточнения диагноза:

***окрашивание пятен 2% раствором метиленового синего**

- электроодонтодиагностика
- рентгенография зубов
- перкуссия зубов
- реакция зубов на температурный раздражитель

588. Пациент 30 лет обратился с жалобами на кратковременные боли в зубе верхней челюсти слева при приеме пищи. При осмотре: на дистальной поверхности 2.7 зуба небольшая, но глубокая кариозная полость, заполненная большим количеством светлого размягченного дентина. Зондирование по дну болезненное, перкуссия безболезненная. Реакция на холод кратковременная, быстро проходит после устранения раздражителя. Ваш диагноз:

- глубокий кариес, медленно прогрессирующее течение
- средний кариес, быстро прогрессирующее течение
- хронический фиброзный пульпит
- острый очаговый пульпит

***глубокий кариес, быстро прогрессирующее течение**

589. Пациент Н. явился в стоматологическую клинику на профилактический осмотр. При обследовании пациента в 3.6 зубе на жевательной поверхности выявлена большая кариозная полость с пищевыми остатками. На дне и стенках плотный пигментированный дентин. Зондирование по дну малоболезненно. Реакция на холод – незначительная, кратковременная боль. ЭОД – 5 мкА. Клинике какого заболевания соответствуют эти объективные данные:

***глубокий кариес**

- средний кариес
- средний кариес
- начальный кариес

· 590. При обследовании пациента в пришеечной области 1.4 зуба выявлена кариозная полость, дно которой располагается несколько глубже дентино-эмалевого соединения. Зуб в цвете не изменен. Зондирование по дну – безболезненное, по стенкам болезненно. Перкуссия безболезненная. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную диагностику?

· глубокий кариес, медленно прогрессирующее течение

***средний кариес**

· поверхностный кариес

· клиновидный дефект

· глубокий кариес, быстро прогрессирующее течение

591. Пациентка 27 лет обратилась с жалобами на наличие пятна в области зуба верхней челюсти слева. Анамнез: появление пятна заметила около 1 месяца назад. Объективно: в пришеечной области зуба 2.2 определяется одиночное меловидное пятно. Поверхность пятна ровная, матовая, блеск отсутствует. Пятно окрашивается 2% раствором метиленового синего. Какое лечение необходимо провести:

· Препарирование, пломбирование композиционным материалом

***Курс реминерализующей терапии**

· Сошлифовывание пятна, покрытие фторлаком

· Изготовление винира

· Пломбирование

[fribbi junior](https://fribbi.junior)

Консультация по ТСТ для интернов 2024

1.Классификация кариеса по МКБ-10!!!

K02.0 Кариес эмали, стадия мелового пятна (начальный кариес)

K02.1 Кариес дентина

K02.2 Кариес цемента K02.3

Приостановившейся кариес зубов

K.02.3 Одонтоклазия Детская меланодентия Меланодонтоклазия

K02.8 Другой кариес зубов

K02.9 Кариес зубов неуточнённый

Пример:

1. Пациентка 33 лет жалуется на кратковременные, быстро проходящие боли при приеме сладкой пищи в зубе верхней челюсти. Объективно: на жевательной поверхности зуба 4.6 выявлена кариозная полость **в пределах верхних слоев дентина**. Зондирование болезненно в области эмалево-дентинного соединения. Реакция на холод кратковременна. Перкуссия безболезненна. Поставьте предварительный диагноз **по МКБ-10://**

Кариес эмали//

Кариес дентина//

Средний кариес//

Кариес зубов неуточнённый//

Приостановившийся кариес

Пример:

2.Пациентка 28 лет обратилась с целью профилактического осмотра. Объективно: на вестибулярной поверхности в пришеечной области 2.4 зуба выявлено меловидное пятно. Поверхность пятна матовая, слегка шероховатая, зондирование, реакция на холод безболезненны. При окрашивании **2% раствором метиленового синего пятно окрасилось** в голубой цвет. Поставьте предварительный диагноз **по МКБ-10?**//

Одонтоклазия//

Кариес дентина//

Кариес зубов неуточненный//

Приостановившийся кариес//

Кариес эмали, стадия «белого (мелового) пятна»

2.КАРИЕС ЭМАЛИ – обратить внимание на наличие пятна, окрашивание пятна метиленовым синим – если это начальный кариес, либо полость в пределах ЭМАЛИ – если это поверхностный кариес

3.Поверхностный кариес – это тоже КАРИЕС ЭМАЛИ, т.е. полость В ПРЕДЕЛАХ ЭМАЛИ

Пример:

Пациентка 33 лет явилась с целью санации полости рта. Объективно: на жевательной поверхности зуба 3.4 определяется кариозная полость **в пределах эмали**. Зондирование, реакция на холод, перкуссия безболезненны. Поставьте предварительный диагноз?//

Кариес эмали//

Кариес дентина//

Средний кариес//

Кариес зубов неуточненный//

Приостановившийся кариес

4.Кариес дентина (сюда вообще относят и средний, и глубокий кариес) – наличие кариозной полости, зондирование болезненно по стенкам полости (подразумевают средний кариес), на дне – наличие плотного дентина

5.Дано описание кариозных полостей по 1-6 классам – выучить их расположение!!!

Пример:

1.На вестибулярной поверхности в области слепой ямки нижнего второго моляра слева обнаружена кариозная полость. К какому классу кариозных полостей по Блэку относится данная полость?//

к 1-му классу//

ко 2-му классу//

к 3-му классу//

к 4-му классу//

к 5-му классу

Пример:

2.На медиально-контактной поверхности 3.6 зуба обнаружена кариозная полость. К какому классу кариозных полостей по Блэку относится данная полость?//

1 класс//

2 класс//

3 класс//

4 класс//

5 класс

Пример:

3. На дистальной поверхности верхнего центрального резца справа обнаружена кариозная полость. Дистальный угол и режущий край коронки не повреждены. К какому классу кариозных полостей по Блэку относится данная полость?//

к 1-му классу//

ко 2-му классу//

к 3-му классу//

к 4-му классу//

к 5-му классу

6.Лечение быстро прогрессирующего кариеса – наложение лечебной прокладки на дно кариозной полости под временную пломбу, через 5-7 дней – замена пломбы на постоянную

Пример:

Патология, при которой проводится в первое посещение – обезболивание, препарирование кариозной полости, высушивание, лечебная прокладка, временная пломба. Через 5-7 дней - наложение лечебной, изолирующей прокладок, постоянная пломба из композита химического отверждения://

Глубокий кариес, быстро прогрессирующее течение//

Поверхностный кариес//

Глубокий кариес, медленно прогрессирующее течение//

Средний кариес, быстро прогрессирующее течение//

Средний кариес, медленно прогрессирующее течение

7. Дистрактор «стеклоиомеры» - пломбировочные материалы, обладающие кариесстатическим действием – это такие СИЦ, как Мегацем, Кавитан, Кетак-моляр

Пример:

Цементы, обладающие кариесстатическим свойством://

Цинк-фосфатные цементы//

Цинк-оксид эвгенольные цементы//

Поликарбоксилатные цементы//

Стеклоиономерные цементы//

Силико-фосфатные цементы

8.Дистрактор «Хронический фиброзный пульпит» - наличие длительной боли ТОЛЬКО при приеме пищи, либо может быть при перемене окружающей температуры, ЭОД – 40-50 мкА

Пример:

Жалобы на длительные, медленно проходящие боли в зубе нижней челюсти слева от термических раздражителей. При осмотре: **кариозная полость сообщается с полостью зуба, зондирование**

вскрытой пульпы резко болезненно, пульпа кровоточит, перкуссия безболезненная, холодная вода вызывает длительную боль. ЭОД -50 мкА. О каком заболевании идет речь?//
хронический гипертрофический пульпит//
ретроградный пульпит//
хронический фиброзный пульпит//
конкрементозный пульпит//
хронический гангренозный пульпит

9.Дистрактор «Обострение хронического фиброзного пульпита» - наличие ночной, самопроизвольной, боли в зубе, иррадиирующей. Ранее зуб лечен. Кариозная полость сообщается с полостью зуба либо «полость зуба вскрыта. Зондирование болезненно в точке сообщения»

Пример:

Больной 38 лет, жалуется на самопроизвольную, приступообразную боль в 1.5 зубе с иррадиацией по ходу ветвей тройничного нерва; все виды раздражителей вызывают длительный приступ. Зуб периодически болел ранее, при осмотре полость зуба вскрыта, зондирование резко болезненно во вскрытой точке. Поставьте диагноз://
острый диффузный пульпит//
обострение хронического фиброзного пульпита//
хронический гангренозный пульпит//
острый периодонтит//
обострение хронического периодонтита

10.Тест с описанием глубокого кариеса. Вопрос: с каким заболеванием необходимо дифференцировать – хронический фиброзный пульпит

Пример:

Пациент 25 лет обратился с жалобами на кратковременные, быстропроходящие боли от температурных, механических раздражителей в зубе нижней челюсти. При осмотре: на дистально-жевательной поверхности 3.6 зуба обнаружена глубокая кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, заполненная пищевыми остатками и размягченным дентином. С какой патологией необходимо проводить дифференциальную диагностику?//
Острый диффузный пульпит//
Хронический фиброзный пульпит//
Хронический гангренозный пульпит//
Хронический фиброзный периодонтит//
Острый периодонтит в стадии интоксикации

11.Тест с вопросом какая реакция на температурный раздражитель – дано описание хронического периодонтита, пациентка явилась с целью санации полости рта, обнаружена кариозная полость, сообщ-ся с полостью зуба, зондирование коронковой части полости и устьев безболезненно, перкуссия безболезненна. Рентгенограмма – равномерное расширение периодонтальной щели у вершины медиального корня.

Пример:

Жалобы на неприятные ощущения в зубе. При осмотре: кариозная полость сообщается с полостью зуба, зондирование, перкуссия безболезненны, слизистая не изменена. На рентгенограмме расширение периодонтальной щели. ЭОМ свыше 100 мкА. Каков результат термодиагностики?

Реакция на температурный раздражитель безболезненна

Кратковременная, быстропроходящая боль

Длительная, медленнопроходящая боль

Боль возникает не сразу, через некоторое время

Возникает только от холодного

12.Дистрактор «Хронический гипертрофический пульпит»

Пример:

Для какого заболевания характерно **разрастание "дикого мяса" в кариозной полости**, которое легко кровоточит; иногда бывают боли ноющего характера от различных раздражителей://

острый диффузный пульпит//

острый гнойный пульпит//

конкрементозный пульпит//

хронический гипертрофический пульпит//

обострение хронического фиброзного пульпита

13.Дистрактор «Острый периодонтит в стадии экссудации» - постоянная, ноющая боль, асимметрия лица за счет отека лица, сглаженность переходной складки у причинного зуба, ЭОД выше 100 (105 мкА)

Пример:

Жалобы: на **постоянные ноющие боли в 3.7 зубе, усиливающиеся при накусывании, чувство «выросшего» зуба**, болезненность и припухлость десны в области данного зуба, появившиеся 2 дня назад. Ранее беспокоили боли только от температурных и механических раздражителей. Для какого заболевания характерны данные жалобы://

острый диффузный пульпит//

обострение хронического гангренозного пульпита//

острый периодонтит в фазе интоксикации//

острый периодонтит в фазе экссудации//

обострение хронического фиброзного пульпита

14.Дистрактор «Обострение хронического гранулирующего периодонтита» - постоянная ноющая боль..., на десне рубец от свища

Пример:

Жалобы на **постоянные ноющие боли, чувство «выросшего» зуба, боли при накусывании в зубе в течение 3-х дней. Ранее зуб болел.** При осмотре: в 3.6 зубе глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование, реакция на температурные раздражители безболезненна. Перкуссия болезненна. ЭОМ – свыше 100 мкА. Слизистая в области зуба отечна, гиперемирована, на десне рубец от свища. На рентгенограмме – **очаг разрежения костной ткани в области верхушки корня с нечеткими контурами.** Поставьте диагноз://

острый периодонтит в фазе интоксикации//

острый периодонтит в фазе экссудации//
обострение хронического фиброзного периодонтита//
обострение хронического гранулирующего периодонтита//
обострение хронического гранулематозного периодонтита

15. Есть тесты «поставить диагноз и определить метод диагностики либо специалиста кому отправить

Пример:

Молодой человек 27 лет обратился с жалобами на длительно не заживающую трещину в углу рта. Много курит. При осмотре: в углу рта слева обнаружена трещина, при пальпации безболезненная, имеется плотный хрящеподобный инфильтрат в основании. На слизистой щек – крупные папулы до 1,0 см в диаметре с мацерированной белесоватой поверхностью. Консультация какого специалиста необходима данному пациенту://

Терапевт//

гематолог//

дерматовенеролог//

фтизиатр//

кардиолог

16. Тест – при лечении ранее леченного зуба в корневом канале сломался эндодонтический инструмент ближе к верхушке. Попытки извлечь не увенчались успехом. Корневой канал искривлен в дистальную сторону. На рентгенограмме – очаг деструкции костной ткани у верхушки корня. Врач запломбировал проходимую часть канала до инструмента. Какая тактика врача для предотвращения в дальнейшем осложнений? Ответ – резекция верхушки корня

17. Дистрактор «Хронический катаральный гингивит» - кровоточивость ТОЛЬКО при чистке зубов, наличие зубных отложений, неприятный запах изо рта. Десна ОТЕЧНЫЕ, РЫХЛЫЕ, ГИПЕРЕМИРОВАННЫЕ С ЦИАНОТИЧНЫМ ОТТЕНКОМ, наличие наддесневых зубных отложений

Пример:

Пациент обратился с жалобами на **периодическую кровоточивость** десен при чистке зубов. Объективно: слизистая оболочка десневого края и межзубные сосочки **гиперемированы с синюшным оттенком**, рыхлые, неплотно прилегают к зубам. Имеются **наддесневые** зубные отложения. **Зубодесневое прикрепление не нарушено**. На рентгенограмме: изменений в костной ткани альвеолярной кости не обнаружено. Поставьте диагноз://

хронический катаральный гингивит//

острый катаральный гингивит//

хронический пародонтит легкой степени тяжести//

пародонтальный синдром при болезни Иценко-Кушинга//

гипертрофический гингивит, фиброзная форма

18. Дистрактор «снятие зубных отложений, СКЛЕРОЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ» - дано описание гипертрофического гингивита, отечной формы – разросшиеся десневые сосочки, ложные карманы

Пример:

Устранение местных раздражающих факторов, применение противоотечных, противовоспалительных препаратов в виде аппликаций, электрофореза, **склерозирующей терапии**, рекомендации по уходу за полостью рта входят в план местного лечения при//

фиброматозе десен//

язвенном гингивите//

хроническом пародонтите легкой степени//

отечной форме гипертрофического гингивита//

фиброзной форме гипертрофического гингивита

19. Дистрактор «пародонтит легкой степени тяжести» - пародонтальные карманы 3-3,5 мм, на рентгенограмме – неравномерное снижение высоты межзубных перегородок до 1/3 высоты

Пример:

Пациент 38 лет обратился с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, наличие зубных отложений, запах изо рта. Об-но: слизистая оболочка **десны отека, цианотична**, кровоточит при дотрагивании. Зубы устойчивы, корни их не оголены. **Пародонтальные карманы глубиной до 3,5 мм**, наличие над- и поддесневых зубных отложений. **На рентгенограмме – неравномерное снижение высоты межзубных перегородок до 1/3 высоты.** Ваш предполагаемый диагноз://

хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести//

хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести//

хронический катаральный гингивит//

генерализованный пародонтит тяжелой степени в стадии ремиссии//

хронический гипертрофический гингивит

20. Дистрактор «пародонтит средней степени тяжести» - пародонтальные карманы 4-5 мм, на рентгенограмме – неравномерное снижение высоты межзубных перегородок до 1/2 высоты

Пример:

Пациентка 43 лет обратилась с жалобами на появление щелей между зубами, иногда кровоточивость десен, подвижность зубов, дискомфорт. Объективно: большое количество зубных отложений, легкая кровоточивость десен при зондировании, неравномерная атрофия сосочков и десневого края, оголение корней до 1/3 их длины, подвижность отдельных зубов **1-2 степени**. Пародонтальные карманы **глубиной 4-5 мм**. **На рентгенограмме – неравномерное снижение высоты межзубных перегородок на 1/2 высоты.** Какой из диагнозов соответствует данной клинической картине://

хронический генерализованный пародонтит средней степени//

хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени//

обострение хронического генерализованного пародонтита легкой степени//

обострение гипертрофического гингивита отечной формы//

гипертрофический гингивит, отечная форма

21. Дистрактор «пародонтит тяжелой степени» - пародонтальные карманы свыше 5 мм, на рентгенограмме – неравномерное снижение высоты межзубных перегородок на 2/3 высоты

Пример:

Пациент 65 лет, жалуется на подвижность зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен. При осмотре: обильные над- и поддесневые твердые зубные отложения. Десневой край отечный, синюшный, пародонтальные карманы **глубиной 6 мм и более**, при надавливании серозно-гнойное

отделяемое. Смещение фронтальных зубов и моляров верхней и нижней челюсти, оголение их корней на $\frac{1}{2}$ их длины и более. **Подвижность зубов II-III степени. На рентгенограмме – неравномерное снижение высоты межзубных перегородок на $\frac{2}{3}$ (более $\frac{1}{2}$) высоты.** Поставьте предварительный диагноз://

хронический пародонтит легкой степени//

пародонтоз средней степени//

хронический пародонтит средней степени//

хронический пародонтит тяжелой степени//

пародонтоз тяжелой степени

22.Дистрактор «пародонтоз» - жалобы на зуд десен, чувствительность зубов, при осмотре – десна бледно-розовая, клиновидные дефекты, оголение зубов/корней, зубы устойчивы. На Р-грамме- РАВНОМЕРНОЕ СНИЖЕНИЕ высоты межальвеолярных перегородок, чередование очагов остеопороза и остеосклероза

Пример:

Пациент обратился с жалобами на зуд десен, небольшую подвижность зубов. При осмотре **слизистая оболочка десны бледно-розового цвета**, атрофия десневых сосочков, десневого края, корни зубов оголены на 4-5 мм, пародонтальные карманы не определяются. Подвижность зубов 1-2 степени. На рентгенограмме **равномерное снижение высоты** межальвеолярных перегородок **до $\frac{1}{2}$ их высоты**, чередование очагов остеопороза и остеосклероза://

пародонтоз легкой степени//

пародонтоз средней степени//

гипертрофический гингивит, фиброзная форма//

генерализованный пародонтит легкой степени//

генерализованный пародонтит средней степени

23.Тест по перелому зуба нижнего фронтального зуба нижней челюсти – ранее лечен эндодонтически, жалобы на боль в зубе после травмы - раскололся вдоль на две части – медиальную и дистальную. На Р-грамме – линия перелома от коронки до верхушки. Тактика врача? Ответ – удаление зуба

24.Дистрактор «Системная гипоплазия» - пятна на 1.2 и 2.2 зубах (СИММЕТРИЧНЫЕ ЗУБЫ), не окрашиваются метиленовым синим

Пример:

Во время профилактического осмотра полости рта пациента 20 лет обнаружены пятна белого цвета с четкими границами на режущих краях 1.1 и 2.1 зубов, а также на буграх 1.6 и 2.6 зубов. **Пятна не окрашиваются 2% р-ром метиленового синего** и визуально не определяются в области остальных зубов. Поставьте предварительный диагноз://

Флюороз зубов, пятнистая форма//

Гипоплазия, пятнистая форма//

Поверхностный кариес//

Гиперплазия эмали//

Начальный кариес

25.Дистрактор «Системная гипоплазия» - зубы 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.6 – пятна, не окрашиваются метиленовым синим

26.Дистрактор «Флюороз, меловидно-крапчатая форма» - пятна сразу после прорезывания, на фоне которых дефекты эмали диаметром 1-1,5 мм, глубиной до 0,5 мм

Пример:

Пациент 28 лет обратился с жалобами на эстетический дефект зубов. Анамнез: изменения цвета эмали зубов отмечает с детства. Такие же изменения зубов, как у него имеются у родственников, проживающих с ним в одной местности. При осмотре эмаль всех зубов желтоватого цвета с множественными дефектами глубиной 0,1-0,5 мм, диаметром до 1,5 мм. Зондирование, реакция на температурный раздражитель, перкуссия зубов безболезненны. Поставьте предварительный диагноз://

Флюороз, пятнистая форма//

Гипоплазия, точечная форма//

Гипоплазия, бороздчатая форма//

Эрозия эмали, начальная степень//

Флюороз, меловидно-крапчатая форма

27.Дистрактор «Многоформная экссудативная эритема» - обратить внимание на «СИМПТОМ КОКАРДЫ»

Пример:

Пациент, 35 лет обратился в стоматологическую поликлинику с жалобами на общее недомогание, повышенную температуру тела, появление красных пятен на лице и шее, на тыльной стороне кистей - элементов поражения в **виде «кокард»**. Объективно: в полости рта отмечается **разлитая эритема и отек слизистой оболочки, пузыри разных размеров, болезненные эрозии**, покрытые фиброзным налетом. Каков наиболее вероятный диагноз у больного://

системная красная волчанка//

многоформная экссудативная эритема//

хронический рецидивирующий афтозный стоматит//

рецидивирующие глубокие рубцующие афты//

синдром Бехчета

28.Дистрактор «Красный плоский лишай» - папулы округлой формы, имеющие тенденцию к слиянию с образованием кружевного рисунка, располагаются обычно на обеих щеках в задних отделах (ретромолярной области)

Пример:

Пациентка 52 лет жалуется на чувство шероховатости в области щек. Заметила недавно. Сопутствующие заболевания - сахарный диабет, гипертоническая болезнь. При осмотре в задних отделах **слизистой щек с обеих сторон определяются папулы белого цвета в виде кружевного рисунка, не снимающиеся при поскабливании**. Поставьте предварительный диагноз?//

Хронический гиперпластический кандидоз//

Плоская лейкоплакия//

Красная волчанка//

Пузырчатка//

Красный плоский лишай, типичная форма

29.Дистрактор «Лейкоплакия, плоская форма» - в описании мужчины, очаг помутнения в переднем отделе щеки, ближе к углу рта, не соскабливается, не возвышается, вредная привычка - курение

Пример:

Во время осмотра пациента, 36 лет, **курильщика со стажем курения 18 лет**, выявлен очаг помутнения на слизистой оболочке щек белесоватого цвета, располагающийся по линии смыкания зубов в **переднем отделе щек, в виде треугольника с вершиной, обращенной к молярам. Очаг не возвышается над окружающими тканями, не снимается при поскабливании.** Слизистая оболочка вокруг очага не изменена. Поставьте диагноз.//

псевдомембранозный кандидоз//

красный плоский лишай, типичная форма//

вторичный сифилис полости рта//

плоская лейкоплакия//

болезнь Боуэна

30.Дистрактор «Травматическая язва» - в описании жалобы на боль в заднем отделе альвеолярного гребня нижней челюсти, появилась после изготовления полного съемного протеза, при осмотре – язва, покрытая некротическим налетом, болезненная. Лимфоузлы увеличены, болезненны

31.Дистрактор «гуммозный сифилид, лечение у венеролога» - в описании дано седловидный нос, западение спинки носа, рубцовые изменения мягкого неба, отсутствует язычок, на спинке языка – кратерообразная язва

32.Тест – в задании теста найти только вторичные либо только первичные элементы поражения. В вариантах ответов могут быть перечислены первичные элементы поражения либо вторичные, либо первичные элементы вперемежку со вторичными. Надо найти ТОЛЬКО вторичные или первичные элементы. Поэтому повторите элементы поражения – какие относятся к первичным, какие к вторичным.

Пример:

Определите первичные элементы поражения слизистой оболочки полости рта://

язва, трещина, вегетация//

чешуйка, киста, папула//

бугорок, узелок, киста//

эрозия, лихенизация, волдырь//

пятно, афта, налет

33.Тест – дана картина хронического катарального гингивита, скученность зубов, отсутствие зуба в зубном ряду и др. С какого мероприятия надо начать местное лечение ? Ответ – снятие зубных отложений, коррекция гигиены полости рта. НО НЕ ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБА, НЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ!

34.Тест по травме верхнего фронтального зуба – в описании жалобы на боль в зубе, произошел отлом коронки на ½, полость зуба (пульпа) широко открылась. Аллергоанамнез не отягощен.

Тактика врача-стоматолога – какой метод лечения выбрать? – биологический, витальная ампутация, витальная экстирпация, девитальная ампутация, девитальная экстирпация? Ответ - витальная экстирпация.

35.Тест – дано описание кандидоза – жалобы на жжение, сухость полости рта, при осмотре – на щеках и др.отделах белый творожистый налет, соскабливается с обнажением гиперемированной поверхности. Надо выбрать препарат для лечения данной патологии. Ответ – флуконазол

Пример:

Пациент жалуется на жжение, сухость в полости рта, неприятные ощущения в языке, наличие белого налета на языке, появившиеся 3 дня назад после приема в течение нескольких дней внутримышечно антибиотика по поводу острого бронхита. При осмотре на фоне отечной и гиперемированной слизистой языка определяется **налет белого цвета, напоминающий творог, при поскабливании которого обнажается гиперемированный участок**. Выберите препарат для этиотропного лечения//

Ацикловир//

Флуконазол//

Преднизолон //

Амоксиклав//

Трихопол

36.Тест - дано описание КПЛ, экссудативно-гиперемической формы – на щеках в ретромоларной области определяются папулы на фоне отечной гиперемированной слизистой. Какой препарат необходимо назначить – преднизолон, ацикловир, флуконазол... Ответ – преднизолон

37.Тест – дано описание локализованного пародонтита, развившегося вследствие глубокого продвижения металлокерамических коронок на премоляры верхней челюсти 2.4, 2.5. Глубина пародонтальных карманов – 3,5 мм. Имеются зубные отложения. Вопрос – какое мероприятие этиотропного характера необходимо провести? Ответ – снятие металлокерамических коронок с зубов.

38.Тест – пародонтальный абсцесс

39.Дистрактор «складчатый язык» - дано описание наличие на спинке языка извилин, складок

Пример:

Пациент 28 лет обратился с целью профилактического осмотра. Объективно: язык мягкий, слегка увеличен, глубокие складки - **борозды на спинке и боковых поверхностях языка. Дно и боковые поверхности складок покрыты нитевидными сосочками**. О каком состоянии языка свидетельствует данное описание://

ромбовидный глоссит//

десквамативный глоссит//

складчатый язык//

глоссодиния//

черный "волосатый" язык

40.Дистрактор «эксфолиативный хейлит, экссудативная форма» - дано описание наличие чешуйко-корок на нижней губе от линии Клейна до середины красной каймы. Корки желто-коричневые фиксированы к губе, при снятии обнажается ярко-красная поверхность, СИМПТОМ ФАРТУКА!

Пример:

Пациентку 45 лет беспокоят жжение и болезненность губ, особенно при их смыкании, затрудненный прием пищи и речь. При осмотре полости рта: нижняя и верхняя губы отечны, гиперемированы, болезненны при пальпации, на красной кайме губ чешуйки серовато-желтого и корки желто-коричневого цвета, при этом поражена только часть красной каймы губ от линии Клейна до ее середины. Местами корки **свисают с губ в виде фартука**. Какому диагнозу соответствует данная клиническая картина://

акантолитическая пузырьчатка, вульгарная форма//

эксфолиативный хейлит, экссудативная форма//

красная волчанка, эрозино-язвенная форма//

простой glandулярный хейлит//

красный плоский лишай, гиперкератотическая форма

41.Дистрактор – «glandулярный хейлит» - дано описание – жалобы на увеличение губы, выделение слюны из расширенных протоков мелких слюнных желез – СИМПТОМ РОСЫ!

Пример:

У пациента 48 лет, обратившегося к врачу-стоматологу, при объективном осмотре на слизистой оболочке нижней губы в области зоны Клейна определяются расширенные выводные протоки слюнных желез с капелькой слюны (**симптом росы**). Наиболее вероятный диагноз://

актинический хейлит//

эксфолиативный хейлит//

glandулярный хейлит//

экзематозный хейлит//

метеорологический хейлит

42. Дистрактор – «ГЛАНДУЛЯРНЫЙ ХЕЙЛИТ» - дано описание – жалобы на боли, увеличение губы, выделение слюны с примесью гноя из расширенных протоков мелких слюнных желез.

43.Дистрактор «Контактный аллергический хейлит» - жалобы на болезненность губ, появившуюся после применения НОВОЙ ГУБНОЙ ПОМАДЫ

Пример:

Пациентка 38 лет предъявляет жалобы на сухость, небольшое шелушение, зуд и жжение губ. В анамнезе – 2 дня назад начала применение **ранее не использовавшейся губной помады**. Подобные симптомы отмечает впервые. Объективно: на красной кайме губ резко ограниченные эритемы, на фоне которых имеются мелкие пузырьки и мокнущие участки. Кожные покровы лица и тела без видимых изменений. Поставьте диагноз//

Эксфолиативный хейлит//

Экзематозный хейлит//

Контактный аллергический хейлит//

Атопический хейлит//

Актинический хейлит

44.Дистрактор «Ожог слизистой твердого неба» - в описании жалобы на боль в области неба, появившуюся после приема горячей пищи, при осмотре - эрозия, покрытая налетом

45.Дистрактор «Хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести»

Дополнения:

1. Механизм ремтерапии основан на ионном обмене и проницаемости эмали
2. Повторить объем микропространств в зонах кариозного пятна (в %) (см. Терапевтическая стоматология Боровский, 2004)
3. Повторить клинику быстро- и медленнопрогрессирующего кариеса, их отличительные особенности
4. Повторить эрозию твердых тканей зуба, обратить внимание на частое употребление **кислых продуктов, наличие овальной формы дефектов** на вестибулярной поверхности фронтальных зубов
5. Повторить клинику язвенного гингивита/язвенно-некротического стоматита **Венсана, какими микроорганизмами они вызываются (спирохеты и фузобактерии)**
6. Повторить клинику хронического герпетического рецидивирующего стоматита, обратить внимание на наличие **сгруппированных пузырьков (везикул)**, после вскрытия которых эрозии **полигональной формы**
7. Повторить клинику десквамативного глоссита
8. Повторить клинику клиновидного дефекта (расположение их **в пришеечной области клыков, премоляров, имеют форму треугольника или клина с плотными стенками**)
9. Повторить показания к применению композитов – в каком случае применяют макронаполненные, микронаполненные, мининаполненные, тотально выполненные?
10. Повторить компомеры (комбинация композитов и СИЦ) (в составе СИЦ всегда есть фториды, придающие **кариесстатические свойства и СИЦ, и компомерам**)
11. Выучить какие микроорганизмы относятся к **кариесогенным (Streptococcus mutans)**
12. Повторить причины системной гипоплазии (это заболевания пациента в раннем возрасте, **в период формирования и минерализации зачатков зубов, напр., рахит, инфекционные заболевания и т.д.**)
13. Повторить этиологию флюороза (токсичное действие избытка фтора в употребляемой в пищу воде, которое приводит к **дегенерации амелобластов и нарушению нормального формирования эмали** – см. Боровский Терапевтическая стоматология, 2004)
14. Повторить дифференциальную диагностику пульпитов (см. Лукиных Пульпиты)
15. Повторить показатели ЭОМ при кариесе, при остром очаговом, остром диффузном, хроническом фиброзном пульпите, хроническом гангренозном пульпите, острых и хронических формах периодонтита (см. Лукиных – Пульпит, Лукиных Верхушечный периодонтит)
16. Повторить методы лечения пульпитов – может быть дано описание какой-либо формы пульпита (острого очагового/острого диффузного, хронического фиброзного/ хронического гангренозного пульпита) с аллергоанамнезом (отягощен – имеется аллергия на местный анестетик, либо не отягощен). Необходимо выбрать метод лечения пульпита, показанный при данной форме пульпита с учетом аллергоанамнеза (см. Лукиных Пульпиты).

Второй этап – препарирование кариозной полости на жевательной поверхности 3.6 зуба и препарирование кариозной полости на контактной поверхности 2.5 зуба при отсутствии свободного доступа к полости.